ORIGEM DO DOCUMENTO:	Gerência de Farmácia		
TÍTULO:			Nº DOC:
Manual de Diluição de Medicamentos			MAN.GFARMA.005
DATA 1º VERSÃO	DATA DESTA VERSÃO	VERSÃO Nº	PRÓXIMA REVISÃO
09/10/2017	19/05/2026	02	28/02/2027

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 9

2. OBJETIVOS 9

3. ABRANGÊNCIA 9

4. COMPETÊNCIA 9

5. DESCRIÇÃO 10

MEDICAMENTOS CONTROLADOS 11

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 11

HALOPERIDOL 14

CETAMINA, CLORIDRATO 16

ETOMIDATO 17

FENTANILA, CITRATO + DROPERIDOL 19

PROPOFOL 20

TIOPENTAL, SÓDICO 22

DIAZEPAM 24

FENITOÍNA, SÓDICA 26

FENOBARBITAL, SÓDICO 28

FENTANILA, CITRATO 30

MORFINA, SULFATO 32

DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 34

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

NALBUFINA, CLORIDRATO **36**

REMIFENTANILA, CLORIDRATO **37**

TRAMADOL, CLORIDRATO **38**

NALOXONA, CLORIDRATO **40**

FLUMAZENIL **41**

PARECOXIBE **44**

MIDAZOLAM, CLORIDRATO **45**

MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS **47**

AMICACINA, SULFATO **47**

AMPICILINA, SÓDICA **49**

AMPICILINA, SÓDICA + SUBACTAM, SÓDICA **51**

AZTREONAM **52**

CEFALOTINA **54**

CEFAZOLINA, SÓDICA **56**

CEFEPIME, CLORIDRATO **57**

CEFTAZIDIMA **59**

CEFTRIAXONA, SÓDICA **61**

CIPROFLOXACINO **63**

CLARITROMICINA **65**

GENTAMICINA, SULFATO **66**

CLINDAMICINA **68**

IMIPENEM + CILASTATINA, SÓDICA **70**

LINEZOLIDA **72**

MEROPENEM, TRIIDRATADO **74**

METRONIDAZOL **75**

OXACILINA **77**

PIPERACILINA, SÓDICA + TAZOBACTAM, SÓDICO **78**

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA **80**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

VANCOMICINA, CLORIDRATO **82**

ACICLOVIR, SÓDICO **84**

ANFOTERICINA B **86**

MEDICAMENTOS DE USO GERAL **89**

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) **89**

ÁCIDO GADODÉRICO **90**

ÁCIDO TRANEXÂMICO **92**

ADRENALINA (EPINEFRINA, CLORIDRATO) **93**

ALBUMINA HUMANA **95**

AMINOFILINA **97**

AMIODARONA, CLORIDRATO **99**

ATRACÚRIO, BESILATO **102**

ATROPINA, SULFATO **104**

BICARBONATO DE SÓDIO **105**

BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA (PESADA) **108**

CLONIDINA, CLORIDRATO **109**

CLORETO DE POTÁSSIO **110**

DESLANOSÍDEO **111**

DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO **112**

DICLOFENACO SÓDICO **114**

DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO **115**

DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE **116**

DIPIRIDAMOL **117**

DIPIRONA SÓDICA **118**

DOBUTAMINA, CLORIDRATO **120**

DOPAMINA, CLORIDRATO **121**

ENOXAPARINA SÓDICA **123**

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO **125**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 127

ETILEFRINA, CLORIDRATO 128

FITOMENADIONA 129

FLUCONAZOL 130

FUROSEMIDA 132

GLICOSE 135

GLICONATO DE CÁLCIO 136

HEPARINA SÓDICA 137

HIDRALAZINA, CLORIDRATO 139

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 140

INSULINA NPH HUMANA 141

IOVERSOL 143

ISOSSORBIDA, MONONITRATO 144

LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO 145

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 146

METILPREDNISOLONA, ACETATO 149

METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO 150

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 151

METOPROLOL, TARTARATO 153

N-ACETILCISTEÍNA 154

NEOSTIGMINA, METILSULFATO 155

NITROGLICERINA 156

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 157

NORADRENALINA, BITARTATRATO (NOREPINEFRINA) 158

OMEPRAZOL 160

ONDANSETRONA, CLORIDRATO 162

PANCURÔNIO, BROMETO 163

PENTOXIFILINA 164

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

PROMETAZINA **166**

PROTAMINA **168**

ROCURÔNIO, BROMETO **169**

SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO III **171**

SALBUTAMOL **173**

SULFATO DE MAGNÉSIO **174**

SUXAMETÔNIO, CLORETO **175**

VERAPAMIL, CLORIDRATO **177**

VITAMINA B12 ..... **179**

VITAMINAS DO COMPLEXO B **180**

SUGAMADEX SÓDICO **182**

6. REFERÊNCIAS **183**

7. HISTÓRICO DE REVISÃO **183**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

LISTA DE ABREVIATURAS

mg –miligrama

mL – mililitro

mcg – Micrograma

h – hora

min – minuto

TA – Temperatura ambiente

R. – Sob refrigeração (2 a 8ºC)

ºC – Grau Celsius

IM – Intramuscular

EV – Endovenoso

SF – Soro fisiológico 0,9%

SG – Soro Glicosado 5%

SRL – Solução de Ringer Lactato

SC – Subcutâneo

ACM – a critério médico

UTI - Unidade de terapia Intensiva

AD – Água destilada para injeção

Seg. – segundos

BI – Bomba de infusão

SN – Se necessário

Folha: 200

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

1. INTRODUÇÃO

Considerando a complexidade do uso de medicamentos parenterais no ambiente hospitalar, bem como os riscos relacionados a incompatibilidades físico-químicas, erros de diluição, instabilidade das soluções, falhas de administração e eventos adversos, este material reúne informações técnicas e organizadas de forma objetiva, prática e acessível, visando subsidiar a tomada de decisão clínica e operacional no cotidiano assistencial.

As orientações aqui descritas contemplam aspectos relacionados a diluentes compatíveis, concentrações recomendadas, vias e tempos de administração, incompatibilidades, estabilidade após preparo, armazenamento, cuidados específicos de manipulação e medidas relacionadas à prevenção de eventos adversos, conforme evidências científicas, referências técnicas especializadas e normativas sanitárias vigentes.

2. OBJETIVOS

Estabelecer diretrizes técnicas padronizadas para o preparo, reconstituição e diluição de medicamentos, visando a segurança do paciente, a estabilidade farmacológica e a minimização de erros de medicação no ambiente hospitalar

3. ABRANGÊNCIA

O manual serve como instrumento de consulta e orientação para todos os colaboradores, e abrange todos os processos assistenciais que envolvem a manipulação e administração de terapias medicamentosas na instituição, garantindo um ambiente assistencial seguro e em conformidade com a legislação sanitária vigente.

4. COMPETÊNCIA

A garantia da segurança do paciente na terapia medicamentosa por via injetável é um processo interdependente, fundamentado na atuação harmônica e integrada entre a Farmácia, a Enfermagem e a Medicina, em estrita consonância com as diretrizes do Núcleo de Segurança do Paciente.

Para fins de aplicação e cumprimento deste manual, estabelecem-se as seguintes competências institucionais:

Equipe de Farmácia:

Folha: 201

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

- Compete a coordenação técnico-científica deste guia, sendo responsável pelo levantamento de evidências sobre a estabilidade físico-química dos fármacos, determinação de diluentes compatíveis, identificação de interações/incompatibilidades;
- Capacitar a assistência na manipulação e diluição segura de medicamentos;
- Orientar o uso de técnicas para garantir a assepsia no preparo;
- Revisar o manual conforme novas evidências e fichas dos fabricantes;
- Manter o documento em conformidade com a legislação sanitária atual.

Equipe de Enfermagem:

- Compete a validação prática dos fluxos assistenciais à beira do leito;
- Execução segura dos processos de reconstituição e diluição nas unidades de internação (conforme padronizado);
- Administração rigorosa quanto às vias e tempos de infusão;
- Monitoramento contínuo do paciente para a identificação precoce de eventos adversos.

Equipe Médica:

- Compete a responsabilidade pela indicação clínica, diagnóstico e prescrição precisa da terapia, cabendo-lhe avaliar as restrições hídricas, metabólicas ou hemodinâmicas do paciente, garantindo que as solicitações de diluições especiais (fora do padrão regular) estejam clinicamente justificadas e registradas em prontuário.

5. DESCRIÇÃO

Este manual foi estruturado a partir da relação de medicamentos padronizados na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCECON), organizando-os em três categorias principais de acordo com os regulamentos sanitários vigentes:

1. *Medicamentos Sujeitos a Controle Especial e de Uso Restrito, em conformidade com a Portaria MS nº 344/1998 e a RDC ANVISA nº 6/2014;*

2. *Medicamentos Antimicrobianos, alinhados às diretrizes das RDCs ANVISA nº 44/2010 e nº*

Folha: 202

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

61/2010;

***3.** Medicamentos de Uso Geral.*

Para cada fármaco listado, são apresentadas os seguintes itens:

- Nome do medicamento;
- Classe farmacêutica;
- Apresentação;
- Dose usual;
- Reconstituição;
- Vias de administração, e suas respectivas diluições, diluentes e tempo de infusão;
- Estabilidade em temperatura ambiente (TA) e sob refrigeração (R) (de 2 a 8 °C);
- Incompatibilidades;
- Interações medicamentosas relevantes;
- Observações, ou seja, características exclusivas do medicamento.

MEDICAMENTOS CONTROLADOS

Lista de medicamentos incluídos na Portaria 344/98 MS e RDC Nº6/2014

CLORPROMAZINA, CLORIDRATO		
Classe farmacológica	Antipisicótico, antiemético	
Apresentação	Ampola de 25mg/5 mL, Concentração de 5mg/mL	
Dose Usual	Adultos: 25 a 100mg Dose máxima: 400 mg a cada 4-6h	
	Crianças: 6 meses a 5 anos: dose máxima 40 mg/dia 5 a 12 anos: dose máxima 75 mg/dia	
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)	
	IM	Sim (Profundo)

Folha: 203

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Vias de administração	**EV Direto**	Sim	**Diluição padrão:**	1mg/mL
			Diluente:	SF 0,9%
			Tempo de Infusão:	Lento Adulto: 1mg/min Criança: 0,5mg/min
	EV Infusão	Sim	**Diluição padrão:**	500 – 1000mL (1mg/mL)
			Diluente:	SF 0,9%
			Tempo de Infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Descartar sobras
			R:	Descartar sobras
	Diluído		**TA:**	24h - uso único
			R:	Não se aplica

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Incompatibilidade	Aminofilina, alopurinol, ampicilina, anfotericina B, aztreonam, benzilpenicilina potássica e sódica, cefepima, cimetidina, fenobarbital, etoposídeo, furosemida, metotrexato, tiopental, piperacilina + tazobactam.
Interações medicamentosas	Relatos de interações moderadas: Biperideno, triexifenidil: ↓ dos níveis séricos. Fenitoína, fenobarbital e carbamazina: ↓ da eficácia antipsicótica. Anti-hipertensivos, epinefrina, diuréticos tiazídicos: ↑ do risco de hipotensão (inclusive ortostática). Opióides, ansiolíticos, anestésicos gerais, hipno-sedativo: ↑ da depressão do SNC. Atropina, antiparkinsoniano, anticolinérgicos, antidepressivos, tricíclicos: ↑ dos efeitos anticolinérgicos. Haloperidol, fenitoína, ácido valpróico: pode ↑ a concentração sérica destes medicamentos. Anticoagulante oral: pode ter seu efeito ↓
Eventos adversos	Sedação, convulsão em epiléptico, perturbação da regulação da temperatura corporal com febre ou hipotermia, delírio, síndrome neuroléptica maligna, estado catatônico, retenção urinária. Discinesia tardia (uso prolongado), sonolência, tonteira, vertigem, ansiedade, inquietação, sintomas extrapiramidais, fraqueza, convulsão, hipotensão, taquicardia, arritmias, palpitação, constipação, colestase, boca seca, leucocitose, leucopenia, eosinofilia, agranulocitose, plaquetopenia, icterícia (no início do tratamento), constipação, íleoadinâmico, fotossensibilidade, rash cutâneo, hiperglicemia, dor no local da administração intramuscular, distúrbios visuais, rubor facial, obstrução nasal.
Observação	Foto Na administração IM: injetar profundo e lentamente Se infiltrar no subcutâneo pode provocar necrose tecidual Contraindicação: depressão medular, psíquica e hepatopatias, coma, glaucoma de ângulo agudo. Antídoto intoxicação fenotiazínicos (com sinais de extrapiramidalismo): biperideno. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias

Folha: 205

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">HALOPERIDOL</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antipisicótico</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Ampola de 5mg/mL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos:
Dose inicial: 0,5 a 2 mg cada 4-8h Dose de manutenção: 1 a 15 mg Dose máxima: 100 mg/dia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças > 6 a 12 anos
Dose inicial: 1 a 3 mg a cada 4-8h Dose máxima: 0,15 mg/kg/dia</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição Padrão:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>Não aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
</table>

Folha: 206

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Biperideno, bupropiona, buspirona, carbamazepina, carbidopa/levodopa, cetoconazol, cilastina + imipeném, clozapina,dipirona + orfenadrina, fenitoína, fenobarbital, indometacina, isoniazida, itraconazol, metildopa, metotrexato, olanzapina, paroxetina, propranolol, rifampicina, sertralina, terbinafina, tizanidina, trazodona, Soro fisiológico 0,9% precipita quando a concentração final do haloperidol for ≥ 1 mg/ml., heparina sódica, nitroprusseto de sódio
Interações medicamentosas	Amiodarona, amitriptilina, atropina, carbonato de lítio, ciprofloxacino, claritromicina, clorpromazina, dipirona + escopalamina, escopalamina, fluconazol, fluoxetina, isoflurano, moxifloxacino, nortriptilina, octreotida, oxibutinina, prometazina, risperidona, sotalol, sulfametoxazol + trimetoprima, tamoxifeno, tioridazina, tramadol, venlafaxina.
Eventos adversos	Sintomas extrapiramidais (parkinsonismo, distonia aguda, acatisia, discenesia tardia), sedação, hipotensão, efeitos anticolinérgicos, interferência na liberação do hormônio de crescimento, aumento prolactina, secreção inapropriada do ADH, síndrome neuroléptica maligna, agranulocitose, tontura, cefaleia, visão borrada, ↑ o risco de convulsões, boca seca, constipação, náusea, vômito, diarreia, sialorreia, dispepsia, colestase, hepatotoxicidade, hipotensão, taquicardia, prolongamento do QT, torsade alergia, broncoespasmo, laringoespasmo, retenção urinária, priapismo, galactorreia, ginecomastia, disfunção sexual, anemia, leucopenia ou leucocitose, linfomocoitose, hiponatremia, hipomagnesemia.
Observação	Monitoramento contínuo do eletrocardiograma deve ser feito para prolongamento do intervalo QT e arritmias cardíacas sérias, se o haloperidol for administrado por via endovenosa. Administrar com cautela em pacientes com insuficiência hepática. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias.

Folha: 207

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">CETAMINA, CLORIDRATO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Anestésico geral</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Frasco ampola contendo 500mg/10mL, concentração de 50mg/mL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos:
Dose usual: 1 a 4,5 mg/kg Por
via IM: 6,5 a 13mg/kg
Infusão continua: 2 a 7 mcg/kg/min
Dose máxima: EV- 4,5 mg/kg; IM- 13 mg/kg</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças:
Dose usual: 9 a 13 mg/kg IM Por
via EV: 0,5 a 1 mg/kg/dose Infusão
contínua: 20 mcg/kg/min
Dose máxima: EV- 1mg/kg/dose; IM- 13 mg/kg/dose</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (Solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>ACM (50 mg/mL)</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>0,5 mg/kg/min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição Padrão:</td><td>250 mL (2 mg/mL)</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SG 5%</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>Contínua</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Barbitúricos como fenobarbital</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="4">Diazepam</td></tr>
</table>

Folha: 208

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Hipertensão, taquicardia, hipotensão, bradicardia, arritmias, depressão miocárdica paradoxal, movimento tônico-clônico, tremor, alucinação, elevação da pressão intracraniana, alucinações visuais e auditivas, disforia, eritema transiente, rash, nistagmo, diplopia, pesadelos, elevação de pressão intraocular, náusea, vômito, hipersalivação, depressão respiratória, laringoespasmo (raro), supressão do reflexo da tosse (possível), apneia, tolerância.
Observação	Existe incompatibilidade química entre os barbitúricos e a dextrocetamina ocorrendo formação de precipitado. Não devem, portanto, ser injetados juntos, na mesma seringa. A ação de dextrocetamina é potencializada pelo diazepam. Os dois medicamentos devem ser administrados separadamente. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias.

ETOMIDATO				
Classe farmacológica	Anestésico hipnótico			
Apresentação	Ampola de 20mg/10mL, concentração 2mg/mL			
Dose Usual	Adultos: 0,2 a 0,3 mg/kg lenta. Idosos: usar com cautela, não ultrapassando dose de adultos.			
	Crianças acima de 10 anos: 0,2 a 0,6 mg/kg/dose (não mais que 5mg/min) a cada 15 a 30 min.			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV Direto	Sim	**Diluição padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de Infusão:	30 a 60 segundos
	EV infusão	Não	**Diluição Padrão:**	Não se aplica

Folha: 209

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de Infusão:	Não se aplica
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Descartar sobras
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ciclosporina, varfarina.			
Interações medicamentosas	Carbamazepina, carboplatina, cetoconazol, ciprofloxacino, cisplatina, doxorrubicina, fenitoína, fenobarbital, ganciclovir, ofloxacino,			
Eventos adversos	Taquicardia e hipertensão acentuada (podem ser impedidaspela pré-medicaçãoanalgésica), hipotensão (infusão prolongada), náusea e vômito (pós-operatório), oligúria (infusão prolongada), dor (pode ser reduzida com injeção rápida em veiade grande calibre ou pré-medicação com analgésico, como fentanila ou petidina), movimentos musculares espontâneos (durante a indução; cessam rapidamente), apnéia transitória (geralmente me idosos), supressão reversível da função adrenocortical, distúrbios eletrolíticos que respondem aos corticoides (infusão prolongada).			
Observação	Antes da indução, instalar uma perfusão para eventual manutenção da volemia. Limitar ao máximo a utilização de outros medicamentos hipotensores. Pode acusar náuseas e vômitos. Deve ser usado somente em crianças maiores de 10 anos. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

<table>
<tr><th colspan="5">FENTANILA, CITRATO + DROPERIDOL</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Anestésico, analgésico, antipsicótico</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Soluçã injetável de 0,0785mg/mL + droperidol 2,5mg/mL, Ampola com 2 mL</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dose Usual</td><td colspan="4">Adulto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pré Anestesia IM: 0,5-2 mL, 4560 minutos antes da cirurgia.</td><td colspan="2">Complemento Anestesia
EV direto (lento): 1 mL/10-12 kg
EV infusão: 10mL/250mL de SG 5%, até o inicio da sonolência. Nesse momento podese diminuir ou supender para administração do anestésico geral.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Procedimento diagnóstico IM: 0,25/10kg , 4560 minutos antes do procedimento</td><td colspan="2">Complemento de anestesia regional IM,
EV direto (lento): 1-2 mL</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças (Acima de 2 anos)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pré Anestesia
IM: 0,5-2 mL, 45-60 minutos antes da cirurgia.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (solução pronta par uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>Lento</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição Padrão:</td><td>10mL/250mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SG 5%</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>-</td></tr>
</table>

Folha: 211

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Alopurinol, anfotericina B, barbitúricos, fluouracila, furosemida, heparina, ácido folínico, pemetrexede, piperaciclina + tazobactam, Ampicilina, amicacina, bicarbonato, cefalosporina, ciclosporina, cimetidina, complexo B, dexametasona, difenidramina, dobutamina, hidralazina, hidrocortisona, insulina, isoproterenol, meperidina, morfina, midazolam, ondansetrona, sulfametoxazol+ trimetroprima, tobramicina, vancomicina, ácido ascórbico.
Interações medicamentosas	Potencialização imprevisisível e intensa de inibidores da MAO pelos analgésicos narcóticos. Efeitos adtivo ou potencializadores com depressores do sistema nervoso central (ex.: barbituricosm tranqüilizantes, outros barcóticos ou agentes anestésicos gerais).
Eventos adversos	Hipotensão, prurido, hiperglicemia, hemólise, rigidez muscular, visão turva, sedação pós-operatória, apnéia, depressão respiratória, tontura, calafrio, alucinação.
Observação	Não indicado para manunenção de anestesia para evitar o acumulo de droperidol. Lista A1: Lista das substâncias Entorpecentes – Sujeita a Notificação de Receita “A”

PROPOFOL		
Classe farmacológica	Anestésico	
Apresentação	Emulsão injetável de 10mg/mL, seringa preenchida com 50 mL Emulsão injetável de 10mg/mL, frasco com 20 mL	
Dose Usual	**Adultos (**Dose máxima: 6-12mg/kg/hora)	
	Indução de anestesia EV direto ou infusão: 1,5-2,5mg/kg, administrar aproximadamente 40mg a cada 10 segundos até o início da anestesia	*Manutenção de anestesia* EV infusão contínua: 4 a 12mg/kg/h EV direto repetido (*em bólus)* Aumentos de 25 mg (2,5mL) a 50mg (5 mL) ACM
	Sedação na UTI EV infusão contínua: 0,3 a 4mg/kg/h	*Sedação consciente* EV direto: 0,5 a 1mg/kg por 1 a 5 minutos. Manutenção com infusão de 1,5-4,5mg/kg/h. .

Folha: 212

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">Crianças (Dose máxima: 7,5-18 mg/kg/hora) Não recomendado para menores de 3 anoS</td></tr>
<tr><td colspan="5">Indução de anestesia
Acima de 8 anos
EV direto lentamente: 2,5mg/kg
De 3 a 8 anos
Necessidade pode ser maior</td><td colspan="2">Manutenção de anestesia
EV infusão contínua:
9-15mg/kg/h</td></tr>
<tr><td colspan="5">Sedação na UTI
Não recomendado</td><td colspan="2">Sedação consciente
Não recomendado</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="7">Não se aplica (solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="6">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td colspan="3">Diluição padrão:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">Diluente:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tempo de infusão:</td><td colspan="2">Lento</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td colspan="3">Diluição padrão:</td><td colspan="2">Até 2mg/mL</td></tr>
<tr><td colspan="3">Diluente:</td><td colspan="2">SG5%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tempo de infusão:</td><td colspan="2">ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Recontituído</td><td>TA:</td><td colspan="4">Sobras devem ser descartadas</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td colspan="4">6 horas</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="7">Anfotericina B, atracúrio, cisatracúrio, ciclosporina, cloreto de cálcio, doxrrubicina, metoclopramida, mitoxantrona, ciprofloxacino, verapamil, diazepam, digoxina, levofloxacino, metotrexato, metilprednisolona, amicacina, gentamicina, tobramicina, fenilefrina, vancomicina, fenitoína, remifentanila.</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="7">Álcool e outros fármacos que produzem depressão do SNC podem aumentar os efeitos depressores do SNC, depressores respiratórios ou hipotensivos.
Propofol pode ↑ os efeitos de: midazolam, ropivacaína. Os efeitos do propofol podem ser por: alfentanil, inibidores da CYP2B6, midazolam.</td></tr>
</table>

Folha: 213

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Apneia, bradicardia, hipotensão, hipertensão, mioclonia perioperatória, movimentos musculares involuntários temporários, náusea, vômito, cólicas abdominais, tosse, tontura, febre, rubor, soluços, tosse, trombose, flebite, dor, ardência ou ferroada no local da injeção, depressão cardiovascular, depressão respiratória (com dose excessiva), rabdomiólise, acidose metabólica, hipercalemia, rash, prurido.
Observação	**ATENÇÃO**: A apresentação em seringa preenchida não necessida de diluição, pois se encontra pronta para uso. Propofol na apresentação em seringa preenchida pode ser administrado por infusão alvo controlada somente com o sistema TCI DIPRIFUSOR, incorporando software específico. Para reduzir a dor da injeção inicial, adicionar lidocaína 0,5% ou 1% sem conservante (200mg de propofol para 20mg de lidocaína). Técnica asséptica rigorosa no preparo. Filtros com menos de 5µm não devem ser usados com emulsão de propofol. Não utilizar se houver separação de fases na emulsão. Não congelar Agitar antes do uso Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias

TIOPENTAL, SÓDICO				
Classe farmacológica	Anestésico barbitúrico de curta duração			
Apresentação	Pó liofilizado 1 g			
Dose Usual	**Adulto:** De 0,5 a 1g Dose máxima: 1g **Crianças:** 3-5 mg/kg/dose (indicado para intubação em hipertensão intracraniana)			
Reconstituição	Sim, de 2 – 2,5%			
Vias de administração	**EV direto**	Sim	**Diluição padrão:**	1g p/ 40mL (2,5%)

Folha: 214

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Diluente:	AD, SF 0,9%
			Tempo de infusão:	2-10 minutos
	EV Infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	-
			R:	24h
	Diluído		TA:	-
			R:	-
Incompatibilidade	SRL, Normosol, benzilpenicilina, atracúrio, norepinefrina, pancurônio, vecurônio, succinilcolina, alfentanila, cimetidina, clorpromazina, difenidramina, diltiazem, dobutamina, dopamina, epinefrina, fenilefrina, hidromorfona, lidocaína, labetalol, petidina, midazolam, prometazina, tiamina, dimenidrato, droperidol, clindamicina, furosemida, injeção de ácido ascórbico, insulina regular, pantoprazol, amicacina, atropina.			
Interações medicamentosas	Quetiapina, cloranfenicol, ciclosporina, droperidol, etoposideo, hidrato de cloral, hidroxizina, cetorolaco, lamotrigina, meperidina, fenitoína, primidona, ácido valpróico, varfarina, zolpidem. ↑ efeito: benzodiazepínicos, analgésicos opióides, amilorida, atenolol, clorpromazina, enalapril, furosemida e hidroclorotiazida			
Eventos adversos	Bradicardia, hipotensão (grave), anafilaxia, necrose no local do extravasamento (se houver), depressão respiratória e cardíaca, redução do débito cardíaco, laringoespasmo, broncoespasmo, apneia, síncope, ansiedade, sonolência, confusão, alucinações, ataxia, tosse, soluço, rubor, rash, urticária, edema de face, reação alérgica, tromboflebite, hipotermia, diminuição do débito urinário.			

Folha: 215

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Injeção rápida pode causar distúrbios cardíacos. Contraindicação: porfiria Lista B1: Lista de substâncias Psicotrópicas – Sujeita a Notificação de Receita “B”

DIAZEPAM				
Classe farmacológica	Ansiolítico			
Apresentação	Ampola de 10mg/2mL, Concentração de 5mg/mL			
Dose Usual	Adultos: 5 a 10mg Dose máxima 30mg/dia			
	Crianças > 5 anos: 0,2 – 0,5mg/kg/dose (não mais que 5mg/min) cada 2-5min Crianças > 5 anos: 1 mg cada 2 a 5 min (não mais que 10 mg) Dose máxima: 10 mg/dia crianças acima de 10kg			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de Infusão:	3-5 mg/min
	EV infusão	Sim (não recomendado*)	**Diluição Padrão:**	0,1mg/kg/h
			Diluente:	SF, SG5%
			Tempo de Infusão:	
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	4h
			R:	Não se aplica

Folha: 216

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Paracetamol, aciclovir, amiracina, aminofilina, anfotericina B, ampicilina, ácido ascórbico, atenolol, atracúrio, atropina, bivalirudina, cloreto de cálcio, gluconato de cálcio, carboplatina, cafazolina, cefmetazol, cefoperazona, diltazem, esmolol, ácido fólico, fluconazol, dopamina, fenoldopam, gencitabina, gancoclovir, hidrocortisona, hidroxizine, ciplastina, cimetidina, vecurônio, verapamil, vancomicina, fenobarbital, lidocaína.
Interações medicamentosas	Para administração EV, não misturam ou diluir Diazepam com outras soluções ou drogas, na seringa ou frasco de infusão. A injeção intravenosa deve ser feita lentamente, não administrar mais rápido do que 5 mg / min. Não injetar em veias de pequeno porte. Evitar a administração intra-arterial ou extravasamento Monitorar a respiração de 5 a 15 minutos por 2 horas Na administração rápida, pode ocorre, depressão respiratória, hipotensão e bradicardia.
Eventos adversos	Arritmia cardíaca, síndrome compartimental, hipotensão, bradicardia, tromboflebite, vasculite, vasodilatação, rash, anafilaxia, acidose, hipertermia, constipação, diarreia, salivação excessiva, xerostomia, neutropenia, trombocitopenia, hepatotoxicidade, amnésia, ataxia, confusão, sonolência, vertigem, cefaleia, tremor, inquietação paradoxal, taquipneia, apneia, laringo-espasmo, diplopia, ototoxicidade, pode ocorrer necrose tecidual se houver extravasamento, dependência física e psicologia com uso prolongado
Observação	Para administração EV, não misturam ou diluir Diazepam com outras soluções ou drogas, na seringa ou frasco de infusão. Injeção intravenosa deve ser feita lentamente, não administrar mais rápido do que 5 mg / min. Não injetar em veias de pequeno porte. Evitar a administração intra-arterial ou extravasamento Monitorar a respiração de 5 a 15 minutos por 2 horas Na administração rápida, pode ocorre, depressão respiratória, hipotensão e bradicardia. * Pode ocorre absorção de 22-55% em bolsas e seringas de PVC. Lista B1: Lista de substâncias Psicotrópicas – Sujeita a Notificação de Receita “B”

Folha: 217

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

FENITOÍNA, SÓDICA

Classe farmacológica	Anticonvulsivante			
Apresentação	Ampola, 250/ 5 mL, em concentração de50 mg/mL			
Dose Usual	Adultos: 125 a 500 mg, EV/IM, em uma hora, nunca exceder 250 mg 2m 15 min. Dose máxima: 1000 mg/dia			
	Crianças: 2,0 -2,5 EV, nunca repetir a dose antes de 15 min Dose de máxima: 15 mg/kg/dia			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV Direto	Sim	**Diluição padrão:**	Até 250mg/20 mL
			Diluente:	SF
			Tempo de Infusão:	5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição Padrão:**	1 a 10mg/mL
			Diluente:	SF
			Tempo de Infusão:	Neonatos: não exceder 0,5mg/kg/min Crianças > 1 mês: não exceder de 1 a 3mg/kg/min Adultos: 50mg/min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	1h
			R:	Não se aplica

Folha: 218

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	SG 5%, SRL, anfotericina B, aminofilina, benzilpenicilina, norepinefrina, ceftazidima, ciprofloxacino, cefepime, difenidramina, fentanila, cloreto de potássio, debutamina, fenilefrina, lidocaída, petidina, prometazina, vancomicina, dimenidrinato, fitomenadinona, fenobarbital, linezolida, nitroglicerina, propofol, amicacina, gentamicina, morfina, teofilina.
Interações medicamentosas	Aciclovir, ácido acetilsalicílico, albendazol, alopurinol, amiodarona, amitriptilina, anlodipino, atorvastatina, atracúrio, azitromicina, betametasona, bupropiona, carbamazepina, carbidopa/levodopa, carbonato de lítio, carboplatina, cefriaxona, cimetidina, ciprofloxacino, cisplatina, claritromicina, clomipramina, clonazepam, cloranfenicol, clorpromazina, clozapina, deflazacorte, fenobarbital, diazepam, digoxina, diltiazem.
Eventos adversos	Hipotensão e choque (se injeção rápida), arritmia, taquicardia, vasodilatação, hipertricose, rash, dermatite esfoliativa, prurido, perda de peso, hiperplasia gengival, náusea, constipação, alteração cor urina (rosa, vermelho ou marrom), vômito, agranulocitose, anemia aplástica, leucopenia, anemia megaloblástica, polineuropatia, trombocitopenia, hepatite medicamentosa, hipocalcemia, dor nas costas, osteomalácia, dor pélvica, diplopia, nistagmo, zumbido, anorexia, ataxia, agitação, edema cerebral, coma, tontura, sonolência, disartria, discenesia, cefaleia, nervosismo, fraqueza, reações extra-piramidais, hipersensibilidade (Síndrome de Stevens-Johnson, febre, linfadenopatia), hiperglicemia, alterações metabolismo da vitamina D e K, hirsutismo, acne, flebite.
Observação	Não administrar via SC. Após injeção EV, lavar com SF 0,9%, para minimizar irritação. Pode ocorrer precipitação sob refrigeração e, após a diluição surge coloração amarelo clara, que não indica redução de potência. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias

Folha: 219

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

FENOBARBITAL, SÓDICO	
Classe farmacológica	Anticonvulsivante

Apresentação	Ampola 200 mg/ 2 mL, concentração de 100mg/mL			
Dose Usual	Dose Usual: Adultos: 100 a 320 mg/dia EV Dose máxima: 600 mg/dia EV			
	Crianças:10- 20 mg/kg Dose de manutenção: 5 mg/kg Dose máxima: 40 mg/kg			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV Direto	Sim	**Diluição padrão:**	30-130 mg/mL
			Diluente:	SF, SG 5%
			Tempo de Infusão:	Crianças: 30mg/min Adultos: 60mg/min
	EV infusão	Não	**Diluição Padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de Infusão:	Não se aplica
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Descartar sobras
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Anfotericina B, atracúrio, norepinefrina, pancurônio, succinil colina, clorpromazina, difenidramina, hidralzina, petidina, prometazina, vancomicina, ranitidina, fenitoína, clindamicina, insulina regular, hidrocortizona, epinefrina, ondansentrona, midazolam, dobutamina, amicacina, complexo B, dexametasona, cefalosporinas.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Interações medicamentosas	Podem ↓ a concentração de: vitaminas D, K, C, B12, folato e cálcio. ↓ do metabolismo do fenobarbital (risco de intoxicação) e da sedação: ácido valpróico, inibidores da MAO, cloranfenicol, Fenobarbital ↓ a concentração sérica: lamaotrigina, ritonavir, saquinavir, varfarina, contraceptivos orais, cloranfenicol, griseofulvina, doxiciclina, beta-bloqueadores, teofilina, corticóide, etoposídeo, doxorrubicina, vincristina, metotrexato, antidepressivos ticiclicos, aloperidol, fenotiazinas. Ciclosfofamida: ↑ o risco de hemotoxicidade. Paracetamol: ↑ o risco de huepatotoxicidade. Depressão de SNC aditiva: anti-histamínico, opióide e outro sedativo.
Eventos adversos	Hipotensão, fotossensibilidade, rash, urticária, constipação, diarreia, náusea, vômito, flebite, artralgia, mialgia, neuralgia, depressão respiratória, laringo e broncoespasmo, depressão, sonolência, vertigem, hipotensão, osteoporose, síncope, incoordenação motora, alucinação, ansiedade, nervosismo, irritabilidade, eczema esfoliativa, SSJ, necrose epidérmica tóxica, agrunolocitose, anemia megaloblástica, trombocitopenia, tromboflebite, dano hepático, osteopenia e raquitismo, colapso circulatório, excitamento paradoxal, deficiência na memória, redução da atenção, ataxia, erupções na pele, hepatite medicamentosa, dependência física e psicológica, osteomalácia, hipocalcemia, hiperatividade
Observação	As crianças submetidas a tratamento por tempo prolongado devem receber um tratamento profilático do raquitismo. Antes da administração, salinizar o acesso quando em infusão anterior com SG. Cautela na disfunção hepática ou renal. Pode causar depressão respiratória, vasodilatação, queda da pressão arterial, apnéia e laringoespasmo se administrado rapidamente. Não administrar via SC. Administrar via EV em velocidade que não exceda 60mg/min. A solução bastante alcalina (pH 9,2-10) e pode causar dano tecidual. Recomenda-se acesso facilitado a equipamentos de ressuscitarão e ventilação artificial. Lista B1: Lista das substâncias Psicotrópicas – Sujeita a Notificação de Receita “B”.

Folha: 221

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">FENTANILA, CITRATO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Analgésico opióide</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Soluçã injetável de 0,05mg/mL, ampola com 10mL e com 2mL
- sem conservante</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pré anestesia
IM: 0,05 mg a 0,1mg - 30 a 60min antes da cirurgia</td><td colspan="2">Anestésico geral
EV: 0,05 mg a 0,1mg/kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">No pós-operatório
IM: 0,05 mg A 0,1mg</td><td colspan="2" rowspan="2">Componente de Anestesia geral
EV:Dose baixa: 0,002 mg/kg
Dose moderada: 0,002 a 0,02mg/kg (respiração controlada)

Manutenção: 0,025 a 0,1 mg/kg (EV ou IM)
Dose elevada: 0,02 a 0,05mg/kg
Manutenção: 0,025 a 0,1 mg</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anestésico regional
ESPINHAL: 0,0015 mg/kg
Complemento: 0,05mg a 0,1mg (IM ou EV lento)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças: de 2 a 12 anos</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (solução pronta par uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td>ESPINHAL</td><td colspan="3">ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>Lento</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição Padrão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF 0,9%, SG 5%</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>50-100mcg/h ou ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>24 h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
</table>

Folha: 222

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Azitromicina, bicarbonato de sódio, fenitoína, fenobarbital, fluoruracila, diazepam, tiopental.
Interações medicamentosas	Baixa dos efeitos de fentanila: inibidores de protease, bloqueadores de cálcio de cálcio, β-bloqueadores adrenérgicos, macrolídeos, benzodiazepínicos, barbitúricos, fenotiazinas. Benzodiazepínicos e óxido nitroso: > risco de depressão cardiovascular. Relaxantes musculares: podem aumentar a depressão respiratória; Antagonistas dos opiódes: podem precipitar crise de abstinência ao opióide; Inibidores de IMAO: pode causar excitação ou depressão do SNC. Sibutramina: aumenta o risco de síndrome serotoninérgica. Ritonavir: potencialização dos efeitos da fentanila e ↓ do metabolismo hepático
Eventos adversos	Edema periférico, bradicardia, diaforese, rigidez torácica e músculo-esquelético, convulsão, taquicardia, bradicardia, hipertensão, desidratação, perda de peso, dor abdominal, constipação, distensão abdominal, miose, diarreia, perda de apetite, náusea, vômito, reação no local da aplicação, dores nas costas, rigidez muscular, astenia, confusão, vertigem, enxaqueca, sedação, fadiga, insônia, retenção urinária, broncoespasmo e hipersecreção brônquica, apneia, depressão respiratória, dispneia, neutropenia, risco de abstinência e dependência, aumento da pressão intracraniana
Observação	Fentanila pode sofrer perda por adsorção pelo PVC quando em solução alcalinas. Evitar contato com a pele e inalação de partículas de citrato de fentanila. Injeção muito rápida pode causar rigidez torácica e muscular c/ insuficiência respiratória grave de difícil tratamento (curarizar com pancurônio e utilizar naloxona). Antídoto: naloxona (avaliar necessidade de infusão contínua de naloxona). Deve ser suspenso 24h antes da extubação, pois induz apnéia. Lista A1: Lista das substâncias Entorpecentes – Sujeita a Notificação de Receita “A”

Folha: 223

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

MORFINA, SULFATO

Classe farmacológica	Analgésico opióide			
Apresentação	Solução injetável 0,2mg/mL (sem conservante) Solução injetável 10mg/mL			
Dose Usual	**Adultos**			
	I.M: Dose inicial: 5-20 mg/70kg de peso I.V.: Dose inicial: 2-10 mg/70kg de peso SC (*off label):* Dose inicial: 0,2-10mg PERIDURAL (apenas com solução sem conservante) Dose inicial: 5 mg na região lombar INTRATECAL (apenas com solução sem conservante) Dose inicial: 0,2-1 mg			
	Crianças A segurança e eficácia da morfina em pacientes pediátricos ainda não foram definitivamente estabelecidas. Os benefícios devem ser considerados em relação aos riscos.			
	IM, IV: 0,1-0,2mg/kg a acada 3-4horas se necessário. Infusão IV: 10-60mcg/kg/hora.			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1-2mg/mL Diluir até 10 mL
			Diluente:	AD, SF, SG5%
			Tempo de infusão:	4-5 minutos
	EV Infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 mg/ml
			Diluente:	AD, SRL, SF, SG5%
			Tempo de infusão:	15 a 30 min, 0,1 - 1 mg/mL
	SC (*off label)*	Sim	**Diluição padrão:**	10mg/mL, ampola de 1 mL em 1 mL de diluente
			Diluente:	A.D.
Estabilidade (apenas a ampola de	**Recontituído**		TA:	-
			R:	-
			TA:	24h na seringa ou bolsa

Folha: 224

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

10mg/mL)	**Diluído**	R:	7 dias, deve ser utilizado em até 48 horas
Incompatibilidade	Anfotericina B, Azitromicina, petidina, fenobarbital, fenitoína, fluouracila, doxorrubicina, heparina, aminofilina.		

Interações medicamentosas	Depressores SNC: potencializa o efeito dos depressores SNC. Neurolépticos: maior risco de depressão respiratória. Ciclosporina: possível ↑ do risco de anormalidades e mau funcionamento do sistema neurológico. Rifampicina: possível perda da eficácia da morfina
Eventos adversos	Edema periférico, prurido, urticária, sudorese, náusea, vômito, boca seca, constipação, diarreia, espasmo no trato biliar, depressão circulatória, hiperemia conjuntival, vasodilatação (efeito histamínico), miose, parada cardíaca, rubor facial, colapso da circulação periférica, síncope, bradicardia, hipotensão ortostática, taquicardia, ambliopatia (distúrbios visuais), retenção urinária, efeito antidiurético, apneia, laringoespasmo, broncoespasmo, anorexia, tontura, sedação, euforia, delírio, insônia, agitação, ansiedade, medo, alucinação, depressão, sonolência, letargia, desorientação, coma, mudança de humor, fraqueza, cefaleia, convulsão (RN), dependência física e psicológica, aumento da pressão intracraniana.
Observação	Na infusão contínua: - lactentes/crianças: iniciar com 20 mg. Evitar Injeção rápida: pode causar depressão respiratória, apneia, hipotensão, reação anafilactóide, colapso circulatório periférico. Antídoto: naloxona Lista A1: Lista de substâncias Entorpecentes – Sujeita a Notificação de Receita “A

Folha: 225

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO	
Classe farmacológica	Sedativo, Agonista Alfa-2 Adrenérgico
Apresentação	Solução injetável de 200 mcg/ 2mL
Dose Usual	**Adultos** Sedação em UTI: Dose de ataque: 1,0 mcg/kg por 10 minutos, seguida por uma infusão de manutenção que pode variar de 0,2 a 0,7 mcg/kg/h. Sedação em procedimentos: Dose de ataque: 1 mcg/kg (ou 0.5 mcg/kg para procedimentos menos invasivos, como oftálmicos) por 10 minutos, seguida por uma infusão de manutenção de 0.6 mcg/kg/h, titulando o efeito desejado; intervalo usual: 0,2 a 1 mcg/kg/h. Craniotomia acordada (*off-label*): Dose de ataque: 0,5 a 1 mcg/kg por 10 a 20 minutos, seguida por uma infusão de manutenção de 0,5 mcg/kg/h, titulando o efeito desejado; intervalo usual: 0,1 a 0,7 mcg/kg/h.
	Crianças A segurança e a eficácia do cloridrato de dexmedetomidina em pacientes menores de 18 anos não foram estudadas. Para neonatos (dados limitados disponíveis): Sedação em UTI: dose de ataque (opcional): 0,1 a 0,5 mg/kg/dose por 10 a 20 minutos. A administração da dose de ataque depende da utilização concomitante de sedativos e do nível desejado de sedação. Dose de manutenção: inicialmente 0,1 a 0,3 mcg/kg/h, podendo ser aumentada de acordo com o nível de sedação desejado. Dose máxima: 1,5 mcg/kg/h. Para lactentes, crianças e adolescentes (dados limitados disponíveis): Sedação em ITU: dose de ataque (opcional): 0,5 a 1 mcg/kg/dose por 10 minutos. A administração da dose de ataque depende da utilização concomitante de sedativos e do nível desejado de sedação. Dose de manutenção: inicialmente 0,2 a 0,5 mcg/kg/h, podendo ser ajustada de acordo com o nível desejado. Sedação, anestesia, procedimentos não-invasivos: dose de ataque: 0,5 a 2 mcg/kg/dose por 10 minutos, podendo ser repetido se a sedação não for adequada. Dose de manutenção: 0,5 a 1 mcg/kg/h. Sedação, pré-anestésico (crianças e adolescentes): dados muito limitados disponíveis em pacientes > 9 anos: Intranasal: 1 a 2 mcg/kg como dose única 30 a 60 minutos antes da indução da anestesia. Doses mais elevadas (2 mcg/kg) são recomendadas para crianças mais velhas (≥ 5 anos) e adolescentes. **Ajuste de dose** Insuficiência hepática: não há ajustes de doses específicos, no entanto, é importante considerar a redução da dose para

Folha: 226

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">hepatopatas, uma vez que a metabolização da dexmedetomidina é principalmente pelo fígado.

Insuficiência renal: nenhum ajuste de dose é necessário para pacientes nefropatas, a farmacocinética não apresentou diferença significativa em pacientes com injúria renal severa (ClCr < 30 mL/minuto.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">EV Bomba de Infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição Padrão:</td><td>Diluir cada 2 mL do medicamento em 48 mL (qsp 50mL).</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF 0,9%</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td>Intranasal</td><td colspan="3">Apenas para pacientes pediátricos. Pode ser administrado sem diluição (100 mcg/mL) ou diluído em 1 ou 1,5 mL. Administrar metade da dose recomendada em cada narina, goteando lentamente na mucosa nasal.</td></tr>
<tr><td>Estabilidade</td><td colspan="2">Diluído</td><td>R.</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Não deve ser coadministrado através do mesmo cateter intravenoso com sangue ou plasma porque a compatibilidade física não foi estabelecida.
Incompatível com anfotericina B e diazepam.</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="4">Anestésicos, sedativos, hipnóticos e opioides: A coadministração com anestésicos, sedativos, hipnóticos e opioides está suscetível ao aumento de efeitos (sevoflurano, isoflurano, propofol, alfentanila e midazolam. Nenhuma interação farmacocinética foi evidenciada entre cloridrato de dexmedetomidina e isoflurano, propofol, alfentanila e midazolam. Entretanto, devido a possíveis interações farmacodinâmicas, quando coadministrado com cloridrato de dexmedetomidina, a redução na dose de cloridrato de dexmedetomidina ou do sedativo, hipnótico, opioide ou anestésico concomitante pode ser necessária.
Bloqueadores neuromusculares: Em um estudo de 10 voluntários sadios, a administração de cloridrato de dexmedetomidina por 45 minutos na concentração plasmática de 1 ng/mL não resultou em aumento clinicamente significativo da magnitude do bloqueio neuromuscular associado com a administração de rocurônio.
Medicamentos com Atividades Cardiovasculares: A possibilidade de efeitos hipotensores e bradicárdicos aumentados deve ser considerada em pacientes recebendo outros medicamentos que causem estes efeitos, por exemplo betabloqueadores, embora os efeitos adicionais em um estudo de interação com esmolol tenham sido modestos.</td></tr>
</table>

Folha: 227

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	hipotensão, hipertensão, bradicardia, febre, vômitos, hipoxemia, taquicardia, anemia, boca seca e náusea.
Observação	Lista C: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial

NALBUFINA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Analgésico opióide			
Apresentação	Solução injetável de 10mg/mL			
Dose Usual	**Adultos** 10mg (SC, IM, EV), ajustada conforme a severidade da dor Dose máxima: Em dose única – 20mg. Dose total diária: 160mg			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV Direto	Sim	**Diluição Padrão:**	1 ampola para 9mL de diluente
			Diluente:	SF 0,9%
			Tempo de Infusão:	10-15 min
	EV Infusão	Sim	**Diluição Padrão:**	1 ampola em 100mL de diluente
			Diluente:	SF 0,9%
			Tempo de Infusão:	ACM
	SC	Sim		
Estabilidade	**Reconstituído**		**T.A.**	Descartar sobras
			R.	Não se aplica
	Diluído		**T.A.**	24h
			R.	Não se aplica
Incompatibilidade	Naficilina, cetorolaco.			
Interações medicamentosas	Efeitos aditivos com outros anlagésicos opiódes, anestésicos gerais, fenazotiazinas ou outros tranqüilizantes, sedativos, hipnóticos, ou outros depressores do sistema nervoso central.			

Folha: 228

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Sedação, sudores, náusea /vômito, tontura/vertigem ; boca seca, cefaléia.
Observação	As vias preferenciais são IM e SC. Pode causar: náusea, vômito, boca seca, miose, apnéia, hipotensão, taquicardia entre outros. Ajuste da dose em pacientes com insuficiência renal e hepática. Lista A2: Lista de outras substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais – Sujeita a Notificação de receita “A”

REMIFENTANILA, CLORIDRATO					
Classe farmacológica	Analgésico opióide				
Apresentação	Frasco ampola com 2mg de pó liófilo para solução injetável				
Dose Usual	**ACM**				
Reconstituição	1mg para 1mL de água destilada para injeção				
Vias de administração	**IM**	Não			
	EV Direto (*bolus*)	Sim	**Diluição Padrão:**		50mcg/ml (adulto) 20-25mcg/mL (crianças menores que 1 anos
			Diluente:		AD
			Tempo de Infusão:		Até 1mcg/kg □ de 30 a 60 seg. Acima 1mcg/kg □ acima de 60 seg.
	EV Infusão	Não	**Diluição Padrão:**		50mcg/ml (adulto) 20-25mcg/mL (crianças menores que 1 anos)
			Diluente:		AD, SF 0,9%, SG 5%
			Tempo de infusão:		ACM
Estabilidade	**Reconstituído**			**T.A.**	24h
				R.	Não se palica
				T.A.	24h

Folha: 229

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	Diluído	**R.**	Não se aplica
Incompatibilidade	Ringer Lactato, propofol		
Interações medicamentosas	Benzodiazepínicos, barbitúricos, relaxantes musculares, dantroleno, droperidol, suc- cinilcolina, duiréticos tiazídicos, zolpidem.		

Eventos adversos	Náusea, vômito, rigidez músculo-esquelético, depressão respiratória, apneia, hipóxia, brocoespasmos, edema pulmonar, calafrios pós-operatório, hipotensão, bradicardia, constipação, taquicardia, hipertensão, assistolia, arritmia, síncope, febre, alucinação, amnésia, prurido, rash cutâneo, pode causar hiperglicemia, desconforto abdominal, trombocitopenia, anemia, leucocitose, linfopenia, reação anafilática, sedação
Observação	Pode causar: hipotensão, bradicardia, rigidez muscular e de-pressão respiratória severa. Lista A1: Lista de substâncias Entorpecentes – Sujeita a Notificação de Receita “A”

TRAMADOL, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Analgésico opióide			
Apresentação	Solução injetável 100mg/2mL, concentração de 50mg/mL			
Dose Usual	**Adulto** Acima de 16 anos de idade			
	50-100mg a cada 6h Dose máxima: 400mg/dia (dose acima desse valor, ACM)			
	Crianças			
	1 a 2 mg/kg/dosea cada 8h			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	2 minutos (1mL/min)

Folha: 230

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV Infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,5-4 mg/mL
			Diluente:	SF 0,9%, SG 0,5%
			Tempo de infusão:	30 minutos

Estabilidade	**Reconstituído**	TA:	-
		R:	-
	Diluído	TA:	24 h
		R:	14 dias
Incompatibilidade	Aciclovir, clindamicina, diazepam, indometacina, rifampicina.		
Interações medicamentosas	*Varfarina:* pode aumentar o RNI (referente ao coagulograma). *Tramadol ↑ os efeitos de:* depressores SNC, álcool, inibidores da MAO, inibidores da recaptação da serotonina.		
Eventos adversos	Náusea, vômito, boca seca, sonolência, hipotensão, sudorese, mínima depressão respiratória central com doses habituais, vasodilatação, bradicardia, palpitação, tontura, cefaleia, ansiedade, agitação, convulsão, labilidade emocional, desordens do sono, febre, rash, SSJ, necrólise epidérmica tóxica, obstipação, dor abdominal, sangramento gastrointestinal, prurido, trombocitopenia, falência hepática, colelítiase, vasodilatação, espasticidade, distúrbios de coordenação, miose, distúrbio visual, aumento da creatinina sérica, broncoespasmo, tosse, dispneia, anafilaxia, reação anafilactóide, depressão respiratória, retenção/ frequência urinária, tolerância.		

Folha: 231

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Antídoto: naloxona Pouco potencial de depedência. Paciente com restrição hídrica: diluir em 20 mL. Monitorar FC e PA devido ao risco de depressão respiratória. Usar com cautela em pacientes em uso de inibidores da monoaminoxidase, em pacientes idosos, com insuficiência renal e hepática. A estabilidade da solução é de 14 dias quando a diluição ocorreu em condições assépticas controladas e validadas. Lista A2: Lista de substâncias Entorpecentes de uso permitido somentes em concentrações especiais – Sujeita a Notificação de Receita “A”

NALOXONA, CLORIDRATO

<table>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antagonista Opióide</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Soluçã injetável 0,4mg/mL, ampola com 1 mL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Dose Usual</td><td colspan="4">Adulto</td></tr>
<tr><td colspan="2">Reversão de depressão pósoperatória por opióide:
0,04-0,4mg até reversão dos sintomas.
Dose máxima: 0,8mg</td><td colspan="2">Superdosagem de opiódes:
0,4-2mg, repetida a cada 2-3 minutos.

Dose máxima 10mg</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças</td></tr>
<tr><td colspan="2">Reversão de depressão pósoperatória por opióide:
Crianças e adolescentes
0,001-0,015mg/kg/dose

Dose máxima 2mg</td><td colspan="2">Superdosagem de opiódes:
<5 anos ou ≤ 20 kg
0,1mg/kg/dose, até reversão dos sintomas, repetir a cada 2- 3 minutos.
>5 anos ou ≥ 20 kg
2mg
Dose máxima 10mg</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1ampola (0,4 mg/mL) para 9ml de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>2-3min (diluído)
30 segundos (sem diluir)</td></tr>
</table>

Folha: 232

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV Infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 ampola (0,4 mg/mL) 100mL
			Diluente:	SF, SG5%
			Tempo de infusão:	Contínua
Estabilidade	**Recontituído**		TA:	Descartar Sobras
			R:	Não se aplica
	Diluído		TA:	24h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Não misturar com soluções alcalinas, heparina, linezolida, propofol.			
Interações medicamentosas	Clonidina: pode resultar em hipertensão.			

Eventos adversos	Náusea, vômito, sudorese, nervosismo, inquietação, irritabilidade, crise aguda de abstinência em pacientes com uso crônico de opiáceos (náusea, vômito, taquicardia, hipertensão, hipotensão, taquipneia, aumento dos ruídos intestinais, piloereção, midríase) hepatoxicidade, hipertensão, hipotensão, arritmia ventricular, parada cardíaca, fibrilação atrial, edema pulmonar.
Observação	IM: não recomendada, absorção errática Pela via endotraqueal: diluir até 1 – 2 mL com SF. Monitorar sinais vitais. Pode causar: náuseas, vômito, agitação. Utilizar com cautela em pacientes cardiopatas. Em overdose de opiódes de longa duração, pode haver o risco de recorrência de depressão respiratória, observar o paciente até que não haja risco razoável de depressão. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias.

FLUMAZENIL	
Classe farmacológica	Antídoto benzodiazepínico
Apresentação	Ampola de 0,5mg/5mL

Folha: 233

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td rowspan="2">Dose Usual</td><td colspan="2"><u>Reversão Anestesia</u> Adultos:
Dose inicial: 0,2 mg IV em 15s
Doses subsequentes: 0,1 mg em 60 segundos
Dose total: 1 mg</td><td colspan="3"><u>Reversão Anestesia</u> Crianças > 1 ano
Dose inicial: 0,01 mg/kg (até 0,2 mg) IV 15s
Dose máxima: 0,05 mg/kg, ou 1 mg</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Intoxicação benzodiazepínicos:</u> Dose usual: 0,3 mg IV Dose total: 2 mg Infusão: 0,1 a 0,4 mg/h</td><td colspan="3"><u>Intoxicação benzodiazepínicos:</u> Crianças > 1 ano
Dose inicial: 0,01 mg/kg (até 0,2 mg)
Dose máxima: 0,05 mg/kg, ou 1 mg</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="5">Não se aplica (solução pronta par uso).</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="4">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV Direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td colspan="2">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td colspan="2">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td colspan="2">15 - 30 s</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição Padrão:</td><td colspan="2">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td colspan="2">SF, SG5%, Ringer lactato</td></tr>
<tr><td>Tempo de Infusão:</td><td colspan="2">0,1 – 0,4 mg/h</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td colspan="2">Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="2">Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td colspan="2">24 h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="2">Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="5">-</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="5">Alprazolam, amitriptilina, bromazepam, clomipramina, clonazepam, cloxazolam, diazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, nortriptilina, zolpidem.</td></tr>
</table>

Folha: 234

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Arritmias cardíacas, taquicardia, dor no peito, convulsões generalizadas (especialmente em pacientes epiléticos, usuários crônicos de benzodiazepínicos e com sinais de intoxicação por antidepressivos cíclicos), náusea, vômito, sensação de frio, cefaleia, agitação, euforia, ansiedade, visão borrada, arritmias, bradicardia, hipertensão, fadiga, hipotensão, tontura, sedação, dor no local da injeção, visão borrada, ondas de calor, boca seca.
Observação	Flumazenil não deve ser administrado antes do desaparecimento do efeito miorrelaxante periférico, quando usado no final de anestesia cirúrgica. Em alguns casos foram relatadas ocorrências de náuseae/ou vômitosdurante o uso em anestesiologia. Nenhuma alteração de função hepáticaou renalfoi observada. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias

Folha: 235

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

PARECOXIBE

Classe farmacológica	Antinflamatório			
Apresentação	Frasco-ampola 40mg.			
Dose Usual	Adultos ≥ 18 anos: 40mg IM / EV, seguido por 20 –40mg a cada 6 – 12h. Dose máxima diária: 80mg. Não exceder 5 dias de tratamento.			
Reconstituição	2ml de SF ou SG 5%.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV Direto	Sim	**Diluição Padrão:**	2ml
			Diluente:	SF, SG 5%.
			Tempo de Infusão:	Bolus
	EV Infusão	Não	**Diluição Padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
Estabilidade	**Reconstituído**		**T.A.**	24h (protegido da luz)
			R.	Não se aplica
	Diluído		**T.A.**	Não se aplica
			R.	Não se aplica
Incompatibilidade	Ringer lactato.			
Interações medicamentosas	Desvenlafaxina, Venlafaxina, Duloxetina, Citalopram, Escitalopram, Fluoxetina, Paroxetina, Sertralina			
Eventos adversos	Aumento do risco de eventos adversos cardiovasculares e trombóticos; hemorragia (perda excessiva de sangue), ulceração (erosão da parede do estômago ou intestino) ou perfuração do trato gastrointestinal superior; hipotensão severa; retenção de líquidos e edema.			
Observação	Deve ser usado com restrição em cardiopatas. Não é recomendado reconstituir em AD. Proteger da luz. Não refrigerar. Lavar a via do equipo antes da administração. Em pacientes com insuficiência hepática, a dose inicial recomendada é de 20mg e a dose máxima é de 40mg. Pode causar: náuseas, vômito, dor abdominal, constipação, prurido, cefaleia, tontura, febre. Lista C1: Lista de outras substâncias sujeitas a controle especial – Sujeita a Receita de Controle Especial em duas vias.			

Folha: 236

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

MIDAZOLAM, CLORIDRATO

Classe farmacológica	Benzodiazepínico		
Apresentação	Solução injetável 5mg/5mL, concentração de 1mg/mL Solução injetável 15mg/3mL, concentração de 5mg/mL Solução injetável 50mg/10mL, concentração de 5mg/mL		
Dose Usual	**Adultos**		
	Indicação	Até 60 anos	A partir de 60 anos
	Sedação consciente	IV: Dose inicial:2-2,5mg Dose total 3,57,5mg	IV: Dose inicial:0,5-1mg Dose total < 3,5
	Pré anestesia	IV: 1-2mg IM: 0,07-0,1mg/kg	IV: Dose inicial:0,5mg IM: 0,025-0,05mg/kg
	Indução anestésica	IV: 0,2mg/kg (0,20,35mg/kg sem pré- anestesia)	IV: 0,05-0,15mg/kg (0,15-0,2mg/kg sem pré-anestesia)
	Sedação em combinação com anestesia	IV: Doses intermitentes de 0,03-0,1mg/kg ou infusão contínua de 0,030,1mg/kg/h	IV: Doses menores qye as recomendadas para adultos < 60 anos
	Sedação em UTI	Dose Inicial: 0,03-0,3 em incrementos de 12,5mg Dose de manutenção: 0,03-0,2mg/kg/h	
	Crianças		
	Sedação consciente	I.V. 6 meses-5 anos: Dose inicial:0,05-0,1mg/kg. Dose total: < 6mg 6-12 anos: Dose inicial: 0,025- 0,05mg/kg. Dose total: < 10mg 13- 16 anos: como adultos I.M. 1-15 anos: 0,05-0,15mg/kg	
	Pré anestesia	I.M 1-5 anos: 0,08-0,2mg/kg	
	Indução anestésica	Não indicado para crianças.	
	Sedação em combinação com anestesia	Não indicado para crianças.	

Folha: 237

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	Sedação em UTI		I.V. Neonatos <32 semanas: 0,03mg/kg/h Neonatos >32 semanas – 6 meses: 0,06mg/kg/h Maior de 6 meses: dose inicial: 0,050,2mg/kg. Dose de manutenção: 0,06- 0,12mg/kg/h	
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim	Profunda	
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	Amp. 5mg/5mL: sem diluição Ampola de 15mg/3mL: diluir até 15mL
			Diluente:	SF 0,9%, SG 5%
			Tempo de infusão:	2 -5 minutos
	EV Infusão	Sim	**Diluição padrão:**	15mg/ 100 até 1000mL
			Diluente:	SF 0,9%, SG 5%
			Tempo de infusão:	Uso contínuo
Estabilidade	**Reconstituído:**		**TA:**	-
			R:	-
	Diluído:		**TA:**	Uso imediato e descartar sobras
			R:	24 horas
Incompatibilidade	SRL, bicarbonato de sódio, albumina, ampicilina, anfotericina B, ceftazidima, cefepime, clonidina, dobutamina, ranitidina, dimenidrato, imipenem+cilastatina, metotrexato, hidrocortisona, tiopental, sufatoxazol+trimetoprima.			
Interações medicamentosas	Cimetidina, diazepam, fenobarbital, fentanila, midazolam, moclobemida, petidina, selegilina, alprazolam, bromazepam, carisoprodol, clobazam, clonazepam, clordiazepóxido, codeína, dantroleno, flunitrazepam, hidrato de cloral, linezolida, lorazepam, midazolam, rasagilina, clorpromazina, ciclosporina, gabapentina, metformina, esmolol, rifampicina.			
Eventos adversos	Confusão, euforia, alucinação, hiperatividade, agressividade, sedação prolongada, redução da atenção, tontura, cefaléia, hipotensão, bradicardia, náusea, vômito, constipação, dor no local da injeção.			

Folha: 238

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Sensível à luz Antídoto: Flumazenil. Lista B1: Lista de substâncias Psicotrópicas – Sujeita a Notificação de Receita “B”

MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS

Lista de medicamentos incluídos na RDC 44/2010 e 61/2010

AMICACINA, SULFATO				
Classe farmacológica	Antimicrobiano aminoglicosídeo semi sintético			
Apresentação	Solução injetável de 250mg/mL, ampola com 2mL			
Dose Usual	Adulto e Crianças: 15mg/kg/dia, a cada 8 a 12 horas			
Reconstituição	Não – Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de infusão:	Não se aplica
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	2,5-5mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12 horas
			R:	24 horas

Folha: 239

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Ampicilina, anfotericina B, azitromicina, cefazolina, clorotiazida, fenitoína, heparina, pantoprazol, propofol, tiopental, cefalotina, cefoperazona, ceftazidima, cefuroxima, dantroleno, diazepam, folinato de cálcio, ganciclovir, indometacina, nitrofurantoína, penicilinas, cefalosporinas, alopurinol, cloreto de potássio, sulfametoxazol+trimetoprima, dexametasona, vitaminas do complexo B, ácido ascóbico tiopental, aminofilina.
Interações medicamentosas	Furosemida: potencializa a ototoxicidade. Anfotericina B, cefalosporinas, vancomicina, aciclovir, AIES, ciclosporina, enflurano, metoxiflurano: ↑ a nefrotoxicidade. Indometacina: pode ↑ a concentração sérica de amicacina. Penicilinas: provocam inativação da amicacina. Anestésicos e bloqueadores neuromusculares: risco de apneia e paralisia respiratória. Cisplatina: ↑ nefro e ototoxicidade.

Eventos adversos	Nefrotoxicidade (menos frequente em dose única diária), hipotensão, ototoxicidade, febre, cefaleia, anemia, leucopenia, bloqueio neuromuscular, anafilaxia e exantema, eosinofilia, angioedema, hipomagnesemia, dermatite esfoliativa e estomatite, zumbido, vertigem, letargia, necrose hepática, hepato e/ ou esplenomegalia, perda de peso, fibrose pulmonar.
Observação	Tempo de infusão para lactentes é de 1-2 horas. A concentração final não deve exceder 10 mg/ml. Necessário fazer ajuste de acordo com o clearance de creatinina. É dialisável.

Folha: 240

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

AMPICILINA, SÓDICA	
Classe farmacológica	Penicilina semisintética – Antibiótico β-lactâmico
Apresentação	Pó para solução injetável 1g.
Dose Usual	**Adulto**
	Vias respiratórias – 250 – 500mg a cada 6horas Trato gastrointestinal – 500mg a cada 6 ou 8 horas Vias geniturinárias – 500mg a 1000mg, cada 6 ou 8 horas Meningite bacteriana – 10 a 14g/ dia, dividida em doses iguais a cada 4horas
	Crianças
	Vias respiratórias –25-50mg/kg/dia em doses iguais a cada 6 ou 8 horas. Trato gastrointestinal –50-100mg/kg/dia em doses iguais a cada 6 ou 8 horas. Vias geniturinárias –50-100mg/kg/dia em doses iguais a cada 6 a 8 horas. Meningite bacteriana –150 a 200mg/kg/dia, em doses iguais a cada 3 a 4 horas.
Reconstituição	Sim

Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto (Não recomendado para pacientes pediátricos)	Sim	**Diluição padrão:**	125-500mg / 5mL 1g / 7,4mL 2g / 14,8mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	Até 500mg – 3 a 5 min Doses maiores – 10 a 15 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	Até 30mg/mL
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	1h
			R:	4h
	Diluído		**TA:**	Em SF: 8h
			R:	-

Folha: 241

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Bicarbonato de sódio, Glicose 5%, Glicose 10%, Glicose 5% em cloreto de sódio 0,45 e 0,9%, anfotericina B, clorpromazina, dopamina, epinefrina, hidralazina, lincomicina, metoclopramida, midazolam, ondansentrona, fluconazol, lansoprazol, amicacina, gentamicina, vinorelbina.
Interações medicamentosas	Alopurinol: pode ↑ a possibilidade de rash cutâneo. Dissulfiram e probenecida: podem ↑ os níveis séricos da ampicilina. Contraceptivos orais: pode ↓ a efetividade do contraceptivo Aminoglicosídeos: administrar 1h antes ou depois. Outras interações com: Bupropiona, clortetraciclina, doxiciclina, tetraciclinas, varfarina.

Eventos adversos	Náuseas, vômitos, diarreia, prurido, irritação gastrointestinal, febre, eritema cutâneo, reações anafiláticas, convulsão (se aplicação EV e rápida), colite pseudomembranosa por Clostridium difficile, bolhas ou descamação da pele, edema de face, garganta e lábios, sibilos ou dificuldade respiratória, prurido vaginal, leucorreia, doença do soro.
Observação	Contraindicado para pacientes alérgicos a penicilina. Aconselhável o uso de outros métodos anticoncepcionais durante o uso da ampicilina. Administrar 1h antes ou depois de outros antibióticos.

Folha: 242

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

AMPICILINA, SÓDICA + SUBACTAM, SÓDICA				
Classe farmacológica	Penicilina semisintética – Antibiótico β-lactâmico + inibidor de βlactamase			
Apresentação	Pó para solução injetável 2g +1g			
Dose Usual	**Adulto**			
	1,5g a 3 g (Ampicilina 2g + subactam 1g) a cada 6 horas			
Reconstituição	Sim (3g em 6,4mL de AD)			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto (Não indicado para pacientes pediátricos)	Sim	**Diluição padrão:**	1,5g em 3,4ml de AD ou 3g em 6,4ml de AD
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	10 – 15 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	3-45mg/mL (2 a 30mg de ampicilina, 1 a 15mg de sulbactam)
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	1h em AD
			R:	-
	Diluído		TA:	8h (em SF) – Administração deve ser finalizada dentro de 8h
			R:	-
Incompatibilidade	Glicose 5%, Glicose 5% em cloreto de sódio 0,45 e 0,9%, anfotericina B, amiodarona, idarrubicina, ondansetrona, lansoprazol.			

Folha: 243

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Alopurinol: pode ↑ o risco de *rash* cutâneo. Contraceptivos orais: eficácia pode ser diminuída. Anticoagulantes: pode produzir alteração na agregação plaquetária e nos testes de coagulação. Medicamentos bacteriostáticos (cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas, tetraciclina: interferem no efeito bactericida das penicilinas). Metotrexato: ↑ a toxicidade do metotrexato. Probenecida: prolonga o tempo de ação da ampicilina + sulbactam e ↑ risco de toxicidade.

Eventos adversos	Dor no peito, reações alérgicas, SSJ, diarreia, colite pseudomembranosa, náuseas e vômitos são os mais comuns, febre, candidíase, choque anafilático, ↑ das transaminases, anemia, trombocitopenia, eosinofilia, leucopenia, flebite, disúria, hematúria, dispneia, sibilos, vertigem, edema de face.
Observação	Deve-se garantir a dissipação da espuma após a reconstituição. Terapia combinada com aminoglicosídeos deve ser administrada em horários diferentes. É dialisável (HD/DP) Necessário fazer ajuste de acordo com o clearance de creatinina. Não usar o produto: alergia a penicilinas, a cefalosporinas ou ao sulbactam.

AZTREONAM	
Classe farmacológica	Antibiótico β – lactâmico monocíclico (monobactâmico)
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g

Folha: 244

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td rowspan="4">Dose Usual</td><td colspan="4">Adulto</td></tr>
<tr><td colspan="4">1g a 2g, a cada 8 ou 12 horas.
Minigite bactéria e sepse: até 8g/dia divididos em doses iguais a cada 6 ou 8h</td></tr>
<tr><td colspan="4">Crianças</td></tr>
<tr><td colspan="4">Acima de 9 meses - 30mg por kg a cada 6 ou 8 horas. Dose máxima: 120 mg/kg/dia</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim - Diluir 1g em 3mL de AD</td></tr>
<tr><td>EV direto</td><td>Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1g em 6-10mL</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Diluente:</td><td>AD</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>3-5 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">EV infusão</td><td rowspan="4">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>Até 20mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>60 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td rowspan="2" colspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>48h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>7 dias</td></tr>
<tr><td rowspan="2" colspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>4h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>7 dias</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Aciclovir, Anfotericina B, Azitromicina, Clorpromazina, Daunorrubicina, Mitoxantrona, Ganciclovir, Lansoprazol, Lorazepam, Metronidazol, Mitomicina, Nafticilina.</td></tr>
</table>

Folha: 245

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Cefoxitina, imipenem: induz a produção de β-lactamase. Probenecida e furosemida: ↑ os níveis séricos de aztreonam. Aminoglicosídeos: agem sinergicamente

CEFALOTINA				
Classe farmacológica	Cefalosporina de primeira geração - Antibiótico β – lactâmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g			
Dose Usual	Adultos: 4 a 12g por dia. Lactentes e crianças: 80 a 160mg/kg/dia em tomadas divididas, cada 4 a 6 horas.			
Reconstituição	Sim			
Vias de administração	**IM**	Sim (Não recomendado por ser muito dolorido)		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1g em 9,8mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	3 - 5min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	Até 20mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	30 – 60min
	Reconstituído		TA:	12h
			R:	4 dias

Folha: 246

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Diluído**	TA:	12h
		R:	24h
Incompatibilidade	Amicacina, amiodarona, atracúrio, bicarbonato de sódio, cefalosporinas, cimetidina, cloranfenicol, fluconazol, gentamicina, gluconato de cálcio, prometazina.		
Interações medicamentosas	Aminoglicosídeos: ↑ da incidência de nefrotoxicidade. Probenecida: ↑ das concentrações séricas de cefalotina, podendo aumentar o risco de toxicidade. Anticoagulantes: ↑ risco de sangramento.		

Eventos adversos	Hipersensibilidade (exantema maculopapular, urticária, febre, eosinofilia, broncoespasmo, anafilaxia). Tromboflebites, teste de Coombs positivo, náusea, vômito, dispepsia, inflamação na boca ou língua, dor epigástrica, prurido vaginal, colite pseudomembranosa, cefaleia, diarreia, necrose tubular renal e nefrite intersticial (raros), aumento das transaminases, risco de superinfecção (candida, pseudomonas, enterococos).

Folha: 247

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Um ligeiro escurecimento da cor quando diluído e mantido sob as condições adequadas, não afeta a potencia do medicamento.

CEFAZOLINA, SÓDICA				
Classe farmacológica	Cefalosporina de primeira geração - Antibiótico β – lactâmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g			
Dose Usual	**Adulto:** 250 a 500mg a cada 8h a12h. **Crianças:** 25 a 50 mg/kg/dia em 3 ou 4 tomadas (dose máxima: não exceder 100 mg/kg).			
Reconstituição	Sim -Diluir 1g em 2,5ml de AD			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1g para 5 a 10mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	3 – 5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	10-20mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	24h
			R:	10 dias
	Diluído		TA:	24h
			R:	-
Incompatibilidade	Idarrubicina, ácido ascórbico, amicacina, bleomicina, barbitúricos, eritromicina, gluconato de cálcio, amiodarona, atracúrio, cloranfenicol, estreptomicina, fluconazol, gentamicina, prometazina, anfotericina B, pemetrexede, vinorelbina.			
Interações medicamentosas	Aminoglicosídeos, diuréticos de alça e drogas nefrotóxicas: função renal deve ser monitorada; Anticoagulantes: maior risco de sangramento (recomenda-se diminuir a dose). Usar com cautela			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Eventos adversos	Hipersensibilidade, tromboflebite, nefrotoxicidade, aumento transitório das transaminases, icterícia, hepatite, candidíase, diarreia severa, crise convulsiva, vômito, perda de apetite e dor epigástrica, cefaleia, alterações hematológicas, dor abdominal, colite pseudomembranosa, dispepsia
Observação	Pode haver formação de cristais quando mandido sob refrigeração. Dose máxima: 6g. Ajuste para função renal

CEFEPIME, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Cefalosporina de quarta geração - Antibiótico β – lactâmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g e 2 g			
Dose Usual	Adultos: Até 2g a cada 8 -12h Dose máx: 6g/dia Crianças: 50 mg/kg a cada 8-12h Infecções mais graves: 100-150mg/kg/dia Dose máx: 6g/dia			
Reconstituição	Sim - Diluir 1g em 2mL de AD			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1g em 9mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-40 mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	24h
			R:	3 dias
			TA:	24h

Folha: 249

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	Diluído	R:	-
Incompatibilidade	Aminoglicosídeos, metronidazol, netilmecina		
Interações medicamentosas	Aminoglicosídeos, diuréticos de alça e drogas nefrotóxicas: monitorar função renal. Anticoagulantes: maior risco de sangramento (recomenda- se diminuir a dose).		
Eventos adversos	Reações alérgicas (urticária, edema de face ou mão, prurido, febre), cefaleia, tosse, dispneia, alterações gastrintestinais, modificações no paladar, confusão mental, candidíase oral, vaginite, visão turva, ↑ transitório das transaminases, uso prolongado pode levar a colite pseudomembranosa e à superinfecção, encefalopatia, taquicardia. Paciente com história de anafilaxia à penicilina não deve utilizar cefepime. Pode ocorrer encefalopatia em pacientes com insuficiência renal, alteração da frequência ou volume urinário.		
Observação	Dose máxima: 6 g/dia. Necessário ajuste para função renal. Dialisável: HD		

Folha: 250

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

CEFTAZIDIMA				
Classe farmacológica	Cefalosporina de terceira geração - Antibiótico β – lactâmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g			
Dose Usual	Adultos: Até 2g a cada 8 – 12h Cianças: 0-4 semanas: 30mg/kg a cada 12h 1 mês – 12 anos: 30-50mg/kg a cada 8h Dose máx: 6g/dia			
Reconstituição	Sim			
Vias de administração	**IM**	Sim - Diluir 1g em 3mL de AD		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1g em 10mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-40mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	15-30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	24h
			R:	-
	Diluído		**TA:**	24h
			R:	-

Folha: 251

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Acetilcisteína, Anfotericina B, Azitromicina, amiodarona, idarrubicina, midazolam, fenitoína, doxorrubicina, eritromicina, lansoprazol, pantoprazol, pemetrexede, varfarina,Bicarbonato de sódio, aminoglicosídeos, vancomicina, ranitidina, filgrastima.
Interações medicamentosas	Aminoglicosídeos, diuréticos de alça e drogas nefrotóxicas: monitorar a função renal. Drogas bacteriostáticas: possível interferência com a ação bacteriostática da cefotaxima. Probenecida: aumento dos níveis da ceftazidima. Soluções que contêm bicarbonato: recomenda-se evitar o uso concomitante
Eventos adversos	Irritante, infiltração pode provocar necrose tecidual; flebite, infiltração, icterícia, dispneia, alterações hematológicas, cefaleia, sinais de alergia (rash, prurido, febre), colite pseudomembranosa, alterações gastrintestinais, aumento de ureia e creatinina, ↑ transaminases, colestase, candidíase, creatinina, coma, teste de Coombs positivo, mioclonia.
Observação	Há formação de dióxido de carbono durante a dissolução, mas este é eliminado em 1-2 min.

Folha: 252

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

CEFTRIAXONA, SÓDICA				
Classe farmacológica	Cefalosporina de terceira geração - Antibiótico β – lactâmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 1 g			
Dose Usual	Adultos: 1 – 2 g a cada 12 ou 24h Dose máx: 4g/dia Crianças: 50-75mg/kg/dia Dose máx: 2g/dia			
Reconstituição	Sim			
Vias de administração	**IM**	Sim – Diluir 1g em 2,1 mL de AD		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1g em 9,6mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	10-40mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	24h
			R:	-
	Diluído		TA:	24h
			R:	-

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Incompatibilidade	Aminofilina, anfotericina B, azitromicina, filgrastim, fluconazol, clindamicina, vonorelbina, soluções de cálcio, hidantoína, dobutamina, vancomicina, metronidazol (fisicamente e quimicamente incompatível)
Interações medicamentosas	Aminoglicosídeos, diuréticos de alça e drogas nefrotóxicas: monitorar a função renal. Drogas bacteriostáticas: possível interferência com a ação bacteriostática da cefotaxima. Probenecida: ↑ dos níveis séricos de ceftriaxona.
Eventos adversos	Náusea, vômito, colelitíase, colecistite, irritante, pode provocar flebite, infiltração provoca icterícia, necrose tecidual, alterações hematológicas, eosinofilia, distúrbios de coagulação, cefaleia, sinais de alergia (rash, prurido, febre), choque anafilático, colite pseudomembranosa, alterações gastrintestinais, ↑ das transaminases e bilirrubina, dispneia, necrose tubular aguda, nefrite intersticial (rara), vertigem, calafrios, vaginites, ↑ dos níveis séricos de creatinina.
Observação	Soluções variam de amarelo claro a âmbar Infusão EV intermitente é a via preferencial. Uso prolongado resulta em super infecção. Cada grama contém 3,6 mEq de sódio. Contraindicado em icterícia neonatal. Via IM muito dolorosa sem anestésico.

Folha: 254

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">CIPROFLOXACINO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Agente antibacteriano Quinolônico sintético</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Bolsa de sistema fechado de 2mg/mL, bolsa com 100mL (concentração final = 200mg)</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos: EV 200 a 400mg duas vezes ao dia. Para infecções mais graves: 400mg até 3x ao dia.

Crianças: 10 mg/Kg, duas vezes por dia. Não se deve exceder o teto máximo de 400mg por dose (dose diária máxima: 800mg). Para infecções mais graves: 400mg até 3x ao dia.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica (Solução pronta para uso)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>60 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Descartar sobras</td></tr>
</table>

Folha: 255

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Aminofilina, ampicilina, anfotericina B, azotrimicina, cefuroxima, cefepime, metronidazol, fenitoína, clindamicina, dexametasona, furosemida, heparina, pantoprazol, pemetrexede, propofol, hidrocortisona, metilprednisolona, varfarina.
Interações medicamentosas	Probenecida: Interfere na excreção renal da ciprofloxacino; tizanidina: Aumento da concentração sérica da tizanidina; teofilina: aumento da concentração sérica da teofilina; fenitoína: alteração da concentração sérica da fenitoína; metotrexato: aumenta níveis plasmáticos de metotrexato; antagonistas da vitamina K: aumenta efeitos anticoagulantes; antidiabéticos orais: hipoglicemia; sildenafila: aumento da biodisponibilidade de sildenafila.
Eventos adversos	Náusea, vômito, reação no local da injeção, aumento de TGO/TGP, rush cutâneo, trombocitopenia, plaquetose confusão e desorientação, alucinações, parestesia, vertigem, vasodilatação, insuficiência renal, depressão da medula óssea, vasculite, pancreatite, ruptura de tendão.
Observação	Monitorar função renal, incluindo pH urinário e acidez, se necessário, para prevenir cristalúria. Os pacientes devem ser mantidos bem hidratados. Fotossensível. O envelope aluminizado deve ser retirado somente no momento do uso. Não refrigerar, pode ocorrer precipitação que redissolve à temperatura ambiente

Folha: 256

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="6">CLARITROMICINA</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="5">Macrolídeo</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="5">Pó para solução injetável de 500mg</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="5">1g dividida em duas vezes ao dia.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="5">Reconstituir em 10mL de AD</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="4">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>4-10mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>60 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td colspan="2">Até o fim da infusão</td></tr>
<tr><td>R:</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="5">Soro fisiológico na reconstituição inicial.
Nenhum outro medicamento deve ser acrescentado à solução diluída devido ao risco de precipitação da claritromicina.</td></tr>
</table>

Folha: 257

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Alprazolam, astemizol, carbamazepina, cilostazol, cisaprida, ciclosporina, disopiramida, lovastatina, metilprednisolona, midazolam, omeprazol, pimozida, quinidina, rifabutina, sildenafil, sinvastatina, terfenadina, triazolam, tacrolimus e vimblastina, fenitoína, teofilina e valproato, lovastatina e sinvastatina (induz a rabdomiólise).
Eventos adversos	Inflamação, sensibilidade, flebite e dor no local da injeção. Alteração do paladar, cefaléia, elevação transitória de enzimas hepáticas, reações alérgicas (desde urticária e erupções cutâneas leves até anafilaxia), síndrome de Stevens-Johnson, tontura, vertigens, ansiedade, insônia, pesadelos, zumbidos, confusão, desorientação, alucinação, psicose e despersonalização, perda auditiva, prolongamento de intervalos QT, flatulência, constipação, alterações da audição e dispnéia, insônia e boca seca.
Observação	A reconstituição inicial deve ser feita com AD e não pode ser feita com SF ou solução salina. Após a reconstituição inicial com AD pode ser diluído com SF ou SG ou SRL. Não há dose segura estabelecida para crianças por via intravenosa

GENTAMICINA, SULFATO	
Classe farmacológica	Antimicrobiano aminoglicosídeo
Apresentação	Solução injetável de 40mg/mL, ampola com 2 mL
Dose Usual	Adultos 3-5mg/Kg/dia, dividida em doses iguais a cada 8-6 horas Crianças (acima de 1 ano) 5-7,5mg/Kg/dia, dividida em doses iguais a cada 8-12 horas

Folha: 258

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>0,4-1,6mg/mL, ou seja, diluir em 50-200mL de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>30-120 minutos</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>24 horas</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>10 dias</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Ampicilina, anfotericina B, azitromicina, cefepima, idarrubicina, heparina, pantoprazol, pemetrexede, propofol, varfarina, penicilinas, alopurinol sódico, indometacina, aminofilina, bicarbonato de sódio, cefalotina, cefazolina, cefotaxima, cefoxitina, ceftazidima, ceftriaxona, cimetidina, clindamicina, dopamina, furosemida, lidocaína.</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="4">Anfotericina B, magnésio, cefalosporinas e penicilinas: neutralização do efeito.
Diuréticos: ototoxicidade. vancomicina, cisplatina, indometacina, Anestésicos: paralisia respiratória.
Drogas nefrotóxicas: aumento da nefrotoxicidade.</td></tr>
</table>

Folha: 259

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Nefrotoxicidade, ototoxicidade, ↑ da creatinina (reversível), oligúria, proteinúria, febre, hipotensão, taquicardia, cefaleia, hipocalcemia, miastenia grave, vertigem, zumbido, tontura, dificuldade urinaria, rash, prurido, eritema, náusea, vômitos, anorexia, granulocitopenia, trombocitopenia, eosinofilia, tromboflebite, bloqueio neuromuscular, tremor, neurite óptica, lacrimejamento, hiperemia ocular, hipomagnesemia, paralisia muscular, superinfecção (febre, infecção respiratória superior, prurido ou descarga vaginal, mal-estar, diarreia).
O**bservação**	Intervalo de uma hora na administração com outros medicamentos, principalmente penicilinas. Não recomendado a recém-nascidos. Cautela em pacientes com disfunção renal. Ajuste para função renal. Dialisável: HD

CLINDAMICINA				
Classe farmacológica	Agente antimicrobiano do grupo das lincosaminas			
Apresentação	Solução injetável de 150mg/ml. Ampola com 4mL, concentração final de 600mg			
Dose Usual	Adultos 300 a 600mg a cada 6 horas Dose máxima até 4.800mg/dia Crianças 10-40mg/kg/dia divididas a cada 8 a 6 horas			
Reconstituição	Não se aplica (Solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	Até 18mg/mL

Folha: 260

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Diluente:	SF, SRL ou SG
			Tempo de infusão:	30mg/min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	-
			R:	-
	Diluído		TA:	24h
			R:	-
Incompatibilidade	Aminofilina, azitromicina, fenobarbital, ceftriaxona, ciprofloxacino, idarrubicina, fenitoína filgtrastim, gluconato de cálcio, pantoprazol, ranitidina, fluconazol, ampicilina, ácido ascórbico, eritromicina, sulfato de magnésio, ciprofloxacino, tobramicina, midazolam, vitaminas do complexo B, anfotericina B.			
Interações medicamentosas	Eritromicina e cloranfenicol: pode ocorrer o antagonismo. Bloqueadores neuromusculares: potencializam o efeito deste medicamento, favorecendo o efeito de apnéia ou paralisia respiratória. Gentamicina e metronidazol: aumentam o efeito da clindamicina.			

Folha: 261

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Urticária, edema de face ou mãos, edema ou formigamento na boca ou garganta, aperto no peito, dificuldade respiratória, rash cutâneo, retenção urinária, acolia fecal (fezes pálidas), febre, dor de garganta, icterícia, dor epigástrica severa, diarreia, prurido vaginal ou leucorréia, anorexia, hipotensão, disfunção hepática e renal (raro), leucopenia, trombocitopenia, ↑ enzimas hepáticas, gosto metálico, discrasias sanguíneas, eritema, SSJ, tontura, cefaleia, vertigem, pele seca, náusea, vômito, dor abdominal, tromboflebite, poliartrite (raro).
Observação	Não administrar mais que 1.200mg em menos de 1 hora de infusão. Não administrar em bolus. Dose administrada IM não deve exceder 600mg. É necessário reduzir a concentração p/ infusão após diluição; Pode ocorrer hipotensão e parada cardiopulmonar se administrado EV rápido. Pelo potencial de colite fatal, suspender o tratamento se ocorrer diarréia, cólica abdominal e perda de sangue/ muco nas fezes.

IMIPENEM + CILASTATINA, SÓDICA				
Classe farmacológica	Antimicroniano carbapenêmico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 500mg			
Dose Usual	Adultos 500mg a cada 6 horas ou 1g a cada 8 horas Dose máx.: 4g/dia. Crianças Até 1 semana de idade: 25mg/kg a cada 12 horas De 1 ate´4 semanas: 25mg/kg a cada 8 horas De 4 semanas a 3 meses: 25mg/kg a cada 6 horas Acima de 3 meses:15-25mg/kg a cada 6 horas			
Reconstituição	Sim			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto		**Diluição padrão:**	-

Folha: 262

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

		Não	**Diluente:**	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	5mg/mL
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	20-30min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	4h
			R:	24h
	Diluído		TA:	-
			R:	-
Incompatibilidade	Bicarbonato de sódio, alopurinol, azitromicina, amiodarona, ringer lactato, meperidina, midazolan, fluconazol, lansoprazol, lorazepam, soro ringer lactato, anfotericina, azitromicina, gentamicina, etoposídeo.			
Interações medicamentosas	Ganciclovir ou ciclosporinas: pode causar convulsão; Aminoglicosídeos: possível inativação do efeito. Probenecida: reduz a excreção renal.			

Folha: 263

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Vômito, náusea, diarreia, febre, hipotensão, choque anafilático (raro), eosinofilia, leucopenia, anemia, eritema e dor no local da injeção, flebite, taquicardia, rash, SSJ, anafilaxia, prurido, alucinações, confusão mental, convulsões (sobretudo em crianças com meningite), sonolência, tontura, candidíase oral, colite pseudomembranosa, manchas nos dentes, sudorese, aumento das transaminases, disfunção renal, urina de coloração amarelada (sem importância clínica).
Observação	Se o paciente apresentar náusea durante a infusão, a velocidade de infusão deve ser diminuída, ou seja, aumentar o tempo de infusão. Se a solução escurecer, não deve ser utilizada.

LINEZOLIDA				
Classe farmacológica	Antimicrobiano fluoroquinolona sintética.			
Apresentação	Solução injetável 2mg/mL em bolsa de 300mL			
Dose Usual	Adultos 600mg a cada 12 horas Crianças 10mg/kg a cada 8-12 horas			
Reconstituição	Não (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	2mg/ml
			Diluente:	SF, SG, SRL

Folha: 264

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	30-120min
Estabilidade	**Reconstituído**		TA:	-
			R:	-
	Diluído		TA:	-
			R:	-
Incompatibilidade	Anfotericina B, clorpromazina, diazepam, pentamidina, fenitoina, sulfametoxazol + trimetroprima, ceftriaxona, lactobionato de eritromicina.			
Interações medicamentosas	Pseudoefrina/ fenilpropanolamina, adrenalina, dopamina, noradrenalina: ↑ leve e reversível da resposta pressórica. Evitar ingestão alimentos contendo tiramina (queijos, extrato de levedura, bebidas alcoólicas não destiladas, produtos de soja fermentado): ↑ pressão arterial.			
Eventos adversos	Cefaleia, sabor metálico, náusea, vômito, diarreia, dor abdominal, colite, convulsão, constipação, candidíase vaginal, monilíase, calafrios, febre, flebite, tontura, zumbido, insônia, hipotensão, hipertensão arterial, parestesia, rash, urticária, sudorese, aumento transaminases, bilirrubinas, amilase, lipase, glicemia, acidose lática, anemia, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia, neuropatia, neurite ótica, boca seca, dispepsia, gastrite, glossite e estomatite. O uso prolongado pode causar neuropatia periférica e supressão medular, acidose lática.			
Observação	Solução de ve ser mantida protegida dda luz até o momento do seu uso. A solução pode ficar amarelada sem afetar sua potência.			

Folha: 265

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">MEROPENEM, TRIIDRATADO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antimicrobiano Carbapenêmico</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Pó para solução injetável de 500mg</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos
1,5-6g/dia divididas a cada 8 horas Crianças
10-40mg/kg a cada 8 horas</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>500mg em 10mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>AD</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>1-3min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1-20mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>15-30min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>2h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>12h</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Anfotericina B, metronidazol, diazepam, multivitaminas, pantoprazol.</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="4">Probenecida: diminui a excreção renal e aumenta os níveis séricos (recomenda-se evitar a co-administração).
Ácido valpróico: pode diminuir os níveis sanguíneos deste medicamento</td></tr>
</table>

Folha: 266

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Hipotensão, dor torácica, dispneia, apneia, bradicardia, síncope, cefaleia, insônia, vertigem, agitação, febre, alucinação, sonolência, parestesia, calafrios, náusea, principalmente em infusão rápida. Diarreia, vômito, melena, constipação, monilíase oral, candidíase oral ou perineal, hemorragia gastrintestinal, febre e superinfecção (por bactérias e por fungos), reação cutânea, necrólise tóxica epidermal (NET), Sindrome de Stevens-Johnson. Pode haver reação de sensibilidade cruzada à penicilina. Neutropenia, trombocitopenia, anemia, eosinofilia, leucopenia, aumento AST e ALT, FA, LDH, bilirrubinas, creatinina sérica. Confusão mental. O risco de convulsão é menor quando comparado ao imipirom
Observação	Soluções não podem ser congeladas. Pode ser utilizado soro glicosado 5% para diluição, no entanto está deve ser utilizada imediatamente.

METRONIDAZOL				
Classe farmacológica	Antimicrobiano e antiparasitário nitroimidazólico			
Apresentação	Bolsa de 500mg/100mL			
Dose Usual	500mg EV a cada 8 horas			
Reconstituição	Não se aplica, solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-

Folha: 267

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1 hora
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	-
			R:	-
	Diluido		**TA:**	-
			R:	-
Incompatibilidade	Anfotericina B, aztreonam, filgrastim, pantoprazol, lanzoprazol.			
Interações medicamentosas	Anticoagulante oral: ↑ do efeito Dissulfiram: episódios psicóticos, efeito dissulfiram (vômitos intensos, congestão generalizada, cefaleia, confusão mental e estado psicótico) se associado a bebidas alcoólicas. Rifampicina e fenobarbital: ↑ metabolismo do metronidazol. Fenitoína, lítio, varfarina: ↑ níveis de toxicidade destes Cimetidina: ↑ toxicidade e diminui o efeito do metronidazol. Barbitúricos: diminui o nível sérico do metronidazol Azatioprina ou Fluorouracil: ↑ risco de leucopenia.			
Eventos adversos	Náusea, vômito, anorexia, estomatite, xerostomia, diarréia, dor epigástrica, náuseas, neutropenia reversível, boca seca, glossite, gosto metálico na boca, urina de coloração escura, urticária, dor nas articulações, exantema, queimação uretral e vaginal, ginecomastia e, raramente, neuropatia periférica (associada a dose alta e prolongada), colite pseudomembranosa. Superinfecção, pancreatite, convulsões, encefalopatia, disfunção cerebelar e ataxia, cefaleia, tontura, confusão mental, insônia, alucinação, parestesia, flebite, tromboflebite, alergia, leucopenia, neutropenia, rash.			

Folha: 268

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Deve ser armazenado a temperatura ambiente e protegido da luz. A refrigeração resulta em cristalização e a exposição à luz causa escurecimento.

OXACILINA				
Classe farmacológica	Antimicrobiano β-lactâmico da classe das penicilinas			
Apresentação	Pó para solução injetável de 500mg			
Dose Usual	**<u>Adultos:</u>** 250mg a 1 g a cada 4 ou 6 horas. Obs.: Meningite Bacteriana (EV): 1,5 a 2 g a cada 4 horas.		**<u>Crianças:</u>** Prematuros e Recém-natos: 6,25 mg por kg de peso a cada 6 horas. Até 40 kg de Peso: 50 a 100 mg por kg de peso corporal por dia, em doses divididas a cada 6 horas; ou 100 mg por kg de peso por dia, em doses divididas a cada 4 horas. Crianças com 40 kg ou mais: Mesmas doses de adultos.	
Reconstituição	Sim - em 4,8 mL de AD			
Vias de administração	**IM**	Não recomendado		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-10mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	1 hora
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	12 horas
			R:	-
	Diluído		**TA:**	12 horas
			R:	-
Incompatibilidade	Aciclovir, cloranfenicol, dopamina, fluconazol, heparina, hidrocortisona, morfina, bicarbonato de sódio, cloreto de potássio, aminoglicosídeos.			

Folha: 269

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Probenecida: ↑ e prolonga os níveis séricos de penicilina e reduz o grau de excreção renal. Aminoglicosídeos: inativação mútua. Tetraciclina: ↓ do efeito da oxacilina. Vacina conta febre tifóide: uso concomitante pode reduzir a resposta imune à vacina. Aguardar 24h ou mais após a última dose do antibiótico para administrar a vacina.
Eventos adversos	Reação alérgica: eritema, anafilaxia, prurido ou urticária, edema de face ou mãos, formigamento na boca ou garganta, aperto no peito, dificuldade respiratória. Febre, colite pseudomembranosa escurecimento da língua, convulsão, ↓ da hemoglobina, neutropenia, hematúria transitória e nefropatia (raro), nefrite intersticial com hematúria, albuminúria
Observação	Administração rápida pode causar crise convulsiva. O armazenamento sob refrigeração pode induzir a cristalização.

PIPERACILINA, SÓDICA + TAZOBACTAM, SÓDICO				
Classe farmacológica	Penicilina associado a um inibidor do inativador de penicilina			
Apresentação	Pó para solução injetável de 4g de piperaciclina mais 500mg de tazobactam			
Dose Usual	Adulto Até 4,5g a cada 6 horas Crianças 2-9 meses de idade: 80mg de piperaciclina + 10mg tazobactam / kg de peso EV a cada 8 horas. 9 meses ou mais com até 40kg de peso: 100mg de piperaciclina + 12,5mg tazobactam / kg de peso EV a cada 8 horas. 9 meses ou mais com mais de 40kg de peso: 3,375g EV a cada 6 horas.			
Reconstituição	Sim - reconstituir em 18 mL de AD			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de infusão:	Não se aplica
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-20mg/mL

Folha: 270

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

		Diluente:	SF, SG, AD

Folha: 271

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	30-60min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	12 horas
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	24 horas
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ringer lactato, aciclovir, anfotericina B, azitromicina, clorpromazina, dobutamina, ganciclovir, haloperidol, amiodarona, hemoderivados, hidrolisados protéicos.			
Interações medicamentosas	Probenecida: prolonga a meia-vida da piperaciclina+ tazobactam e ↓ a depuração renal. Vecurônio: prolonga o bloqueio neuromuscular. Tetraciclinas: podem diminuir os efeitos da piperaciclina + tazobactam.			
Eventos adversos	Náusea, vômito, hipotensão, hipertensão, flebite e dor local, eczema, edema, insônia, cefaleia, agitação, febre, tontura, confusão, vertigem, convulsão, rash, reação anafilática, prurido, eritema multiforme, Síndrome Stevens-Johnson, broncoespasmo, hipocalemia, eosinofilia, neutropenia, trombocitopenia, ↑ creatinina, ↑ das transaminases e bilirrubina, ↓ da hemoglobina e hematócrito, arritmia, anemia hemolítica, mialgia, artralgia, preteinúria, hematúria, piúria, nefrite instersticial, hepatite colestática, hipocalemia, hipernatremia, alcalose metabólica, letargia, ICC, superinfecção.			
Observação	Se também houver aminoglicosídeo prescrito, recomenda-se um intervalo de 30-60 min. entre as duas administrações. As soluções reconstituídas variam de incolores a amarelo- palha. Ajuste para função renal. Dialisável: HD moderada			

SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA	
Classe farmacológica	Sulfonamida + inibidores de diidrofolato redutase

Folha: 272

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Apresentação	Solução injetável 400 + 80mg, ampola com 5mL			
Dose Usual	1 a 2 ampolas a cada 6 a 8 horas			
Reconstituição	Não – Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1mL de solução em 20-25mL de diluente
			Diluente:	SG, SF
			Tempo de infusão:	60-90min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	1 hora
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Midazolam, verapamil, fluconazol, linezolida, pantoprazol, cisatracúrio, vinorelbina.			
Interações medicamentosas	Metotrexato e pirimetamina: ↑ a possibilidade de citopenias graves. Varfarina, fenitoína, tolbutamida, clorpropamida: efeitos potencializados desses medicamentos; Polimixina B e aminoglicosídeo: sinergismo contra BGN; Sulfoniluréia, digoxina: ↑ dos efeitos desses medicamentos; Ciclosporina: diminuição da concentração sérica desse fármaco.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Eventos adversos	Náusea, vômito, anorexia, glossite, estomatite, diarreia, colite pseudomembranosa, pancreatite, esplenomegalia, rash, urticária, prurido dermatite, eritema multiforme, Síndrome de StevensJohnson, anafilaxia, reação do tipo doença do soro, fotossensibilização, agranulocitose, aplasia de medula, eosinofilia, anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia, agrava deficiência de folato com anemia megaloblástica, confusão, depressão, convulsão, alucinações, ataxia, calafrios, febre, meningite asséptica, síndrome lúpica, vasculite, hepatite, colestase, nefrite intersticial, IRA, miocardite alérgica, dor no local da injeção venosa. Hiperpotassemia (dose alta), hiperglicemia, elevação das transaminases, artralgia, mialgia. Precipita kernicterus em RN. Maior incidência de efeitos colaterais em pacientes com AIDS.
Observação	Contraindicado para crianças menores de dois meses. A solução diluída deve ser protegida da luz. Desprezar a solução diluída se houver a formação de preciptado Não administrar sem diluição. Ajuste para função renal.

VANCOMICINA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Antimicrobiano glicopeptídico			
Apresentação	Pó para solução injetável de 500mg			
Dose Usual	500mg a cada 6 horas			
Reconstituição	Sim – reconstuir em 10mL de AD			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	Não se aplica
			Diluente:	Não se aplica
			Tempo de infusão:	Não se aplica
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	2,5-5mg/mL, ou seja, 500mg em 100 a 200mL de diluente.
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	60min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	7 dias

Folha: 274

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

		R:	14 dias
	Diluído	**TA:**	24 horas
		R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Albumina, amobarbital, anfotericina B, Benzilpenicilina potássica, idarrubicina, clorotiazida, fenitoína, fenobarbital, dexametasona, lanzoprazol, pantobarbital, cloranfenicol, aminofilina, aztreonam, bicarbonato de sódio, cefalotina, cefazolina, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona, heparina, hidrocortisona, oxacilina, piperacilina+tazobactam, sulfametoxazol+trimetoprima, varfarina, vitaminas do complexo B, vitamina C.		
Interações medicamentosas	Anestésicos: risco de rubor. Ácido acetilsalicílico, aminoglicosídeos, ciclosporinas, cisplatina e diuréticos de alça: ototoxicidade e nefrotoxicidade.		
Eventos adversos	Alergia cutânea, eritema multiforme, febre, zumbido, tontura, perda da audição, infusão rápida pode causar síndrome do homem vermelho (hiperemia, rubor, angioedema, prurido e calor difuso ou só no pescoço), dor nas costas e no pescoço, superinfecção (língua saburrosa, prurido, leucorreia, diarreia fétida), colite pseudomembranosa (sangue nas fezes), calafrios durante a infusão, náusea, vômito, nefrotoxicidade, bloqueio neuromuscular, flebite e dor no local da injeção, hipotensão, parada cardíaca, leucopenia, trombocitopenia, eosinofilia.		
Observação	Não administrar por via IM e evitar extravasamento durante a administração EV, devido ao risco extremo de irritação e possível necrose. Associação com aminoglicosídeo aumenta nefrotoxicidade de ambas. Ajuste da dose para função renal.		

Folha: 275

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">ACICLOVIR, SÓDICO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antiviral</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Pó para solução injetável de 250mg</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="2">Adultos:
5-15mg/kg a cada 8 horas</td><td colspan="2">Crianças
5-20mg/kg a cada 8 horas</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Sim – Reconstituir em 250mg em 5mL de AD</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>Diluir a solução reconstituída em 50mL a 125mL de diluente compatível, até uma concentração de 2,5 a 7mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>1 h ou mais</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>6 h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>12 h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
</table>

Folha: 276

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Aztreonam, cefepima, dopamina, ondansetrona, piperacilina+tazobactam, dobutamina, idarrubicina morfina, água bacteriostática, hemoderivados, gencitabina, fludarabina, pantoprazol, vinorelbina.
Interações medicamentosas	Ciclosporina: potencializa o risco de nefrotoxicidade. Zidovudina: neurotoxicidade. Metotrexato e outros fármacos eliminados por via renal: ↓ da depuração renal.
Eventos adversos	Neurotoxicidade (revertida com a suspensão do fármaco), neutropenia, síndrome trombocitopênica (> risco em pacientes imunossuprimidos), flebite, rash cutâneo, Síndrome de StevensJohnson, hipotensão, fotossensibilidade, hepatite, hematúria, anafilaxia.
Observação	Garantir hidratação adequada. Não utilizar água bacteriostática, ou solução com álcool benzílico ou parabenos. Não refrigerar a solução reconstituída ou diluída pois pode formar precipitado, invibializando a solução. Se > 7 mg/ml: risco de flebite + nefrotoxicidade. Extravasamento pode causar necrose tecidual. Infusão EV rápida: pode causar insuficiência renal aguda. É dialisável. Fazer a dose sempre após hemodiálise. Dose máxima se função hepática e renal normais: a) crianças > 1 ano: 1.800 mg/dia b) crianças > 30 kg: 4-6 g/ dia.

Folha: 277

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">ANFOTERICINA B</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antifúngico</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Pó para solução injetável de 50mg</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">0,3-1mg/kg/dia</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Sim. 50mg em 10mL de AD</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>Solução reconstituída para 490mL de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SG</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>2-6h</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>7 dias</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
</table>

Folha: 278

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	SF 0,9%, água bacteriostática, NaCl, alopurinol sódico, aztreonam, benzilpenicilina potássica e sódica, ciprofloxacino, KCl, cefepime, cimetidina, clorpromazina, difenidramina, dopamina, verapamil, linezolida, propofol, sais de Ca2+, gentamicina, sulfato Mg2++, polimixina B.

Folha: 279

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	↑ atividade/toxicidade de anfotericina B: caspofungina, aminoglicosídeos, ciclosporina, vancomicina, estreptomicina, antineoplásicos, piperacilina, ticarcilina, corticosteróides, diuréticos espoliadores de K+ (↑ perdas K+); - ↓ atividade/toxicidade de anfotericina B: antifúngicos triazólicos (fluconazol, voriconazol, piperacilina e ticarcilina (↓ nefrotoxicidade); - Anfotericina B ↑ o risco de toxicidade de digoxina e bloqueadores neuromusculares periféricos devido à hipocalemia reduzida
Eventos adversos	Reação de hipersensibilidade com febre (80%), calafrios, broncoespasmo e anafilaxia, toxicidade renal, espoliação de K e Mg, hepatotoxicidade, anemia hipocrômica e normocítica, ↓ plaquetas, leucopenia, hematúria, eosinofilia, prostração, cefaleia, náuseas, vômitos, gosto metálico na boca, hipotensão, hipertensão, perda auditiva, flebite, edema face, lábios e língua, dificuldade respiratória, edema em tornozelos e pés, ↓ diurese, fraqueza severa, câimbra muscular, diarreia, dor epigástrica.
Observação	Solução reconstituída deve ser protegida da luz. Após diluição em SG, não é necessário aproteção de luz. Infusão IV rápida pode provocar hipotensão, hipocalemia, arritmia e choque. É dialisável (HD). Necessário fazer ajuste de acordo com o clearance de creatinina. Se ↑ da creatinina por anfotericina B, reduzir a dose em 50% ou administrar dose total em dias alternados. Monitorar função renal e hepática, eletrólitos séricos e contagens hematológicas durante o tratamento. Infundir preferencialmente pela manhã para evitar que os efeitos colaterais ocorram à noite. Uma sobrecarga hídrica com NaCl antes da infusão diminui a toxicidade renal.

Folha: 280

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)				
Classe farmacológica	Vitamina			
Apresentação	Solução injetável 100mg/mL, ampola com 5mL.			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não se aplica, solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	20mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Uso imediato. Desprezar as sobras
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Bicarbonato de sódio, cefazolina, bleomicina, varfarina, epinefrina, aminofilina, furosemida, hidrocortisona, vitamina K, penicilina potássica, cloranfenicol.			
Interações medicamentosas	Salicilatos: ↑ excreção urinária de vitamina C. Barbitúricos: requer ajuste da dose de vitamina C. Heparina e varfarina: possível ↓ dessas drogas. Deferoxamina: ↑ da toxicidade do ferro. Antidepressivos tricíclicos: possível ↑ da excreção e ↓ dos efeitos dessas drogas (nos casos de acidificação da urina).			
Eventos adversos	Náusea, vômito, tontura e síncope (se aplicação rápida), cefaleia, fadiga, diarreia, rubor facial, disúria, litíase renal, hemólise, acidificação da urina, trombose venosa profunda.			

Folha: 281

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Se doses altas e tempo prolongado pode ocorrer: escorbuto de rebote; dano renal grave; oxalose metastática c/ arritmias cardíacas. Risco de anemias (principalmente nos pacientes hematológicos). Não administrar em tempo inferior a 60 min (devido ao risco de insuficiência renal). Soluções de ácido ascórbico são rapidamente oxidadas quando em contato com o ar e meio alcalino (deve ser protegido do ar e da luz).

ÁCIDO GADODÉRICO				
Classe farmacológica	Contraste radiológico			
Apresentação	Solução injetável de 0,05mmol/mL, frasco-ampola com 10mL			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não - solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	-		
	EV direto *bolus*	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1-2mL/segundo
	EV infusão	-	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Descartar sobras
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Sem registro encontrado. Recomendado não misturar outras drogas ou nutrição parenteral.			
Interações medicamentosas	Sem registro encontrado			

Folha: 282

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Dor, sensação de frio ou calor no local da injeção, náusea, vômito, cefaleia, erupção cutânea, prurido, reações de hipersensibilidade, confusão mental, cegueira transitória, zumbido, dor de ouvido, dermatite bolhosa, boca seca, insuficiência renal aguda, incontinência urinária.
Observação	Solução incolor a amarelo pálido. Contraindicado para portadores de marcapasso e clipe vascular, exames de angiografia e por via intratecal.

Folha: 283

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

ÁCIDO TRANEXÂMICO				
Classe farmacológica	Antifibrinolítico, anti-hemorrágico.			
Apresentação	Solução injetável 50mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	Adultos: 15mg/kg 3 a 4 vezes ao dia (dose máx 1,2g) Crianças: 10mg/kg 3 a 4 vezes ao dia.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	50mg/min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	5ml para 10-20mL de diluente
			Diluente:	AD, SF, SRL
			Tempo de infusão:	50mg/min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Uso imediato. Descartar sobras.
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Recomendado não misturar outras drogas.			
Interações medicamentosas	Estradiol, medroxiprogesterona, clorpromazina, tretinoína.			
Eventos adversos	Dor abdominal, anemia, artralgia, dor musculoequelética, fadiga, tromboembolismo, reaçãoes de hipersensibilidade, visão turva, embolismo pulmonar, náusea diarreia vomito			
Observação	Contraindicado para mulheres que usam contraceptivos orais, hemorragia subaracnóides, pacientes com risco intrínseco de tromboembolismo. Administração muito rápida pode causar hipotensão, náusea, vômito, brasdicardia.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

<table>
<tr><th colspan="5">ADRENALINA (EPINEFRINA, CLORIDRATO)</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Agente simpatomimético</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Solução injtável de 1mg/mL, ampola com 1mL</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="2">Adultos</td><td colspan="2">Crianças</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Reações anafiláticas ou asma: SC ou IM: 0,1-0,5mg (dose única)
Controle de reações alérgicas:
IV: 0,1-0,25mg a cada 5-15min seguido de Infusão contínua: 14mcg/min.
Ressuscitação cardiopulmonar: 0,5-1mg a cada 3-5 min, seguido de Infusão contínua: 1- 4mcg/min
Bradicardia:
1mcg/min Controle de para cardíaca:
Via intracardíaca 0,3-0,5mg</td><td colspan="2">Reações anafiláticas ou asma: SC: 0,01mg/kg a cada 15 min Controle de reações alérgicas: IV:0,1mg seguido de Infusão contínua: 1,5mcg/kg/min.
Ressuscitação cardiopulmonar: 0,01mg/kg a cada 3-5 min, seguido de Infusão contínua: 0,1mcg/kg/min.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não. Solução pronta para uso</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td>SC</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1-64mcg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>6h (discartar o que sobrar na ampola)</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>12h.</td></tr>
</table>

Folha: 285

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Aminofilina, bicarbonato de sódio e soluções alcalinas, ampicilina, penicilina, ciclosporina, cloranfenicol, NaCl, furosemida, GluCa, norepinefrina, propranolol, vitamina C, varfarina, lidocaína, tiopental, ácido hialurônico.
Interações medicamentosas	Adrenérgicos: efeito sinérgico. Diminuição do efeito da epinefrina: beta adrenérgicos, metildopa, clorpromazina; Bloqueadores e adrenérgicos: possível neutralização do efeito terapêutico; Pode ↑ as concentrações plasmáticas de: morfina. Inibidores da MAO: possível crise hipertensiva; Anestésicos inalatórios: ↑ da irritabilidade cardíaca.
Eventos adversos	Taquicardia, hipertensão, arritmias, fibrilação ventricular fatal, isquemia vascular renal, hipertensão severa com hemorragia intracraniana, ansiedade, cefaleia, angina, obstrução da artéria central da retina, náusea, vômito, retenção urinária, disúria, espasmo vesical, queimação transitória, visão turva, glaucoma, fraqueza, debilidade, tremor, falta de memória, insônia. Após reanimação pode ocorrer taquicardia e hipertensão severa quando for usar dose alta, palidez, sudorese, hiperglicemia, edema pulmonar
Observação	Se infiltrar provoca lesão necrótica grave de pele. Deve ser infundida preferencialmente em via central em linha exclusiva. Cautela em paciente com diabetes, distúrbios cardiovasculares, da tireóide e arteriosclerose cerebral. Pode coadministrar com dopamina, dobutamina, atracúrio, pancurio e vecurônio. Complicações: isquemia renal, taquiarritmias ventriculares, hipertensão severa, necrose miocárdica, miocardite, hiperglicemia e hipercalemia, especialmente na presença de anestésicos inalados (halotano), hiperglicemia por supressão da insulina, hipocalemia pela entrada de potássio na célula apos estímulo ds receptores beta-2- adrenérgicos. Sensível a luz e ao ar. Solução diluída pode te alteração de cor de incolor para rosa ou marrom. Não utilizar a solução com a cor alterada.

Folha: 286

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

ALBUMINA HUMANA				
Classe farmacológica	Expansor de volume plasmático			
Apresentação	Solução intravenosa de 20%			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 parte para 3 de diluente (1:3)
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	30min a 4h
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	4h
			R:	-
Incompatibilidade	Midazolan, verapamil, vancomicina, drotrecogina alfa, água destilada (risco de hemólise).			
Interações medicamentosas	Não encontrada nos registrada			

Folha: 287

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Rubor, urticária, hipertensão, hipotensão, taquicardia, bradicardia, febre, náuseas, vômitos, calafrios, hipernatremia aguda, choque anafilático (raro), em caso de insuficiência cardíaca risco de congestão aguda e edema agudo de pulmão.

Folha: 288

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Se o frasco estiver armazenado sob refrigeração, aguardar a solução injetável estabalizar à temperatura ambiente. Após aberto, estabilidade de 15 min. Tempo de ½ vida: 8h Contraindicação: anemia severa, insuficiência cardíaca.

AMINOFILINA				
Classe farmacológica	Agente broncodilatador			
Apresentação	Solução injetável de 24mg/mL, ampola com 10mL			
Dose Usual	**Adultos**: 5,7mg/kg (dose máxima 1.125mg/dia) **Crianças**: 6 meses – 9 anos: 1,2mg/kg/kg 9 – 16 anos: 1,0mg/kg/kg			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	240mg/100ml de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	40-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
			TA:	Uso imediato. Descartar sobras

Folha: 289

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	Diluído	**R:**	Não se aplica

Folha: 290

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Besilato de atracúrio e cisatracúrio, norepinefrina, ceftriaxona, ciprofloxacino, amiodarona, cefepima, clorpromazina, dobutamina, doxorrubicina, epinefrina, hidralazina, hidroxizina, isoproterenol, meperidina, ondansetrona, prometazina, clindamicina, insulina regular, bleomicina, varfarina sódica.
Interações medicamentosas	Alopurinol, β-bloqueadores, bloqueador canal de cálcio, cimetidina, ciprofloxacino, claritromicina, corticóides, efedrina, eritromicina, furosemida, interferon, metotrexato, tiabendazol. Diminuição do nível sérico da aminofilina: carbamazepina, isoniazida, isoproterenol, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, barbitúricos. Adenosina: diminuição do efeito antiarrítmico. Propranolol: pode causar broncoespasmo em pacientes sensíveis. Halotano: risco de taquicardia sinusal.
Eventos adversos	Palpitações, taquicardia sinusal, extra-sístole, hipotensão, urticária, náusea, vômito, dispepsia, piora do refluxo gastroesofágico, peso no estômago, diarreia, aumento da frequência respiratória, anorexia, inquietação, nervosismo, tontura, cefaleia, insônia, convulsão, hemorragia digestiva, efeito diurético, redução do fluxo sanguíneo cerebral.
Observação	Não manter sob refrigeração devido ao risco de cristalização. Contraindicações: Pacientes com úlcera péptica ativa: pode ↑ o volume de acidez das secreções gástricas. Usar com cautela em portadores de doenças cardíacas graves, renais e hepáticas, hipertireoidismo, diabetes e em neonatos. Doses terapêuticas próximas às doses tóxicas. Antídoto para intoxicação Dipiridamol: 50-100 mg (máximo 250 mg) EV em 30-60 segundos.

AMIODARONA, CLORIDRATO	
Classe farmacológica	Antiarrítmico
Apresentação	Solução injetável de 50mg/mL, ampola com 3mL

Folha: 291

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">10-20mg/kg/dia</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não. Solução pronta para uso</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto bolus</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>5 min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1-6mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SG</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>30-60 min.
Para infusões acima de 1 hora, não exceder 2mg/mL, exceto se for acesso central</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>Uso imediato. Descartar sobras</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Aminofilina, heparina, bicarbonato de sódio, ampicilina/sulbactam, ceftadizima, cefazolina, digoxina, furosemida, imipenem, sulfato de magnésio, piperacilina, fosfato de potássio e fosfato de sódio, nitroprussiato de sódio.</td></tr>
</table>

Folha: 292

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Aumenta o risco de cardiotoxicidade por: inibidores de protease, antiarrítmicos de classe 1ª, betabloqueadores adrenérgicos, amitriptilina, azitromicina, cloroquina, diltiazem, foscarnete, fluconazol, fluoroquinolonas, haloperidol, lidocaína, loratadina, metronidazol, ondansetrona. Diminuição do efeito de amiodarona: rifampicina

Folha: 293

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Toxicidade a curto prazo: bradicardia (atropina resistente) e hipotensão por vasodilatação (possivelmente associado com infusão rápida e pode ser fatal). Hipertireoidismo e hipotireoidismo, depressão miocárdica, torsade de pointes, taquicardia ventricular paroxística, choque cardiogênico, fraqueza muscular, tontura, parestesia, incoordenação, constipação, ↑ QT, bloqueio atrioventricular, toxicidade hepática (pode ser fatal), pele de cor azulada, fotossensibilidade, rash, prurido, angioedema, fadiga, cefaleia, insônia, ataxia, mal-estar, marcha anormal, pesadelo, mudança nos hábitos, febre, hiperglicemia, ↑ TG, coagulação anormal, pancitopenia, necrose hepatocelular, flebite, distúrbios oculares (inclusive cegueira - uso crônico), disfunção renal, pneumonia intersticial, anafilaxia.
Observação	Proteger da luz Em contato com o plástico libera substância potencialmente tóxica. Irritante para os vasos periféricos (concentração > 2mg/ml). Contraindicação: bloqueio AV (átrio ventricular) 2º e 3º grau, bradicardia, disfunção do nó sinusal.

ATRACÚRIO, BESILATO				
Classe farmacológica	Bloqueador neuromuscular			
Apresentação	Solução injetável 10mg/mL, ampola com 2,5mL			
Dose Usual	**Adultos:** Início: 0,4 a 0,5mg/kg Manutenção: 0,08 a 0,1 mg/kg **Crianças:** 1 mês a 1 ano de idade: 0,3 a 0,4mg/kg (início) Acima de 2 anos: 0,4 a 0,5mg/kg (inicio) Acima de 1 ano de idade: 0,08 a 0,1mg/kg (manutenção			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto *bolus*	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-

Folha: 294

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	10 s
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,2 a 0,5mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12h
			R:	12h
Incompatibilidade	SRL, aminofilina, barbitúricos, propofol			
Interações medicamentosas	↑ efeito do atracúrio: aminoglicosídeos, vancomicina, anestésicos inalatórios, beta-bloqueadores, antiarrítmicos, furosemida, clindamicina, magnésio, outros bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, procainamida, quinidina, enflurano, sevoflurano, cetamina. ↓ efeito do atracúrio: carbamazepina, corticosteróides, suxametônio (succinilcolina) – antagonismo do bloqueio neuromuscular. Isoflurano: depressão respiratória			
Eventos adversos	Liberação de histamina: hipotensão, vasodilatação, eritema difuso transitório, prurido, urticária, anafilaxia. Outros: taquicardia, bradicardia, dispneia, broncoespasmo, laringoespasmo, ↑ secreção brônquica, sibilos, mínimos efeitos cardiovasculares transitórios, hipotensão ou hipertensão			
Observação	Não é estável em soluções alcalinas. Bloqueio neuromuscular pode ser revertido com neostigmine. Atropina pode ser avaliada para efeitos colinérgicos excessivos da neostigmine.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

ATROPINA, SULFATO				
Classe farmacológica	Antiespasmódico / antiarrítimico			
Apresentação	Solução injetável 0,25mg/mL, ampola com 1mL			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	0,01mg/kg
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ampicilina, bicarbonato de sódio, cloranfenicol, cimetidina, epinefrina, isoproterenol, norepinefrina, tiopental, varfarina.			

Folha: 296

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Anti-histamínicos, antidepressivos tricíclicos, fenotiazinas: ↑ o efeito da atropina e vice-versa. Metoclopramida: ↓ o efeito da atropina. Fenotiazinas e haloperidol: atropina diminui o efeito terapêutico destes medicamentos. Aminas simpatomiméticas: aumentam o risco de taquiarritmias
Eventos adversos	Boca seca, náusea, vômito, disfagia, azia, constipação, ciclopegia (paralisia dos músculos ciliares), midríase (↑ da pupila), sede exagerada, dificuldade em urinar, rubor facial, retenção urinária, palpitação, bradicardia paroxística com baixas doses de atropina e taquicardia com altas doses, cefaleia, sonolência, insônia, nervosismo, reações alérgicas, incluindo anafilaxia e urticária, diminuição da sudorese, leucopenia, arritmias, hiperpirexia (febre > 41oC com delírio), risco de hipertermia em crianças com paralisia cerebral, alucinação, ataxia, delírio, taquipneia, edema pulmonar, respiração superficial.
Observação	A via de administração subcutânea e endotraqueal também é permitida. Contraindicação: asma, taquicardia, doenças obstrutivas gastrintestinais e geniturinárias, íleo paralítico, miastenia grave. Metabolização hepática e eliminação renal. Tempo de meia-vida: 6h30min em crianças. Usar com cautela em pacientes com Síndrome de Down: são pacientes mais sensíveis à droga. Antídoto: Neostigmine

BICARBONATO DE SÓDIO	
Classe farmacológica	Eletrólito / alcalinizante
Apresentação	Solução injetável a 8,4%, ampola com 10mL (10mEq/10mL)
Dose Usual	ACM
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso

Folha: 297

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1:1
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	2 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,5mEq/mL
			Diluente:	SG, SF
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	24 h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Alopurinol, anfotericina B, benzilpenicilina potássica, norepinefrina, carboplatina, cefotaxima, cisplatina, amiodarona, dobutamina, dopamina, epinefrinaidarrubicina, isoproterenol, labetalol, metoclopramida, midazolan, nalbufina, ondansetrona, procaína, dimenidrato, imipinem + cilastatina sódica, injeção de ácido ascórbico, leucovorin calcico, meropenem, pantoprazol, estreptomicina, sulfato de magnésio, vincristina, ticarcilina sódica + clavulanato de potássio.			

Folha: 298

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Anfetamínicos (ex.: anfetaminas, efedrina e pseudoefedrina) ou quinidina: a alcalinização urinária aumenta a meia-vida e a duração da ação destas drogas com possíveis sintomas de toxicidade. - Ciprofloxacino, norfloxacino ou ofloxacino: a alcalinização da urina pode diminuir a solubilidade destes medicamentos e os pacientes devem ser observados quanto aos sintomas de cristalúria e nefrotoxidade. - Suplementos de potássio: o bicarbonato de sódio, por infusão intravenosa, diminui a concentração sérica do potássio promovendo seu deslocamento para dentro da célula. - Salicilatos (ex.: AAS, salicilato de sódio, salicilamida, salicilato de metila): aumenta sua excreção renal e diminui suas concentrações séricas. Recomenda-se administrar com precaução. - Tetraciclinas: diminui a sua absorção, pois o aumento de pH diminui a solubilidade das tetraciclinas e, logicamente sua absorção. Evitar uso em conjunto. Caso necessário, espaçar por duas horas a administração de um e outro. Empregar formas farmacêuticas de tetraciclina com boa disponibilidade; - Cetoconazol: há acentuada redução de sua absorção. - Lítio: aumenta a excreção, possivelmente reduzindo a sua eficácia devido ao conteúdo de sódio. - Anticolinérgicos (ex.: atropina, escopolamina, biperideno, triexafenid, diciclomina benactizina ciproheptadina) e anti-histamínicos H2 (ex.: cimetidina, famotidina, ranitidina): diminui a absorção e a eficácia. - Retarda a excreção e prolonga os efeitos da mecamilamina. - Pode reduzir a eficácia da metamina. - Diuréticos de alça (ex.: bumetanida, furosemida, indapamida) e diuréticos tiazídicos (ex.: hidroclorotiazida e clortalidona) podem aumentar a alcalose hipoclorêmica. - Preparações contendo cálcio, leite ou laticínios podem provocar síndrome alcalina causada pelo leite.
Eventos adversos	Necrose tecidual local e ulceração (se extravasamento), hipocalemia, hipernatremia, alcalose sistêmica, expressa por irritabilidade, excitabilidade neuromuscular e tetania, edema, hemorragia cerebral, acidose intracranial, alcalose metabólica, hipernatremia, hipocalcemia, hiperosmolaridade, distensão gástrica, edema pulmonar
Observação	Não misturar com sais de cálcio, catecolaminas e atropina. Injeção rápida produz hipernatremia, diminuição da pressão do líquor e possível hemorragia intracraniana, especialmente em RN e lactentes.

Folha: 299

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA (PESADA)	
Classe farmacológica	Anestésico

Apresentação	Solução injetável 0,5% (5mg/mL)			
Dose Usual	2-4mL para dultos. Pode variar ACM.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso			
Vias de administração	**Epidural**	Sim (dose máx 3mg/kg)		
	Bloquio periférico	Sim (dose máx 3mg/kg)		
	Raquidiana	Sim		
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Não encontrado na literatura consultada.			
Interações medicamentosas	Verapamil: pode ocasionar risco aumentado de bloqueio cardíaco.			
Eventos adversos	Parada cardíaca, hipotensão, bradicardia, palpitação, cefaleia, cansaço, fraqueza, ansiedade, zumbido, crise convulsiva, paralisia respiratória (apnéia) ou hipoventilação, bloqueio cardíaco, espirro, visão borrada, tremores, náusea e vômito, edema angioneurótico, constrição das pupilas (miose), depressão ou excitação do SNC, retenção urinária, incontinência fecal, perda de sensação perineal, lombalgia, reação alérgica.			
Observação	Administração epidural Usar com cautela em doenças hepáticas. Risco de parada cardíaca e convulsão se aplicado intravenoso. Atenção com pacientes diabéticos, pois solução contem glicose.			

Folha: 300

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

CLONIDINA, CLORIDRATO	
Classe farmacológica	Antihipertensivo / adjuvante de anestesia
Apresentação	Solução injetável 150mcg/mL, ampola com 1mL

Dose Usual	A dose usual entre 2-4 mcg/kg por via peridural e 0,5-1 mcg/kg por via intratecal produz analgesia de curta duração (4 a 6 horas) e deverá ser repetida de acordo com as respostas do paciente			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	7-10 min
	Epidural	Sim	**Diluição padrão:**	100mcg/mL
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	Gotejamento
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Uso único. Despresar as sobras
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Não encontrado na literatura consultada			
Interações medicamentosas	Antidepressivos tricíclicos: ↓ efeito anti-hipertensivo. Betabloqueadores: resposta hipertensiva paradoxal. Depressores do SNC: ↑ efeito depressivo no SNC. Anestésicos locais peridurais: a clonidina peridural prolonga a duração dos efeitos farmacológicos destes agentes, incluindo o bloqueio sensitivo e motor.			
Eventos adversos	Hipotensão, hipotensão postural, bradicardia, taquicardia, palpitações, alteração no ECG, hipertensão rebote, boca seca, náusea, constipação, confusão mental, vertigem, tontura sonolência, fadiga, febre, prurido, dermatite, urticária, rash, crise hipertensiva grave com a suspensão abrupta.			
Observação	-			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

CLORETO DE POTÁSSIO				
Classe farmacológica	Eletrólito			
Apresentação	Solução injetável de 10%, ampola com 10mL			
Dose Usual	**Adultos:** Infusão IV, 10 a 15 mEq três ou quatro vezes ao dia, normalmente não mais que 3 mEq/Kg. Os pacientes que utilizam diuréticos tiazídicos ou de alça podem exigir 80 a 100 mEq ao dia. **Crianças:** Infusão EV, 1 a 1,5 mEq/Kg/dia ou 40 mEq/m2/dia, em administração fracionada			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	30mL em 220ml de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	2-4h
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Uso imediato. Despresar sobras
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Manitol, anfotericina B, azitromicina, diazepam, fenitoína, lansoprazol, ergotamina.			

Folha: 302

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Corticóides e ACTH: podem ↓ efeito dos suplementos de potássio. Diuréticos poupadores de K, inibidores da ECA, AINE, bloqueadores beta-adrenérgicos, ciclosporina, heparina: podem ↑ a concentração sérica de potássio com risco de causar hipercalemia. Sais de cálcio: induzem ao risco aumentado de arritmia cardíaca.
Eventos adversos	Dor no local da injeção, necrose se extravazar, hipercalemia, alcalose, fraqueza, confusão, dormência nas mãos, pés e lábios, dificuldade respiratória, dispneia, ansiedade, cansaço, bradicardia, arritmia, hipotensão, confusão mental, hipercalemia, flatulência, lesões gastrintestinais, flebite, paralisia flácida, parestesia. Pode ser letal se aplicado sem diluição.
Observação	Dose máxima criança: 3 mEq/ kg/dia Usar com cautela em pacientes com doença cardíaca, insuficiência renal, diarréia grave ou prolongada, compressão esofágica, obstrução intestinal, úlcera péptica, acidose metabólica aguda, diabete melito descontrolada. Pode ser letal se aplicado sem diluição. 1 g de cloreto de potássio equivale a 13,41 mEq de potássio

DESLANOSÍDEO				
Classe farmacológica	Digitálico de curta duração			
Apresentação	Solução injetável de 0,2mg/mL, ampola com 2 mL			
Dose Usual	**Adultos:** Digitalização rápida (24h) em casos de urgência: 0,81,6mg, EV ou IM, fracionados em 1-4 administrações. Digitalização lenta (3-5 dias): 0,6-0,8mg/dia, EV ou IM, podendo ser em doses fracionadas. Manutenção: 0,2- 0,6mg/dia, IM ou EV. **Crianças:** Digitalização rápida (24h) em casos de urgência: 0,020,04mg/kg/dia, EV ou IM, fracionados em 1-3 administrações. (Dose máx.: Adultos e Crianças: 2mg/dia).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	Lento

Folha: 303

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	-
			R:	-
	Diluído		**TA:**	Descartar sobras.
			R:	-
Incompatibilidade	Não encontrado na literatura consultada.			
Interações medicamentosas	Cálcio em doses elevadas e psicotrópicos (litio) em pacientes digitalizados: ↑ o risco de arritmia cardíaca. Diuréticos portadores de K, anfotericina B, corticosteróides: podem contribuir para intoxicação digitálica (hipopotassemia)			
Eventos adversos	Os efeitos colaterais mais frequentes, especialmente após os primeiros sintomas da dosagem excessiva são do SNC e gastrointestinais (anorexia, náusea, vômito); em raras ocasiões confusão, desorientação, afasia e distúrbios visuais incluindo cromatopsia, sudorese fria, convulsões, síncope, morte; distúrbios da frequência cardíaca, condução e ritmo (bradicardia acentuada e parada cardíaca); no ECG rebaixamento do segmento ST com inversão pré-terminal da onda T. Reações cutâneas alérgicas (prurido, urticária, erupções maculares) e ginecomastia.			
Observações	Complicações: bradicardia sinusal, taquicardia supraventricular, bloqueio atrioventricular, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular.			

DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO		
Classe farmacológica	Anti-inflamatório corticoide	
Apresentação	Solução injetável de 4mg/mL, ampola com 2,5ml	
Dose Usual	4 a 20mg distribuídas ACM. Dose máxima 80mg/dia	
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.	
Vias de administração	**IM**	Sim

Folha: 304

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1-5min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,1mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12h
			R:	24h
Incompatibilidade	Amicacina, anfotericina, cálcio, ciprofloxacino, diazepam, difenidramina, dobutamina, gentamicina, hidantoína, midazolam, sulfametoxazol+trimetoprima, tobramicina, vancomicina.			
Interações medicamentosas	Antifúngico azólico, ciclosporina, AINEs, bloqueador de cálcio: ↑ efeito da dexametasona. Diuréticos: ↓ de ambas as drogas. Talidomida, ritonavir: risco de necrose epidérmica tóxica. Fenobarbital, fenitoína, rifampicina, colestiramina, antiácidos: ↓ os efeitos da dexametasona. Dexametasona ↑ o efeito de: saquinavir, caspofungina, fluoroquinolona. Bloqueadores neuromusculares: dexametasona ↓ os efeitos.			
Eventos adversos	Cefaleia, vertigem, agitação, insônia, convulsão, distúrbios gastrintestinais, anemia, distúrbios hematológicos, edema e hipertensão, desequilíbrio eletrolítico, euforia, glicosúria, hiperglicemia, reações de hipersensibilidade incluindo anafilaxia, hipertensão, variações de humor, úlcera péptica, sudorese, fraqueza.			

Folha: 305

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	Em tratamento prolongado é necessário suplementar potássio, vitaminas A, B6, C e D, folato cálcio, zinco e fósforo e restringir sódio. Pacientes em uso crônico de dexametasona podem desenvolver outros reações adversas.

DICLOFENACO SÓDICO		
Classe farmacológica	Anti-inflamatório não esteroide	
Apresentação	Solução injetável de 25mg/mL, ampola com 3ml	
Dose Usual	75 mg, uma vez ao dia (dose máx. 150mg/dia)	
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.	
Vias de administração	**IM**	Sim
Interações medicamentosas	Lítio; digoxina, diuréticos, inibidores da ECA ou betabloqueadores, outros AINEs (assim como ácido acetilsalicílico ou ibuprofeno); corticoides, anticoagulantes, antidiabéticos, com exceção da insulina, metotrexato, ciclosporina, antibacterianos quinolônicos.	

Folha: 306

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Dor de cabeça, tontura, náusea, vômito, diarréia, indigestão, dor abdominal, flatulência, perda do apetite, mudança na função do fígado (ex.: nível de transaminases), rash cutâneo (vermelhidão na pele com ou sem descamação), reação no local da injeção, dor no local da injeção, rigidez no local da injeção, onolência, dor de estômago, inchaço nos braços, mãos, pernas e pés (edema), necrose no local da injeção, desorientação, depressão, dificuldade de dormir, pesadelos, irritabilidade, distúrbios psicóticos, formigamento ou dormência nas mãos ou pés, memória debilitada, ansiedade, tremores, distúrbios do paladar, distúrbios de visão e audição, constipação, ferimentos na boca, úlcera no esôfago (o tubo que leva o alimento da garganta para o estômago), palpitações, perda de cabelo, vermelhidão, inchaço e bolhas na pele (devido ao aumento da sensibilidade ao sol), abcesso no local da injeção

DIFENIDRAMINA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Anti-histamínico			
Apresentação	Solução injetável de 50mg/mL, ampola com 1 mL			
Dose Usual	**Adultos**: 10-50mg, IV ou IM profundo, a cada 2-4h. (Dose máx.: 400mg/dia). **Crianças:** 5mg/kg/24h, IV ou IM profundo, fracionado em 2-3 administrações. (Dose máx.: 300mg/dia).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	2-3 min (até 25mg/min)
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-2,5mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL

Folha: 307

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	15-30 min (até 25mg/min)
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Amobarbital, anfotericina B lipossomal, cefepime, fenitoinca, fenobarbital, etoposídeo, haloperidol, lansoprazol, pantoprazol, pantobarbital.			
Interações medicamentosas	Amitriptilina, codeína, clomipramina, linezolida, metoprolol, tramadol, zolpidem, ta- moxifeno, droperidol.			
Eventos adversos	Sedação intensa, sonolência, cefaleia, tontura, fadiga, vômito, náu- sea, tremores, hipotensão, taquicardia, disúria, visão borrada, diarreia, constipação.			
Observações	Não administrar SC.			

DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE				
Classe farmacológica	Ante emético, Antagonista de H1			
Apresentação	Solução injetável de (3mg + 5mg + 100mg + 100mg)/mL, ampola com 10mL.			
Dose Usual	**Adultos:** 1 ampola, a cada 4 a 6 horas. (Dose máx. de dimenidrinato: 300mg/dia EV). **Crianças:** (de 2 a 6 anos de idade): 1,25mg/kg, IM/EV, a cada 6h. (Dose máx. de dimenidrinato: 300mg/dia EV).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	2-5 min
			Diluição padrão:	1 ampola em 100mL de diluente

Folha: 308

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV infusão	Não	**Diluente:**	SF, SG
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12 h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Aminofilina, heparina, hidrocortisona, fenitoína, prometazina, tiopental.			
Interações medicamentosas	Procarbazina, anfetaminas.			
Eventos adversos	Sonolência, sedação, tontura, insônia, visão turva, retenção urinária, hipotensão, taquicardia, náusea, vômito, anemia. Não necessita de ajuste de dose em pacientes com IR e hepática.			
Observações	Contraindicado para recém-nascidos (até 30 dias de vida). Administrar lentamente, pois é irritante			

DIPIRIDAMOL				
Classe farmacológica	Antiagregante plaquetário			
Apresentação	Solução injetável de 5mg/mL, ampola com 2 mL			
Dose Usual	**Adultos**: IV: 0,14mg/kg/min. (Dose máx.: 60mg).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1 ampola para 20-50mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	4-6 min
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-

Folha: 309

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Reconstituído**	**TA:**	Não se aplica
		R:	Não se aplica
	Diluído	**TA:**	Não se aplica
		R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Não encontrado na literatura consultada.		
Interações medicamentosas	Adenosina, AAS, citalopram, dalteparina, venlafaxina, duloxetina, enoxaparina, escitalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, colchicina, dasatinibe, rivaroxabana, vincristina.		
Eventos adversos	Rash, cefaleia, diarreia, vômito, dor abdominal.		
Observações	Não recomendado o uso pediátrico, pois eficácia e segurança em crianças não foram estabelecidas. O extravasamento do medicamento pode causar necrose. Monitorar sinais de sangramento. Não sofre perda na hemodiálise. Usar com cautela em hepatopatas. Aminofilina deve estar disponível para uso em urgências/emergências.		

DIPIRONA SÓDICA				
Classe farmacológica	Anti-inflamatório não esteroide			
Apresentação	Solução injetável de 500mg/mL, ampola com 2 mL			
Dose Usual	**Adultos:** IM ou EV: 1000-2500mg, 1-4 vezes/dia. (Dose máx.: 3000mg/dia). **Crianças:** EV: 20-25mg/kg/dose, a cada 6 horas. (Dose máx.: 500mg/dia).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1mL/min

Folha: 310

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	20mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica. Descartar sobras.
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ciprofloxacino, diazepam, dobutamina, dopamina, doxorrubicina, droperidol, epinefrina, fluconazol, gentamicina, isoproterenol, meperidina, metoclopramida, morfina, norepinefrina, ondansetrona, vimblastina, vincristina, vitamina C.			
Interações medicamentosas	Cetorolaco, cilcospporina, clopidogrel, heparina, enoxaparina, amilorida, espironolactona, hidroclorotiaziada, furosemida, lítio, Metotrexato, glibenclamida, tolbutamina, anlodipino, atenolol, captopril, carvedilol, citalopram, diltiazem, enalapril, felodipino, fluoxetina, hidroclorotiazida, nimodipino, paroxetina, propanolol, sertralina, varfarina, venlafaxina, verapamil.			
Eventos adversos	Efeitos gastrintestinais, erupções cutâneas, alterações hematológicas, choque anafilático, reações alérgicas, edema angioneurótico, distúrbios renais transitórios, depressão medular, crise transitória de hipotensão, tremores, vasculite, exantema, urticária, necrose epidérmica tóxica, síndrome de Lyell e Steven Johnson, náusea, vomito, anafilaxia, pneumonite, sonolência, cansaço, innsuficiencia renal agura.			
Observações	Não administrar o medicamento em crianças menores de 3 meses de idade ou pesando menos de 5kg; não se deve administrar o medicamento por via intravenosa em crianças com idade entre 3 e 11 meses ou pesando menos de 9Kg. Crianças < 12 anos não devem ser tratadas com supositórios para adultos. Pode causar hipotensão			

Folha: 311

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><th colspan="5">DOBUTAMINA, CLORIDRATO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Agente simpatomimético</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Solução injetável de 12,5mg/mL, ampola com 4 mL.</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos:
2,5-20mcg/kg/minuto, EV.
Crianças:
2,5-20mcg/kg/minuto, EV.
(Dose máx. Adultos e crianças: 40mcg/kg/minuto; neonato: 20mcg/kg/minuto).</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não. Solução pronta para uso.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Não</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão Em BI</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>0,25-5mg/mL de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SG, SF, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>Conforme dose.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>24h. Descartar sobras da ampola.</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
</table>

Folha: 312

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Aciclovir, aminofilina, bicarbonato de sódio, cálcio, cefazolina, diazepam, heparina, digoxina, hidantoína, furosemida, cefepima, fenitoína, piperacilina + tazobactam, tiopental, hidrocortisona, insulina regular, penicilina G, sulfato de magnésio, verapamil, anfotericina B, varfarina, KCl, ceftazidima, diazepam, esteptoquinase, fosfato de sódio e potássio, gluconato de cálcio, ganciclovir, indometacina, micafungina, nitroglicerina, nitroprusseto, piperacilina + tazobactam, sulfato de magnésio, oxacilina, tiopental.
Interações medicamentosas	Amitriptilina, carvedilol, cimetidina, metildopa, metoprolol, nortriptilina, nimesulida.
Eventos adversos	Cefaleia, náusea, vômito, flebite, angina, hipocalemia, febre, dispneia, câimbras nas pernas, hipotensão, hipertensão, febre, angina, parestesias. Pode aumentar resposta ventricular (taquicardia) na fibrilação ou flutter atrial. Pode causar hipotensão em paciente hipovolêmico. Em doses altas pode ocasionar taquicardia, arritmias.
Observações	Usar bomba de infusão. Administrar por veias de grande calibre. Não administrar na mesma linha venosa (em Y) que heparina, hidrocortisona, cefazolina e penicilina. Risco de necrose tecidual (se houver extravasamento). Alguns casos de choque não melhoram com dobutamina. Pode ser misturada com dopamina, adrenalina, noradrenalina, lidocaína, vecurônio, atracurônio, isoproterenol, tobramicina. **Não administrar com Bicarbonato de sódio. Infundir em acesso calibroso pelo risco de necrose**. Observar a coloração rósea: perda da potência. Monitorar PA e FC.

DOPAMINA, CLORIDRATO	
Classe farmacológica	Agente simpatomimético
Apresentação	Solução injetável de 5mg/mL, ampola com 10 mL.
Dose Usual	**Adultos**: 1-5mcg/kg/min, EV. **Crianças**: 1-20mcg/kg/min, EV. (Dose máx. Adultos e crianças: 50mcg/kg/min).

Folha: 313

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão Em BI	Sim	**Diluição padrão:**	1,25 – 3,2 mg/mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	Conforme dose
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	24h. Descartar sobras da ampola.
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Aciclovir, cefepime, furosemida, indometacina, insulina regular, tiopental, anfotericina B, bicarbonato de sódio, ampicilina, benzilpenicilina, tiopental, sais de ferro, gentamicina, lansoprazol.			
Interações medicamentosas	Fenitoína: pode levar a convulsões, hipotensão e bradicardia; Aumento do efeito da dopamina: bloqueadores adrenérgicos alfas e adrenérgicos, antidepressivos tricíclicos, anestésicos gerais. Pode haver ↓ de efeito da dopamina por: clorpromazina, haloperidol, fenitoína. Outras interações registradas com: Amitriptilina, ergotamina, fenitoína, linezolida, metildopa, nortriptilina, selegilina.			

Folha: 314

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Taquicardia, angina, náusea, palpitação, vasoconstrição, hipotensão, cefaleia, midríase, poliúria, ansiedade, extra- sistolia, alargamento de QRS, vômito, hipoxia, aumento de shunt intrapulmonar, pode piorar isquemia de extremidade e função renal, necrose tecidual (se infiltrar), dispneia, hipocalemia, parestesia, câimbra nas pernas, vasoconstrição, bradicardia.
Observações	Usar bomba de infusão. Não utilizar se a solução apresentar alteração de cor. Administrar em acesso central. Não utilizar com soluções alcalinas. Uma coloração amarelocastanha na solução é indicativo de sua decomposição, não devendo ser utilizada. Soluções escuras e amareladas não devem ser utilizadas. A administração deve ser interrompida gradualmente para evitar o aparecimento de hipotensão aguda. Restrição hídrica: metade do volume de diluição (500mg em 150 mL). Reduzir a dose em uso de IMAO Evitar infusão em cateter umbilical (não usar em artéria umbilical). Compatível com dobutamina, epinefrina, isopreterenol, lidocaína, atracúrio, vecurônio. Risco de isquemia renal (choque, pós-CEC)/ síndrome de baixo débito/ hipotensão com RVS diminuída.

ENOXAPARINA SÓDICA	
Classe farmacológica	Agente anticoagulante, heparina de baixo peso molecular.
Apresentação	Seringa preenchida de 20mg/0,2mL e 40mg/0,4mL

Folha: 315

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="3">Adultos: Profilaxia de tromboembolismo durante procedimento cirúrgico geral, em pacientes com risco moderado: 20mg, SC, 2h antes da intervenção. Em pacientes com alto risco: 40mg, SC, 12h antes da intervenção. Tratamento da trombose venosa profunda e angina instável: 1mg/kg, SC, a cada 12h. Prevenção da formação de coágulos, em procedimentos de hemodiálise: 1mg/kg, injetado na linha arterial do circuito, no início da sessão de hemodiálise.
Dose máx. adultos: 1mg/kg, 2x dia.
Crianças: Terapêutica (TVP): 1.5mg/kg/dose a cada 12 horas (< 2meses); 1mg/kg/dose a cada 12 horas (≥ 2meses); Profilaxia (TVP): 0.75mg/kg/dose a cada 12 horas (< 2meses); 0.5mg/kg/dose a cada 12 horas (≥ 2meses).
Dose máx. crianças: (≥ 2meses): 1mg/kg, 2x dia.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="3">Não. Solução pronta para uso.</td></tr>
<tr><td>Vias de administração</td><td>SC</td><td colspan="2">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="3">Enoxaprina pode ↑ os níveis de: anticoagulantes, colagenases.
Níveis de enoxaparina podem ↑ por: 5-ASA- derivados, agentes plaquetários, AINES, pentoxifilina, prostaciclina, agentes trombolíticos, salicilatos.
Cetorolaco: afeta a hemostasia.</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos</td><td colspan="3">Edema, febre, hiperlipidemia, náusea, hemorragia, trombocitopenia, elevação de enzimas hepáticas (assintomático), equimose, dor, eritema e irritação local; rash, urticária, constipação, vômito, retenção urinária, anemia, hematoma, tontura, cefaleia, insônia, confusão, vasculite cutânea, necrose de pele no local ou em local distante da injeção, hematúria.</td></tr>
</table>

Folha: 316

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observações	Usar com cautela em pacientes com história de ulceração gastrointestinal e hemorragia. Diminuir a dose em pacientes com disfunção renal severa, baixo peso. Deverá ser administrado por via subcutânea, na região ânterolateral do abdômen, alternando a cada aplicação os lados direito e esquerdo. Se for utilizada a enoxaparina em pacientes em diálise, as dosagens devem ser reduzidas e os níveis de anti-Xa monitorizado frequentemente. Via preferencial: SC. Se houver bolha de ar na seringa, não retirála (inerte). Monitorar risco de sangramento. A via EV não é utilizada rotineiramente na Institui- ção. Uma única dose pode ser administrada EV, diluída SF ou SG, ACM, como parte do tratamento para infarto do miocárdio com elevação de ST, em pacientes < 75 anos. Antídoto: protamina (cada 1 mg neutraliza 1 mg de enoxaparina) - neutraliza em grande parte, se enoxaparina administrada nas primeras 8h.

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO	
Classe farmacológica	Antiespasmódico / Anticolinérgico
Apresentação	Solução injetável de 20mg/mL, ampola com 1 mL.
Dose Usual	**Adultos (maiores de 12 anos):** Via EV, IM ou SC: 20 a 40mg (1 a 2 ampolas). (Dose máx. adultos: 100mg/dia). **Crianças:** Via EV, IM ou SC: Em casos graves, 0,3 a 0,6mg/kg. (Dose máx. crianças: 1,5mg/kg/dia).
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.

Folha: 317

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td>SC</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>20mg/10mL de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, AD</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>2-3 min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Não</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>8h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>Interações medicamentosas</td><td colspan="4">Analgésicos, opióides, anti-histamínicos, antidepressivos ou sedativo-hipnóticos: depressão aditiva do SNC.
Anti-histamínicos, antidepressivos tricíclicos, inibidores MAO, haloperidol, fenotiziana, disopiramida ou quinidina: efeitos anticolinérgicos aditivos.</td></tr>
<tr><td>Eventos adversos</td><td colspan="4">Boca seca, alterações na produção de suor (disidrose), alterações de visão, taquicardia, retenção urinária, tontura, hipotensão, rash cutâneo, constipação, perda de paladar, náusea, midríase, dispnéia, cefaleia, insônia, confusão mental, reações anafilactóide, choque, reações psicóticas agudas (crianças e idosos), bradicardia, fadiga, ciclopegia, fotofobia, euforia, inquietação, agitação, tremores, fraqueza, febre, diarreia, vômito, disfagia, nariz e garganta seca, hemorragia intracraniana e depressão do SNC no recém- nato antes do trabalho de parto.</td></tr>
</table>

Folha: 318

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observações	Esse medicamento é contra-indicado para uso por idosos especialmente sensíveis aos efeitos secundários dos antimuscarínicos, como secura da boca e retenção urinária. Contraindicação: glaucoma de ângulo fechado, Síndrome de Down, obstrução urinária ou intestinal, íleo paralítico, miastenia, tireotoxicose, ICC, arritmia cardíaca

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA				
Classe farmacológica	Antiespasmódico, anticolinérgico.			
Apresentação	Solução injetável 4+500mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	5 mL, até 2 - 3x/dia, SN			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1 amp/15mL de diluente
			Diluente:	SF, SG, AD
			Tempo de infusão:	10min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1amp/250mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Heparina, hidrocortisona, KCl, propofol, fentanila, metadona, morfina.			

Folha: 319

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Amitriptilina, imipramina, anlodipino, atenolol, atropina, biperideno, captopril, carbi- dopa/levodopa, carbonato de lítio, carvedilol, ciclosporina, citalopram, clopidogrel, cloreto de potássio, ipratrópio, clorpromazina, clortalidona, clozapina, digoxina, diltia-zem, duloxetina, enalapril, espironolactona, felodipino, fluoxetina, fosinopril, furose- mida, glibenclamida, glimepirida, haloperidol, hidroclorotiazida, indapamida, levo- floxacino, lisinopril, metformina, metoprolol, metotrexato, nimodipino, paroxetina, perindopril, propranolol, sertralina, varfarina, venlafaxina, verapamil.
Eventos adversos	Boca seca, sonolência, visão borrada, agitação, palpitação.
Observações	-

ETILEFRINA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Agente simpatomimético			
Apresentação	Solução injetável de 10mg/mL, ampola com 1 mL.			
Dose Usual	**Adultos:** 1 ml (Via IM e SC) **Crianças:** de 6 a 14 anos: 0,7-1 ml; de 2 a 6 anos: 0,4-0,7 ml; menores de 2 anos: 0,2-0,4 ml. Caso necessário, a dose deve ser repetida a intervalos de 1-3 horas. Dose máx.: Adultos e crianças maiores de 6 anos: 50 mg/dia; Crianças de 2 a 6 anos: 40 mg/dia; Crianças menores de 2 anos: 30 mg/dia			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
			Diluição padrão:	1 ampola para 40mL de diluente
			Diluente:	SG, SF, SRL

Folha: 320

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV infusão	Sim	**Tempo de infusão:**	Crianças < 2 anos: 0,1 mg/min (0,05 – 0,2 mg/min) Crianças 2 -6 anos: 0,2 mg/min (0,1 a 0,4 mg/min) Adultos e crianças maiores de 6 anos: 0,4 mg/min (0,2-0,6 mg/min)
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Interações medicamentosas	O efeito da etilefrina: guanetidina, mineralocorticóides, simpaticomiméticos, antidepressivos triciclicos e inibidores da MAO. ↑ o efeito da etilefrina sobre o coração: hidrocarbonetos alifáticos halogenados, causando arritmias cardíacas. Suprime os efeitos da etilefrina: agentes bloqueadores adrenérgicos.			
Eventos adversos	Palpitações, taquicardia, ansiedade, sudorese, insônia, náuseas, tremores e sensação de pressão craniana.			

FITOMENADIONA				
Classe farmacológica	Protrombinogênica			
Apresentação	Solução injetável 10mg/mL, ampola com 1 mL			
Dose Usual	**Adultos**: 10 mg/dose, IV, não exceder 50mg em 24h. **Crianças:** > 1 ano: 2-10mg, IV. < 1 ano: 2 mg (apenas quando não houver possibilidade de VO)			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim (apenas a formulação específica, verificar rótulo antes de administrar)		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	No mínimo 30 seg.
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	8h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Fenitoína, amobarbital, cianocobalamina, dobutamina.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Interações medicamentosas	Varfarina (antídoto). Anticoagulantes cumarínicos: fitomenadiona pode diminuir efeito anticoagulante de derivados cumarínicos. Anticoagulantes orais: possível redução efeito dessas drogas.			
Eventos adversos	Dor e edema no local, vasodilatação, cianose, hipotensão, náusea, ↑ bilirrubina, hemólise, anafilaxia, dispneia, anemia hemolítica, flebite, hematoma muscular, hemoglobinúria, broncoespasmo, colapso respiratório ou circulatório, tontura, suor profuso, eritema.			
Observações	Injetável: IV (não pode ser administrada por via IM). A solução não deve ser diluída e nem misturada com outros medicamentos injetáveis, mas pode ser injetada, quando apropriado, na parte inferior do equipo de infusão, durante a infusão de SF ou SG5%. Tempo de infusão: Injeção direta lenta, em pelo menos 30seg. A fitomenadiona é altamente sensível. A exposição à luz causa degradação da substância e perda de efeito. As ampolas devem permanecer na caixa até o momento da administração. Uso imediato. Descartar o que restar na ampola.			
FLUCONAZOL				
Classe farmacológica	Antifúngico			
Apresentação	Solução injetável 2mg/mL, bolsa de 100mL			
Dose Usual	**Adultos:** EV: 200-800mg EV 1xdia. **Crianças:** 3-12 mg/kg/dia. (Dose máx. crianças: 12mg/kg/dia).			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**EV infusão**	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	60-120 min (não exceder 200mg/h) Crianças: 2h
			TA:	Não se aplica

Folha: 322

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Reconstituído**	**R:**	Não se aplica
	Diluido	**TA:**	24h
		R:	Não se aplica. Descartar sobras
Incompatibilidade	Ampicilina, anfotericina B, cefotaxima, ceftazidima, cefuroxima, clindamicina, ceftri- axona, hidroxizina, diazepam, furosemida, gluconato de cálcio, imipeném, haloperidol, sulfametoxazol + trimetoprima.		

Interações medicamentosas	Agentes antiadiabéticos orais: fluconazol reduz o metabolismo e ↑ a concentração do tolbutamida, glipizida. Varfarina: ↑ o tempo de protrombina. Fluconazol: ↑ a concentração plasmática de ciclosporina, tacrolimas, midazolam, teofilina, zidovudina, cisaprida. Em pacientes em uso concomitante de fluconazol e cisaprida: pode ocorrer arritmia fatal que inclui taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, prolongamento do QT (eletrocardiograma). Rifampicina: ↑ o metabolismo do fluconazol (considerar o ajuste da dose de fluconazol). Antagonismo pode ocorrer se o fluconazol e anfotericina B forem usados concomitantemente. Hidroclorotiazida, ritonavir e ciclosporina: ↑ os efeitos do fluconazol. Outros registros de interação com Algestona+estradiol, alprazolam, aminofilina, amiodarona, amitriptilina, anfotericina B, anlodipino, atorvastatina, carbamazepina, celecoxibe, ciclofosfamida, ciclosporina, cilostazol, cimetidina, citarabina, claritromicina, clonazepam, clorpromazina, desogestrel+etinilestradiol, dexametasona, diltiazem, enflurano, felodipino, fenitoína, fentanila, finasterida, fluoxetina, gestodeno+etinilestradiol, glibenclamida, glimepirida, haloperidol, hidroclorotiazida, hidroclorotiazida+amilorida, isoflurano, levofloxacino, losartana, lovastatina, metilprednisolona, midazolam, nevirapina, noretisterona+estradiol, nortriptilina, octreotida, pravastatina, prednisolona, prednisona, rifampicina, risperidona, ropivacaína,
	rosuvastatina, sildenafila, sinvastatina, sotalol, sulfametoxazol+trimetoprima, varfarina, venlafaxina, verapamil, zidovudina, zolpidem.

Folha: 323

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Eventos adversos	Náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, cefaleia, convulsões, dermatite, rash, SSJ, hepatotoxicidade, ↑ das transaminases, hepatite, colestase, ↑ fosfatase alcalina, trombocitopenia, leucopenia, anafilaxia, angioedema, QT prolongado (eletrocardiograma), vertigem, hipocalemia, hipercolesterolemia, ↑ triglicerídeos, dispepsia, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, agranulocitose, alopecia, prurido, distúrbio de paladar, flatulência.
Observações	Induz a insuficiência renal e hepatotoxicidade em tratamento prolongados. Proteger as sobras do frasco ou bolsa com embalagem laminada. Não necessita de equipo fotossensível para infusão. Não é necessário uso exclusivo de equipo/bureta. Sofre perda na hemodiálise. Ajuste em pacientes com IR. Administrar por infusão EV a uma velocidade não superior a 200 mg/ hora. Em pacientes pediátricos recebendo dose > ou = 6 mgkg/dia, administrar em 2h. Não usar soluções precipitadas ou turvas. Ajustar para função renal. Hemodiálise: diminuem em 50% a concentração plasmática.

FUROSEMIDA	
Classe farmacológica	Diurético de alça
Apresentação	Solução injetável 10mg/mL, ampola com 2mL

Folha: 324

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos:
20- 40mg, EV ou IM, podendo ser repetida em intervalos de 2h, de 20mg/dose até obter o efeito desejado (intervalo usual é de 6-12h). Edema pulmonar agudo: 40mg, EV, se a condição do paciente requerer, injetar uma dose adicional de 20 a 40 mg de furosemida (1 a 2 ampolas) após 20 minutos. Dose máx. 1,5g/dia
Crianças:
EV ou IM, 1mg/kg de peso corporal.
Dose máx. 40mg/dia.</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não. Solução pronta para uso.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>Se diluir: 1mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>AD</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>1-2 min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1-2mg/mL de diluente</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>Adultos: 4mg/min Crianças: 0,5mg/kg/min</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">Diluido</td><td>TA:</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Azitromicina, vecurônio, anrinona, ciprofloxacino, cálcio, cefalosporinas, clorpromazina, diltiazem, dopamina, dobutamina, fluconazol, gentamicina doxapram, esmolol, hidrocortisona, Mg^{2+}, hidralazina, meperidina, metoclopramida, idarrubicina, midazolan, morfina, ondansetrona, ticarcilina, vancomicina, tiopental, prometazina, isoproterenol, droperidol, filgrastima, milrinona, vinblastina, vincristina.</td></tr>
</table>

Folha: 325

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	AINES: bloqueia parcialmente o efeito diurético. Indometacina: ↓ o efeito da furosemida, Lítio: ↓ a excreção de lítio e o risco de toxicidade. Antidiabéticos: ↓ a tolerância a glicose (hipoglicemia). Agentes hipotensivos: podem ↑ o efeito hipotensor. Aminoglicosideos: ↑ da ototoxicidade Digitálicos: ↑ da toxicidade Varfarina: ↑ o efeito anticoagulante. Salicilatos: ↑ toxicidade do salicilato e ↓ a excreção.
Eventos adversos	Hipotensão ortostática, cefaleia, vertigem, tontura, hipovolemia excessiva, urticária, fotosensibilidade. Distúrbios eletrolíticos: hipopotassemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipocloremia, alcalose metabólica, desidratração, hiperuricemia, ototoxicidade, nefrotoxicidade (potencializada pelos aminoglicosídeos), pancreatite aguda, câimbra, agranulocitose, anemia, trombocitopenia, isquemia hepática, icterícia. Em prematuros uso prolongado (pela hipercalciúria): pode causar nefrocalcinose, osteopenia e hiperparatireoidismo secundário.
Observações	Administração EV direta pode ser realizada com ou sem diluição. Para a diluição para infusão, de preferencia diluir em SF.

Folha: 326

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

GLICOSE				
Classe farmacológica	Repositor eletrolítico			
Apresentação	Solução injetável 25 e 50%, ampola com 10mL			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1:1
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	Lentamente
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	ACM
			Diluente:	SF, SG, SRL, AD
			Tempo de infusão:	Até 24h
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	24h (com soro)
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Fenitoina, ampicilina.			
Interações medicamentosas	Corticóides			
Eventos adversos	Febre, confusão, náusea, hiperglicemia, hiperosmolaridade, acidose, taquipneia, edema pulmonar, polidipsia, esclerose, trombose de veias quando se usa soluções acima de 25% em bolus ou acima de 12,5% em infusão contínua por tempo prolongado; administração rápida de glicose hipertônica do prematuro extremo pode causar mudança súbita da osmolaridade e hemorragia intracraniana, dor local, irritação da veia, flebite, hipovolemia, hipervolemia, desidratação, edema, necrose do tecido, inconsciência, confusão mental, hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, poliúria, glicosúria, cetonúria.			
Observações	Glicose 25% contém 25 g de glicose em 100 ml ou 2,5 g em 10 ml. Glicose 50% contém 50 g de glicose em 100 ml ou 5g em 10ml. Contraindicação: cetoacidose diabética. Não usar solução hipertônica em pacientes com hemorragia do SNC, delirium tremens com desidratação e no coma hepático, anúria, desidratação, síndrome da má absorção glicose-galactose.			

Folha: 327

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

GLICONATO DE CÁLCIO				
Classe farmacológica	Repositor eletrolítico			
Apresentação	Solução injetável 10%, ampola com 10mL			
Dose Usual	ACM			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1:1
			Diluente:	SG
			Tempo de infusão:	3-5 min (max. 50-100mg/min)
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	50mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	120-240mg/kg em 1h (0,61,2mEq em 1h). Ou ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	24h (com soro), descartar sobras na ampola.
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Bicarbonatos, fosfatos e sulfatos, a mistura resultará em precipitação.			
Interações medicamentosas	Digoxina: pode potencializar a toxicidade digitálica. Pode antagonizar os efeitos bloqueadores do canal de cálcio.			
Eventos adversos	Bradicardia até assistolia em caso de administração rápida, vasodilatação, hipotensão, bradicardia, arritmias, síncope, hipofosfatemia, hipercalciúria, hipomagnesemia, aumento de amilase, náusea, vômito, obstipação, secura na boca (xerostomia), fraqueza muscular, esclerose de veia, necrose tecidual em caso de infiltração, zumbido, letargia, coma, eritema, hipercalcemia			
Observações	Contraindicado em casos de cálculo renal e fibrilação ventricular			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

HEPARINA SÓDICA					
Classe farmacológica	Anticoagulante				
Apresentação	Solução injetável de 5.000U.I/mL (frasco com 5mL) Solução injetável de 5.000U.I./0,25mL (via SC)				
Dose Usual	**Adultos:** Nas doenças tromboembolíticas: Dose inicial: 5.000 - 10.000 UI EV, seguida de infusão contí- nua de 15 - 24 UI/Kg/h. Na síndrome coronariana aguda: 5.000 UI em bolus EV, seguido de 12 UI/Kg/h até 1.000 UI em infusão contínua por 48h. Heparina SC: Profilaxia: iniciar 2 horas antes do procedimento cirúrgico 5.000UI, SC, a cada 8-12h. A posologia deve ser ajustada ACM. **Crianças:** Profilaxia para cateterismo cardíaco (abordagem arterial): IV: Bolus: 100 unidades/kg. Heparinização sistêmica: EV Intermitente: inicial: 50-100 unidades/kg, em seguida, 50-100 unidades/kg a cada 4 horas; infusão EV: dose inicial: 75 unidades/kg dadas ao longo de 10 minutos, em seguida dose de manutenção inicial: 20 unidades/kg/hora, ajustar a dose para manter TTPA de 60-85 segundos.				
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.				
Vias de administração	**IM**	Não			
	SC	Sim (somente a apresentação 5.000U.I./0,25mL)			
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-	
			Diluente:	-	
			Tempo de infusão:	ACM	
	EV	Sim	**Diluição padrão:**	Até 100U.I./mL	
	infusão em BI		**Diluente:**	SF, SG	
			Tempo de infusão:	ACM	
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica	
			R:	Não se aplica	
	Diluido		**TA:**	24h	
			R:	Não se aplica	

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Incompatibilidade	Alteplase, anfotericina B, cprofloxacino, amiodarona, daunorrubicina, idarrubicina, diazepam, fenitoína, filgrastim, haloperidol, doxiciclina, ácido hialurônico, eritromicina, levofloxacino, amicacina, estreptomicina, gentamicina, tobtamicina, ergotamina.
Interações medicamentosas	↑ o risco de hemorragia: ácido acetilsalicílico, AINES, dextrano, antagonista de vitamina K, penicilinas, corticóides, outros anticoagulantes orais. ↓ do efeito da heparina: antihistamínicos, nitroglicerina (altas doses), digitálicos, nicotina, tetraciclina, digoxina. Outros resgistros incluem: Abciximabe, alprostadil, alteplase, citalopram, clopidogrel, desvenlafaxina, enoxaparina, estreptoquinase, fluoxetina, sertralina, varfarina, venlafaxina, indometacina, nitroglicerina.
Eventos adversos	Hemoragia, choque hemorrágico, febre, cefaleia, náusea, vômito
Observações	Inverter a bolsa a cada 4 horas, pelo menos 6 vezes, a fim de prevenir a aglomeração de heparina na solução. A presença de álcool benzílico na formulação de Heparina EV pode desencadear eventos adversos, sendo portando não recomendado o uso via SC. Além disso, usar com precaução em neonato devido o risco aumentado de toxicidade. **Via SC usar a apresentação 5.000U.I./0,25mL, exclusiva para SC.** Dose para manter permeabilidade de acesso central e periférico: 0,5 (preferir esta dose em neonatos) a 1,0 UI/ml de fluido. Solução padrão para heparinização de cateter: - 0,5 ml de heparina (2.500UI) em 250 ml de SF. Desta solução utilizar apenas o volume necessário (3 vezes o volume de preenchimento do cateter). Antídoto: protamina (1 ml inativa 1000 UI de heparina).

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

HIDRALAZINA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Vasodilatador			
Apresentação	Solução injetável 20mg/mL, ampola com 1mL			
Dose Usual	**Adultos:** Hipertensão grave: 5 - 40 mg IM ou EV. (Dose máx.: 20 mg) **Crianças:** Hipertensão: 1,7 - 3,5 mg/kg/dia IM ou EV, em 4 a 6 aplicações			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1 ampola para 20ml
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	Lento
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	3 h na seringa (proteger da luz
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	SG 5%, aminofilina, ampicilina, furosemida, nitroglicerina			
Interações medicamentosas	Furosemida, diázoxido, moclobemida, selegilina, indometacina, metilfenidato, metoprolol, propranolol, rituximabe, amifostina.			
Eventos adversos	Hipotensão, cefaléia, palpitação, exa- cerbação da angina, taquicardia. Avaliar edema, hipocalemia, débito cardíaco. Monitorar PA e frequência cardíaca após administração.			
Observações	-			

Folha: 331

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO				
Classe farmacológica	Corticóide			
Apresentação	Pó para solução injetável de 100mg e 500mg			
Dose Usual	**Adultos:** Anti-inflamatório e imunossupressor: 100-500mg, EV ou IM, a cada 2, 4 ou 6h. Insuficiência adrenocortical: 100mg, EV, dose única, seguida de 100mg, EV ou IM, 8/8h. Choque séptico: 50mg, EV, 6/6h. **Crianças:** Anti-inflamatório e imunossupressor: 1-5mg/kg/dia ou 30150mg/m²/dia, EV ou IM, a cada 12 ou 24h. Insuficiência adrenocortical: 186-280mcg/kg/dia ou 1012mg/m²/dia, EV ou IM. Choque séptico: 1-2mg/kg/dia, EV.			
Reconstituição	Sim. 100mg em 2mL e 500mg em 4mL de AD			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	50mg/mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1-5mg/mL de diluente
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	20-30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	24h
			R:	48h
	Diluído		**TA:**	12h
			R:	24h
Incompatibilidade	Midazolam, ciprofloxacino, dobutamina, fenobarbital, hidantoína, fenitoína, sulfametoxazol+trimetropima, doxorrubicina, idarrubicina, dacarbazina, diazepam, metilprednisolona, prometazina.			

Folha: 332

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Barbitúricos, fenitoína, rifampicina, salicilatos, AINEs, diuréticos poupadores de potassio, anfotericina B, clortalidona, furosemida, hidroclorotiazida, AAS, atracúrio, pancurônio, rocurônio, neostigmina, tretinoína, carbamazepina, colestiramina, fenobarbital, fenitoína, primidona, ciprofloxacino, levofloxacino, norfloxacino, anti-concepcionais orais, itraconazol, vacinas, femprocumona, varfarina.
Eventos adversos	Hiperglicemia, hipertensão, edema (retenção de água e sal), euforia, insônia, cefaleia, vertigem, convulsão, psicose, hipocalemia, síndrome de Cushing, úlcera péptica, gastrite, náusea, vômitos, reação anafilactóide, queda na densidade mineral óssea, estrias, imunodepressão, supressão do eixo hipófise-adrenal.
Observações	Contraindicação: infecções não controladas, sobretudo herpes, varicela, tuberculose, fungos. **Proteger sobras e solução da luz.** Pode aumentar a hepatotoxicidade com o uso de paracetamol. Atentar para uso em pacientes idosos com doença cardíaca, renal, hepáti- ca, diabetes ou imunossupressão. As soluções somente podem ser utilizadas se estiverem límpidas.

INSULINA NPH HUMANA		
Classe farmacológica	Regulador de glicemia	
Apresentação	Solução injetável de 100U.I./mL, ampola com 10mL	
Dose Usual	ACM	
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.	
Vias de administração	**IM**	Não (Insulina regular)
	SC	Sim (Insulina NPH)

Folha: 333

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1 UI/mL
	(Insulina Regular)		**Diluente:**	SF
			Tempo de infusão:	ACM
	EV infusão (Insulina Regular)	Não	**Diluição padrão:**	0,05 - 1 UI/ mL Na hiperpotassemia: 10 UI e m 25 g de glicose (50 mL)
			Diluente:	SF Na hiperpotassemia: 500 mL SG 10%
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	-
			R:	-
	Diluido		**TA:**	-
			R:	-
Incompatibilidade	Aminofilina, amobarbital, norepinefrinaa, citarabina, dopamina, clorotiazida, fenitoína, fenobarbaital, metilprednisolona, tiopental.			
Interações medicamentosas	Atenolol, carvedilol, ciprofloxacino, clonidina, esmolol, fluoxetina, levotiroxina, lítio, norfloxacino, pentamidina, ginkgo biloba, ginseng, glucomanan, hypérico, moclobemida, octreotida, selegilina.			
Eventos adversos	Hipoglicemia (manifestada por sudorese, fome, calor, cefaleia, pele fria e úmida, fraqueza, alterações da visão, náusea, vômito, taquicardia, vertigem, perda do auto-controle, sensação de risco iminente, tremores, tontura, desmaio, bradicardia e coma), aumento de peso, edema, palpitação, prurido, lipodistrofias, resposta inflamatória, hipocalemia, perda da consciência, confusão mental, visão borrada, hipocalemia, reação no local da aplicação ou hipersensibilidade sistêmica (rash, angioedema, dispnéia, colapso vascular, hipotensão).			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Observações	**Insulina NPH:** É a insulina de ação prolongada. Deve ser armazenada sob refrigeração. Não congelar. Somente via SC. No uso concomitante: aspirar antes a insulina regular, trocar agulha, para não contaminar o frasco e por último aspirar a insulina NPH. Frasco multi-dose, realizar assepsia antes de aspirar o medicamento. Auteração de cor pode indicar contaminação. Não administrar EV ou IM **Insulina regular:** É a insulian de ação mair curta e a única que pode ser administrada EV. Armazenar sob refrigeração, sem congelar. Insulina regular deve ser clara e incolor. Armazenar sob refrigeração. Não congelar. Trocar equipo e solução a cada 24 h devido à adsorção do medicamento à superfície da embalagem. Saturar o equipo com insulina por 30 min antes da infusão para evitar adsorção.

IOVERSOL				
Classe farmacológica	Meio de contraste não iônico			
Apresentação	Solução injetável 68%, ou seja, 678mg/mL, frasco com 50mL			
Dose Usual	Varia conforme o tipo de exame e idade do paciente.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**Intrao-arterial**	Sim		
	Intra-articular	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	Não necessário
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**	**TA:**	Não se aplica	
		R:	Não se aplica	
	Diluido	**TA:**	Não se aplica	
		R:	Não se aplica	
Incompatibilidade	-			

Folha: 335

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Toxicidade renal foi relatada em alguns pacientes com disfunção hepática que receberam agentes colecistográficos por via oral, seguido de agentes de contraste por via intravascular. A administração de qualquer agente de contraste por via intravascular deve ser adiada em pacientes que receberam recentemente agentes de contraste colecistográficos. Outras medicações não devem ser misturadas com a injeção de ioversol.
Eventos adversos	Náusea, dor de cabeça, angina pectoris, hipotensão, flutuação da pressão arterial, espamo arterial, bradicardia, defeito de condução, falso aneurisma, hipertensão, arritmia transitória, trauma vascular, vômito, boca seca, infarto cerebral, visão turva, vertigem, alucinações visuais, reação vasovagal, desorientação, parestesia, disfasia, espasmo muscular, síncope, edema de laringe, edema pulmonar, espirro, congestão, tosse, respiração encurtada, hipóxia, edema periorbital, urticária, prurido, edema facial, rubor; eritema, extravasamento, hematoma, calafrios, gosto ruim, dor generalizada, cólica renal, febre, poliúria, retenção urinária.
Observações	O teor de iodo organicamente ligado é de 47,2%. O ioversol é não-iônico e não se dissocia em solução.

ISOSSORBIDA, MONONITRATO				
Classe farmacológica	Nitrato			
Apresentação	Solução injetável 10mg/mL, ampola com 1mL			
Dose Usual	**Adultos:** 20-80mg, EV direto, a cada 8-12h; 0,8mg/kg, EV contínuo, a cada 8-12 horas; 10-20mg, Intracoronária.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	10mg/100mL
			Diluente:	SF, SG

Folha: 336

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	2 a 3 h
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	24h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Anti-hipertensivos, anti-histamínicos, sildenafila			
Eventos adversos	Cefaleia, náusea e hipotensão.			
Observações	Pode haver tolerância a nitratos após exposição crônica. A tolerância pode ser controlada com períodos curtos sem administração de nitratos.			

LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Anestésico			
Apresentação	Solução injetável de 0,5%, 5mg/mL. Frasco ampola com 20mL (s/ vaso). Solução injetável de 0,5%, 5mg/mL. Frasco ampola com 20mL (c/ epinefrina – 5mcg/mL).			
Dose Usual	Dependente do tipo de procedimento. Dose máx.: Doses peridurais de até 375mg têm sido administradas, em doses Bloqueio intraoperatório e controle da dor pós- operatória: 695mg. Infusão peridural pós-operatória: 570mg. Bloqueio do plexo braquial: como injeção fracionada única, foi de 300 mg.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**Uso peridural ou bloqueio plexo braquial**	Sim	**Diluição padrão:**	0,625 - 2,5mg/mL de diluente
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	ACM
		TA:		Não se aplica

Folha: 337

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Reconstituído**	**R:**	Não se aplica
	Diluido	**TA:**	24h
		R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Bicarbonato de sódio, soluções alcalinas		
Interações medicamentosas	Efeitos aditivos com outros anestésicos locais: derivados de amidas.		
Eventos adversos	Febre, tontura, cefaleia, náusea, vômito, dores no dorso, hipoventilação, apneia, broncoespasmo, edema pulmonar, hipotensão, síncope, arritmias cardíacas, espasmo muscular generalizado, reações alérgicas.		
Observações	Uso EV contraindicado		

LIDOCAÍNA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Anestésico/Antiarrítimico			
Apresentação	Solução injetável de 2%, 20mg/mL. Frasco ampola com 20mL (s/ vaso). Solução injetável de 2%, 20mg/mL. Frasco ampola com 20mL (c/ epinefrina – 5mcg/mL).			
Dose Usual	Como anesésico local: 5 - 300 mg Como Antiarrítmico: **Adultos:** ataque: 1 mg/Kg manutenção: 1 - 4 mg/min **Crianças:** ataque: 1 mg/Kg manutenção: 20 - 50 mcg/Kg/min			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	Lento
	EV infusão	SIm	**Diluição padrão:**	1-2mg/mL
			Diluente:	SF, SG, RL

Folha: 338

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	Infusão contínua *sem vasoconstritor

Folha: 339

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Reconstituído**	**TA:**	Não se aplica
		R:	Não se aplica
	Diluído	**TA:**	24h
		R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ampicilina, anfotericina B, bicarbonato de sódio, cefazolina, cefotaxima, epinefrina, fenitoína, metoprolol, norepinefrina, tiopental.		
Interações medicamentosas	Atracúrio, ciprofloxacino, fenitoína, levofloxacino, metoprolol, norfloxacino, ofloxacino, propofol, propranolol, sotalol.		
Eventos adversos	Crises de ausência, nervosismo, apreensão, euforia, confusão, vertigem, sonolência, zumbido, visão nebulosa ou dupla, vômitos, sensação de calor, frio ou entorpecimento, contrações, tremores, convulsões, inconsciência, depressão e parada respiratória, parada respiratória, bradicardia, hipotensão e colapso cardiovascular, lesões cutâneas, urticária, edema ou reações anafilactoides, dor de cabeça postural, hipotensão, dor nas costas, náusea, respiração inadequada e visão dupla.		
Observações	O medicamento com vasoconstritor não deve ser usado em dedos, pênis, nariz ou orelha por risco de isquemia. O uso EV deve ser sem vasoconstritor. O uso EV contínuo requer monitorização cardíaca. Usar bomba de infusão. A validade após aberto dependerá das técnicas assépticas de manipulação do mesmo. Outras vias: SC, intratecal, epidural Para tratamento de arritmias, formulação com epinefrina não deve ser utilizada. O remanescente no frasco ampola permanece estável 72 horas, mantando-se as condições assépticas de manipulação.		

Folha: 340

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

METILPREDNISOLONA, ACETATO				
Classe farmacológica	Corticóide			
Apresentação	Pó para solução injetável de 40mg			
Dose Usual	Antiinflamatório ou imunossupressor: 10 - 80 mg a cada 1 ou 2 semanas Intra-articular: varia com o local: 4 - 80 mg a cada 1 - 5 semanas Intralesional: 20 - 60 mg			
Reconstituição	Sim. Reconstituir 40mg em 1 mL de diluente próprio.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	-			
Eventos adversos	Efeitos de uso agudo: hipertensão, vertigem, convulsão, psicose, cefaleia, insônia, náusea, gastrite, hipopotassemia, alcalose, hiperglicemia, inibição da cicatrização, urticária, reação anafilática.			
Observações	Não usar EV. Reconstituir no momento da administração. Evitar a aplicação no deltóide (incidência de atrofia muscular). Não injetar em áreas com evidência de infecção aguda local. Usar o medicamento com cautela, devido aos efeitos colaterais. Outras vias: Intra-sinovial (peri-articular, intrabursal) e intralesional, in- traretal			

Folha: 341

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SÓDICO				
Classe farmacológica	Corticóide			
Apresentação	Pó para solução injetável de 125mg e 500mg			
Dose Usual	**Adultos:** Afecções reumáticas: 1g, EV, 1 vez/dia, por 1-4 dias ou 1g, EV, 1 vez/mês, por 6 meses. Lúpus eritematoso: 1g, EV, 1 vez/dia, por 3 dias. Esclerose múltipla: 1g, EV, 1 vez/dia, por 3-5 dias. Estados edematosos: 30mg/kg, EV, 48/48h, por 4 dias ou 1g, EV, 1 vez/dia, por 3-7 dias. Prevenção de náusea/vômito associado à quimioterapia: 250mg, EV, doses únicas antes e depois da quimioterapia. Tratamento auxiliar em outras indicações: 10-500mg, EV, por até 48-72h. **Crianças:** 0,5-1,7mg/kg, EV, 1 vez/dia ou 5-25mg/m²/dia, EV, fracionados a cada 6-12h.			
Reconstituição	Sim. Volume de reconstituição varia conforme concentração: 125mg em 2mL de AD (ou diluente próprio) 500mg em 8mL de AD (ou diluente próprio)			
Vias de administração	**IM**	Sim (diluir em 2mL)		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	até 125mg em 5 a 10mL
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	Acima de 5min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,6-10mg/mL
			Diluente:	SG, SF
			Tempo de infusão:	Mínimo de 30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	12h
			R:	2 dias
	Diluido		**TA:**	12h
			R:	24h
Incompatibilidade	Alopurinol, benzilpenicilina sódica, ciprofloxacino, ondansetrona, filgrastina, etoposido, gluconato de cálcio, insulina regular, lansoprazol, pantoprazol, propofol.			

Folha: 342

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Ácido acetil salicílico (AAS): possível ↑ da depuração dessa droga e ↑ da toxicidade salicílica. Fenitoína, efedrina, fenobarbital, rifampicina: podem ↑ o clearance da metilprednisolona. Vacina de vírus vivos: ↑ risco de infecção viral. Aumento do efeito da metilprednisolona: antifúngicos azólicos, bloqueadores de canais de cálcio, ciclosporina, estrógenos, antiácidos, AINE, AAS, talidomida, ritonavir. Diminuição do efeito da metil: fenobarbital, fenitoína, rifampicina, primidona, isoniazida. Metilprednisolona aumenta os efeitos de: saquinavir, caspofungina, fluoroquinolonas, anticoagulantes orais. Metilprednisolona diminui os efeitos de: bloqueadores neuromusculares, anticoagulantes orais.
Eventos adversos	Efeitos de uso agudo: hipertensão, vertigem, convulsão, psicose, cefaleia, insônia, náusea, gastrite, hipopotassemia, alcalose, hiperglicemia, inibição da cicatrização, urticária, reação anafilática.
Observações	Contraindicação: infecções não controladas, sobretudo herpes, varicela, tuberculose e fungos. Não deve ser usada em crianças abaixo de 1 mês, por causar a Síndrome de Gasping, pois contém álcool benzílico. Uso em transplante renal; síndrome nefrótica, rim cadáver e receptor hipersensibilizado

METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO				
Classe farmacológica	Antiemético / Prócinético			
Apresentação	Solução injetável de 5mg/m, ampola com 2mL			
Dose Usual	**Adultos:** 10mg, EV ou IM, 3 vezes/dia. Exame radiológico do trato gastrointestinal: 1-2 ampolas, EV/IM, 10 minutos antes do exame. Dose máx.: 0,5mg/kg/dia. **Crianças:** Uso injetável não recomendado para crianças.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1-2 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	10mg/50mL
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	15 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	24h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ampicilina, anfotericina B, benzilpenicilina potássica, bicarbonato de sódio, cefepime, furosemida, gluconato de cálcio, doxorrubicina lipossomal, eritromicina, lanzoprazol, pantoprazol, propofol, cloranfenicol.			
Interações medicamentosas	Levodopa; álcool; anticolinérgicos e derivados da morfina; depressores do sistema nervoso central como derivados da morfina, hipnóticos, ansiolíticos, anti-histamínicos H1 sedativos, antidepressivos sedativos, barbituratos, clonidina; neurolépticos; ciclosporina; mivacúrio e suxametônio.			
Eventos adversos	Discinesia; distonia agudas; síndrome parkinsoniana, acatisia, sonolência, confusão e alucinação, convulsões, síndrome neuroléptica maligna, depressão, diarreia, sulfaemoglubinemia, galactorreia, ginecomastia, reações alérgicas incluindo anafilaxia, astenia, hipotensão, bradicardia.			
Observações	Doses abaixo de 10mg não pecisam ser diluídas. Podem ser administradas EV direto. Respeitar o intervalo de tempo (ao menos 6 horas), entre cada administração, mesmo em casos de vômito e rejeição da dose, de forma a evitar super dosagem. A combinação de metoclopramida com levodopa é contraindicada, pois apresentam um antagonismo mútuo. Estados de ansiedade e agitação transitórias intensas, seguido de sonolência, podem ocorrer com a administração EV rápida (em menos de 3 minutos).			

Folha: 344

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

METOPROLOL, TARTARATO				
Classe farmacológica	Beta-Bloqueador			
Apresentação	Solução injetável 1mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	2-20mg Dose máx: 20mg			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	2-5 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 amp. em 100 mL [0,04 mg/mL]
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	30-60 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	-
			R:	-
	Diluido		**TA:**	12h
			R:	-
Incompatibilidade	Lidocaína, nitroglicerina.			
Interações medicamentosas	Monitorar uso concomitante com: adrenalina, ácido mefenâmico, amiodarona, anlodi- pino, atazanavir, celecoxibe, clorpromazina, citalopram, ciprofloxacino, darunavir, diltiazem, digoxina, dipirona, difenidramina, doxazosina, dobutamina, escitalopram, fluoxetina, glibenclamida, hidralazina, fenobarbital, fentanila, ibuprofeno, indometacina, insulina, lidocaína, meloxicam, metformina, naproxeno, nifedipino, nimodipino, paroxetina, verapamil.			
Eventos adversos	-			
Observações	Monitorar função cardíaca e pressão arterial. Sofre perda na hemodiálise. A administração da solução contínua não é usual na instituição. Necessita de ajuste na insuficiência hepática.			

Folha: 345

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

N-ACETILCISTEÍNA

Classe farmacológica	Mucolítico			
Apresentação	Solução injetável de 100mg/mL, ampola com 3mL			
Dose Usual	**Adultos:** dose inicial de 150mg/kg via EV em 1 hora, segunda dose de 50mg/kg em 4h, seguida por uma dose de 100mg/kg em 16 horas. Inalatório: 3mL para 3mL de SF inalatório. **Crianças:** Para uso via IM a dose deve ser reduzida à metade daquela estabelecida para adultos. Inalatório: 3mL para 3mL de SF inalatório.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	1 amp para 10-20mL
			Diluente:	SF, AD
			Tempo de infusão:	3-5 min
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Nitroglicerina e antibióticos (inativação).			
Eventos adversos	Hipersensibilidade, broncoespasmo, rinorreia, estomatite, vômito, náusea, urticária, rash, prurido, reação anafilática, taquicardia, angioedema, edema facial, hipotensão e tempo prolongado de protrombina.			
Observações	Solução injetável pode ser utilizada via inalatória. Indicado como antídoto na intoxicação por paracetamol. Via EV em intoxicações por paracetamol: 1ª dose em 1h; 2ª dose em 4h; 3ª dose 16h. 50-150mg/kg em 100-1.000 mL de SF.			

Folha: 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

NEOSTIGMINA, METILSULFATO

Classe farmacológica	Anticolinesterásico			
Apresentação	Solução injetável de 0,5mg/mL, ampola com 1mL			
Dose Usual	Reverção de curarização: **Adultos:** 0,5 - 2,5 mg a cada 1 - 3 h. Dose máxima: 5 mg **Crianças:** 0,025 - 0,08 mg/kg/dose a cada 2 - 4 h **Neonatos:** 0,025 - 0,1 mg/kg/dose			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	SC	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	0,167mg/mL
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	Lentamente
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Pode ter sua ação diminuída com: aminoglicosídeos, anestésicos locais injetáveis em altas doses, lincomicina, polimixina B, quinina, anticolinérgicos. Pode ter sua ação antagonizada por: guanedrel, guanetidina, mecamilamina, trimetofano, procainamida, quinidina.			
Eventos adversos	Crise colinérgica (broncoespasmo, hipersecreção brônquica, salivação, bradicardia, hipotensão, assistolia, bloqueio atrioventricular), anorexia, náusea, vômito, diarreia, disfagia, miose, sudorese, diplopia, lacrimejamento, fasciculação muscular, incontinência urinária e fecal, agitação, fadiga, fraqueza, confusão, alergia, rash, urticária, anafilaxia.			
Observações	-			

Folha: 347

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

NITROGLICERINA

Classe farmacológica	Nitrato orgânico vasodilatador			
Apresentação	Solução injetável de 5mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	**Adultos:** 5 mcg/min. Aumentar 5 mcg a cada 3 - 5 min, até 20 mcg/min. Se não houver resposta, aumentar 10 mcg/min em intervalos de 3 - 5 min, até atingir o efeito desejado. (Dose máx.: 200 mcg/min). **Crianças:** infusão contínua: 0,25 - 0,5 mcg/Kg/dia. Aumentar a dose em 0,5 - 1 mcg/Kg/min a cada 3 - 5 min, SN, até o máx de 5 mcg/Kg/min			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 amp (50 mg) em 250 mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Alteplase, dobutamina, fenitoína, hidralazina, levofloxacino, nitroprusseto de sódio, ampicilina, ampicilina+sulbactam, anfotericina B, diazepam, furosemida, haloperidol, sulfametoxazol + trimetoprima.			
Interações medicamentosas	Amifostina, alteplase, anti-hipertensivos, diazóxido, heparina, metilfenidato, sildenafila.			
Eventos adversos	Hipotensão, cefaléia, náusea, vômito, síncope.			
Observações	Usar equipo PVC free e bolsa trilaminada. Inverter o frasco várias vezes para assegurar a diluição uniforme do medicamento.			

Folha: 348

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

NITROPRUSSIATO DE SÓDIO

Classe farmacológica	Vasodilatador			
Apresentação	Pó para solução injetável de 50mg			
Dose Usual	**Adultos:** Crise hipertensiva: inicial 0,25 a 0,3mcg/kg/min, podendo ser aumentado para 0,5mcg/kg/min para atingir efeitos hemodinâmicos desejáveis, sendo a dose usual 3mcg/kg/min. Insuficiência cardíaca descompensada: inicial 5 a 10mcg/min, podendo ser aumentado a cada 5 minutos para atingir efeitos hemodinâmicos desejáveis, sendo a dose usual 5 a 300mcg/min. Dose máx.: Adultos: 10 mcg/kg/min ou 400mcg/min **Crianças:** Inicial 0,3 a 0,5mcg/kg/min, podendo ser aumentado para atingir efeitos hemodinâmicos desejáveis. Dose máx. crianças: 10mcg/kg/min.			
Reconstituição	Sim. Reconstituir 50mg em 2mL de diluente próprio ou SG			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	50mg em 250mL de diluente
			Diluente:	SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	4h (proteger da luz)
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	24h (proteger da luz)
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Amiodarona, haloperidol, heparina, metoprolol, levofloxacino, aciclovir, anfotericina B, ampicilina, ampicilina+sulbactam, caspofungina, clorpromazina, dobutamina, fenitoína, nitroglicerina, imipenem, prometazina, cisatracúrio, pantoprazol, propofol.			

Folha: 349

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Nitroprussiato pode ↑ níveis de: anti-hipertensivos, agentes hipotensores, rituximabe. Níveis de nitroprussianto pode ser ↓ por: iombina, metilfenidato. Níveis/efeitos de nitroprussiato podem ser ↑ por: bloqueadores canais de cálcio, inibidores MAO, diazoxida, inibidores 5- fosfodiesterase (sildenafila). Sildenafil: potencialização dos efeitos hipotensores. Dobutamina: pode propiciar o ↑ do débito cardíaco e ↓ da pressão pulmonar.
Eventos adversos	Hipotensão exagerada, desconforto torácico, náusea, vômito, tremores, inquietação, fraqueza, sudorese, alucinações, cefaleia, desorientação, excessiva resposta hipotensora, contratura muscular, comportamento psicótico, acidose lática, náusea, vômito, sudorese, dor abdominal, cefaleia, vertigem, palpitação, desconforto retroesternal.
Observações	Usar equipo fotossensível. Restrição hídrica: diluição 1 mg/mL. Monitorar PA e pulso. Recomenda-se o controle sérico de tiocianato com o uso > de 72 h, com dose superior a 3 mcg/kg/min pelo risco de toxicidade. Monitorar sintomas de intoxicação por tiocianeto: psicose, visão borrada, confusão, cansaço, nistagmo, convulsão, metahemoglobinemia. Por cianeto: acidose metabólica, hiperoxemia venosa (sangue venoso brilhante), falta de ar, confusão mental, parada cardiorespiratória e morte.

NORADRENALINA, BITARTATRATO (NOREPINEFRINA)		
Classe farmacológica	Vasocontritor	
Apresentação	Solução injetável 2mg/mL, ampola com 4 mL	
Dose Usual	Adultos e adolescentes: 0,5 - 30 mcg/min, titulada até obter PA desejada. Dose terapêutica usual: 0,01 - 3,3 mcg/Kg/min Crianças: dose inicial: 0,05 - 0,1 mcg/Kg/min, aumentando SN (máx: 1 - 2 mcg/Kg/min)	
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.	
Vias de administração	**IM**	Não

Folha: 350

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	16mg em 250mL
			Diluente:	SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	8h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Aminofilina, bicarbonato de sódio, insulina, tiopental, ampicilina, atropina, cefazolina, furosemida, oxacilina, cefalotina, diazepam, estreptomicina, fenitoína, fenobarbital, insulina regular, oxacilina, oxitocina, pentobarbital, ringer lactato, soro fisiológico.			
Interações medicamentosas	Imipramina, metildopa, furazolidona: ↑ efeito hipertensivo. ↑ efeito da noradrenalina: antiácidos, beta-bloqueadores, canabinóides, inibidores da anidrase carbônica, anestésicos inalatórios, inibidores da MAO, inibidores da recaptação serotonia/ epinefrina, antidepressivos tricíclicos. ↓ efeito da noradrenalina: espirolactona. Noradrenalina pode ↑ níveis/efeitos de: simpaticomiméticos. Anestésicos inalatórios, beta-adrenérgicos, digitálicos: podem aumentar o risco de hipertensão, hiperpirexia e arritmias ventriculares graves.			
Eventos adversos	Bradicardia, cefaléia, isquemia periférica, ansiedade, dispneia, Arritmia cardíaca, palpitação, bradicardia, taquicardia, dor no peito, palidez, ansiedade, cafaleia, vômitos, contração uterina, bradicardia reflexa (bloqueável com atropina), necrose intersticial (se extravasamento), isquemia das artérias renal e mesentérica, fotofobia, diaforese.			

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Observações	A solução é quimicamente mais estável em SG 5%. Vesicante – dar preferência para acesso central. Monitorar PA. Não administrar se a solução mudar de coloração. Administrar em veia calibrosa (preferencialmente em acesso central).

OMEPRAZOL				
Classe farmacológica	Inibidor da bomba de próton			
Apresentação	Pó para solução injetável de 40mg			
Dose Usual	20 - 40 mg EV,1 ou 2x/dia Dose máx.: 270mg/dia.			
Reconstituição	Sim. 40mg em diluente próprio.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	40mg em 10mL de diluente próprio
			Diluente:	Diluente próprio.
			Tempo de infusão:	3 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	40mg/100mL de diluente
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	20-30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	4h
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	12h
			R:	Não se aplica

Folha: 352

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Midazolam, vancomicina.
Interações medicamentosas	Atazanavir, carvedilol, cetaconazol, ciclosporina, clopidogrel, clozapina, dasatinib, delavirdina, erlotinib, indinavir, itraconazol, metotrexato, micofenolato, nelfinavir, posaconazol, suplementos de ferro, tacrolimo, voriconazol, ampicilina.
Eventos adversos	Náusea, vômito, diarreia, cólica abdominal, parestesia, constipação, tontura, cefaleia, fraqueza, apatia, boca seca, sonolência, insônia, ansiedade, exantema, rash, leucopenia, hiponatremia, neutropenia, trombocitopenia, anemia, leucocitose, taquicardia, palpitação, bradicardia, palpitação, nefrite instersticial, pele seca, hipoglicemia, atrofia da língua, ↑ transaminases, dispneia, tosse e epistaxe, hematúria, piúria, proteinúria, tremores musculares, artralgia, parestesia, dor nas costas e dor torácica, alterações gastrintes- tinais, sonolência, tontura, cefaleia, hipotensão, hipertensão, taquicardia.
Observações	Não reconstituir a solução com outros medicamentos. O diluente do omeprazol não deve ser utilizado para diluir outros medicamentos. Cautela em pacientes com hipocalemia, dietas restritas em sódio e alcalose respiratória. A segurança e eficácia não está estabelecida em crianças menores de 2 anos. Usar com cautela em pacientes com insuficiência hepática e renal. O uso prolongado de inibidores de bomba de prótons pode aumentar o risco de diarreia associada à *Clostridium difficile.*

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

<table>
<tr><th colspan="5">ONDANSETRONA, CLORIDRATO</th></tr>
<tr><td>Classe farmacológica</td><td colspan="4">Antiemético</td></tr>
<tr><td>Apresentação</td><td colspan="4">Solução injetável 2mg/mL, ampola com 2 mL e 4 mL</td></tr>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Prevenção da Náusea e Vômito antes da quimioterapia: Adultos: 0,15 mg/kg 3x/dia, 30 min antes ou 0,45 mg/kg 1x/dia, ou 8 - 10 mg 1 - 2 x/dia, ou 24 ou 32 mg 1x/dia
Crianças de 6 m a 18 anos: 0,15 mg/kg/dose, 30 min antes da quimiotera- pia, 4 e 8 h após 1ª dose ou 0,45 mg/kg 1x/dia.

Prevenção da Náusea e Vômito pós-operatório:
Adulto: 4 mg 30 min antes do término da anestesia Crianças: ≤ 40kg: 0,1mg/kg dose única; > 40kg: 4mg dose única</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Não. Solução pronta para uso.</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>2-5 min</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>0,08mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>15 min</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluído</td><td>TA:</td><td>12h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Aciclovir, alopurinol, aminofilina, ampicilina, anfotericina B, ampicilina+sulbactam, bicarbonato de sódio, cefepime, dexametasona, droperidol, furosemida, fluoruracila, ganciclovir, meropenem, lorazepam, metilprednisolona succinato, micafungina, tiopental.</td></tr>
</table>

Folha: 354

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Diminuição do efeito da ondansetrona: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifamicina, erva-de-são-joão. Diminuição dos efeitos de: pimozida. Ciclofosfamida: uso concomitante pode resultar decréscimo da exposição sistêmica a ciclofosfamida. Tramadol: pode ↓ o efeito analgésico do tramadol. Outras interações registradas com: amiodarona, ciclofosfamida, droperidol, enflurano, halotano, pimozida, sotalol, tioridazina, quetiapina, nilotinibe, ciprofloxacino.
Eventos adversos	Constipação, diarreia, cefaleia, dor abdominal, mal-estar, fadiga, tontura, ansiedade, sonolência, hipotensão, taquicardia, bradicardia, angina, disritmia, síncope, hipotensão, palpitação, mialgia, retenção urinária, parestesia, ↑ transitória das transaminases, broncoespasmo, laringoespasmo, anafilaxia, dificuldade respiratória, rash, reação no local da injeção, urticária, febre, obnubilação, convulsão, calafrio, tremor, xerostomia, perda de peso, hipocalemia (rara), visão borrada, soluço, dor musculoesquelética, ataxia, reações de hipersensibilidade.
Observações	Pacientes com insuficiência hepática, a dose não deve exceder 8 mg. A ondansetrona contém o mesmo núcleo imidazol da cimetidina e omeprazol. Pacientes recebendo ondansetrona concomitante com teofilina, fenitoína ou varfarina devem ser acompanhados.

PANCURÔNIO, BROMETO				
Classe farmacológica	Bloqueador neuromuscular			
Apresentação	Solução injetável 2mg/mL, ampola com 2 mL			
Dose Usual	**Adultos:** Bolus: 0,15 mg/Kg/dose cada 20 - 40min SN Infusão contínua: 0,4 - 0,6 mcg/Kg/min **Criança:** Bolus: 0,05 - 0,15 mg/Kg/dose cada 20 - 40 min SN Infusão contínua: 0,5 - 1,6 mg/Kg/min			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	Bolus rápido

Folha: 355

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,5-1mg/mL
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**	**TA:**	Não se aplica	
		R:	Não se aplica	
	Diluido	**TA:**	24h	
		R:	Não se aplica	
Incompatibilidade	Diazepam, pantoprazol, tiopental.			
Interações medicamentosas	Potencializa: Isoflurano, halotano, óxido nitroso, aminoglicosídeos, polimixina, clindamicina, vancomicina, magnésio, lidocaína, furosemida, manitol, tiazidas, anfotericina B, anestésicos locais, betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, cetamina, lítio, succinilcolina, ciclosporina. Antagoniza: Cálcio, carbamazepina, fenitoína, esteróides, teofilina, neostigmina, cafeína, azatioprina.			
Eventos adversos	Hipertensão, hipotensão, frequência cardíaca em 15%, arritmias, náusea, vômito, rash, broncoespasmo, prurido, soluço, fraqueza muscular, anafilaxia.			
Observações	Não misturar com soluções alcalinas. Antídoto: edrofônio/ neostigmina / Uso prolongado aumenta o potencial de reações adversas. Início de ação rápida: 30 a 45 segundos. Duração: 30 a 90 minutos.			

PENTOXIFILINA				
Classe farmacológica	Redutor de viscosidade do sangue			
Apresentação	Solução injetável 20mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	**Adulto:** 200 - 300 mg 2x dia.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	
			Diluente:	
			Tempo de infusão:	
	EV		**Diluição padrão:**	100mg/250-500mL de diluente

Folha: 356

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	infusão	Sim	**Diluente:**	SF, SG

Folha: 357

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

			Tempo de infusão:	120 a 180 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	24h
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Anti-hipertensivos, abciximab, anagrelida, AAS, cilostazol, clopidogrel, diclofenaco, dipiridamol, dipirona, etodolaco, droperidol, enoxaparina, heparina, ciprofloxacino, ibuprofeno, cetoprofeno, cetorolaco, ácido mefenâmico, meloxicam, naproxeno, nimesulida, fenilbutazona, piroxicam, sulindaco, tenoxicam, teofilina, tirofibana, ticlopidina, varfarina.			
Eventos adversos	Rubor facial, náusea, vômito, diarreia, prurido e urticária.			
Observações	-			

PROMETAZINA				
Classe farmacológica	Antihistamínico			
Apresentação	Solução injetável 25mg/mL, ampola com 2ml			
Dose Usual	**Adultos:** Antiemético: 12,5 – 25 mg a cada 4 - 6 SN Anti-histamínico: 25mg IM ou EV, podendo- se repetir em 2h Sedativo: 12,5 - 50 mg/dose IM ou EV **Crianças ≥ 2 anos**: Antiemético: 0,25 - 1 mg/Kg/dose IM ou EV de 4 - 6 x/dia SN Dose máxima: 25 mg/dose Sedativo: 0,5 - 1 mg/Kg/dose IM ou EV a cada 6h. Dose máxima: 50 mg/dose			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	3 min

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	25mg/20ml
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	10-15min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	24h (proteger da luz)
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Fármacos com pH alcalino. Gluconato de cálcio, cetorolaco, aminofilina, barbitúricos, benzilpenicilina, furosemida, cloranfenicol, heparina, hidrocortisona, morfina			
Interações medicamentosas	Potencializa efeitos sedativos: opióides, fenotiazinas, barbitúricos, álcool, antidepressivos, anticonvulsivantes, outros depressores do SNC. Alterações eletrocardiográficas: fluoroquinolonas, octreotida. Tramadol: ↑ risco de convulsão.			
Eventos adversos	Taquicardia, bradicardia, arritmia, hipotensão ortostática, hipertensão, palpitação, agitação paradoxal, sonolência, alucinações, reação extrapiramidal, incoordenação motora, convulsão, tremores, distonia, cansaço, náusea, vômito, diarreia, obstipação, xerostomia, hepatite, icterícia colestática, artralgia, mialgia, trombocitopenia, leucopenia, anemia hemolítica, visão borrada, diplopia, agranulocitose, retenção urinária, depressão respiratória e apneia (severa em crianças), fotossensibilidade, rash, eritema, eczema, angioedema, anafilaxia			
Observações	Infusão não pode exceder 25mg/min Proteger da luz. Uso EV é arriscado (hipotensão). Preferir a via IM e passar para VO assim que possível. Se extravasar pode provocar necrose. Administrar em veia calibrosa, nunca em mão e pulso. Não fazer via subcutânea. Contraindicada em pacientes < 2 anos, glaucoma, depressão do SNC, obstrução gastrointestinal ou urinária. Crianças desidratadas têm risco maior de desenvolver reações distônicas			

Folha: 359

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

PROTAMINA				
Classe farmacológica	Antídoto de heparina			
Apresentação	Solução injetável de 10mg/ml, ampola com 5mL			
Dose Usual	**Adultos**: Neutralização da ação anticoagulante da heparina: 1mL de protamina neutraliza 1.000 UI de heparina. A dose necessária depende da quantidade de heparina circulante no sangue e do período de tempo transcorrido desde a sua administração. Caso a concentração de heparina não seja determinada, recomenda-se não administrar mais de 1mL de protamina. Como regra geral para o tratamento das hemorragias originadas pela heparina, pode-se utilizar uma dose de protamina que neutralize 50% da última dose de heparina. Dose máx.: 50mg.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1ml/3min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	50mg/25-50mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	10-20min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Ampicilina, cefazolina, cefoxitina, cefotaxima, cefalotina, cefuroxima, meticilina, naficilina, oxacilina, penicilina G, piperacilina.			
Interações medicamentosas	Insulina NPH: tem um risco aumentado de desenvolvimento de reações adversas a protamina, incluindo hipotensão e anafilaxia.			
Eventos adversos	Hipotensão, bradicardia, ruborização transitória e sensação de calor, dispneia, náusea, vômito, cansaço, anafilaxia, colapso circulatório, derrame capilar, hipertensão pulmonar aguda, dor nas costas, reação de hipersensibilidade (urticária, angioedema, anafilaxia), edema pulmonar não			

Folha: 360

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	cardiogênico, sangramento por efeito rebote de heparina ou superdosagem de protamina.
Observações	Cada 10 mg (1 ml) de protamina neutraliza 1.000 unidades de heparina. Em pacientes alérgicos a peixes e em uso de insulina NPH pode ocorrer reação de hipersensibilidade (incluindo anafilaxia fatal). Cada 1mL equivale a 1.000UI de protamina.

ROCURÔNIO, BROMETO				
Classe farmacológica	Bloqueador neuromuscular			
Apresentação	Solução injetácel 10mg/mL, ampola com 5mL			
Dose Usual	**Adultos:** Bolus: 0,6 - 1,2 mg/Kg/dose Infusão contínua: 10 – 12 mcg/Kg/min **Crianças:** Bolus: 0,6 mg/Kg/dose Infusão contínua: 10 – 12 mcg/Kg/min Lactentes: Bolus: 0,5 mg/Kg/dose cada 30min			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	5-10 seg
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1mg/mL
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
			TA:	24h

Folha: 361

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

	Diluído	**R:**	Não se aplica

Folha: 362

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	Amoxicilina, anfotericina B e complexo lipídico, azatioprina, cefazolina, dexametasona, diazepam, famotidina, fenitoína, fosfato de potássio, furosemida, gemtuzumab, hidrocortisona, insulina, metilprednisolona succinato, micafungina, piperacilina+tazobactam, sulfametoxazol+trimetoprima, prednisolona, tiopental, vancomicina.
Interações medicamentosas	Potencializa: Isoflurano, halotano, óxido nitroso, aminoglicosídeos, polimixina, clindamicina, vancomicina, magnésio, antiarrítmicos (lidocaína), diuréticos (furosemida, manitol, tiazidas), anfotericina B, anestésicos locais, betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, cetamina, lítio, succinilcolina, ciclosporina. Antagoniza: Cálcio, carbamazepina, fenitoína, esteróides, teofilina, neostigmina, cafeína, azatioprina.
Eventos adversos	Medicamentos controlados e anestésicos hipertensão, hipotensão, taquicardia, arritmia, náusea, vômito, erupção cutânea, soluços, broncoespasmo.
Observações	Não misturar com soluções alcalinas. Antídoto: edrofônio/ neostigmina Uso prolongado aumenta o potencial de reações adversas. As condições clínicas podem afetar a efetividade do medicamento (consultar literatura especializada). Início de ação rápida: 30 a 45 segundos. Duração: 30 a 90 minutos.

SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO III	
Classe farmacológica	Antianêmico
Apresentação	Solução injetável 20mg/mL, ampola com 5ml
Dose Usual	**Adultos:** 10-72,5mL de Sacarato de hidróxido férrico III. Dose varia conforme dosagem de hemoglobina e peso. Dose máx. para adultos: 7mg Fe/kg de peso, não excedendo 500mg/500mL infundidos em 3,5h. **Crianças:** 0,15mL/kg de peso 1 a 3 vezes por semana. Dose máx. para crianças: 0,35mL/kg infundido em 3,5h.

Folha: 363

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.

Folha: 364

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	1ml/min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1ml para 20mL de diluente
			Diluente:	SF
			Tempo de infusão:	Concentração/tempo: 100mg/15min 200mg/30min 300mg/1h30min 400mg/2h30min 500mg/3h30min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Não administrar outros medicamentos na mesma diluição.			
Eventos adversos	Deturpação temporária do paladar, hipotensão, febre e calafrios, reações no local da injeção e náusea.			
Observações	-			

SALBUTAMOL		
Classe farmacológica	Broncodilatador	
Apresentação	Solução injetável 0,5mg/mL, ampola 1mL	
Dose Usual	4 – 8 mcg/kg de peso corporal, repetidos a cada 4h SN	
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.	
Vias de administração	**IM**	Sim
	SC	Sim

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	0,5mL/5mL de diluente
			Diluente:	AD
			Tempo de infusão:	Lento
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-			
Interações medicamentosas	Injetável não deve ser utilizado juntamente com medicamentos beta-bloqueadores não seletivos, como o propranolol; Injetável não é contraindicado em pacientes em tratamento com inibidores da monoaminoxidase (IMAOS).			
Eventos adversos	Tremor; aumento da frequência dos batimentos do coração; palpitações; dor de cabeça; câimbras musculares; isquemia miocárdica; edema pulmonar; coceira; inchaço; falta de ar; podendo ocorrer diminuição da pressão sanguínea e desmaio; acidose láctica; hiperatividade; enjoos e vômitos.			
Observações	Em alguns casos de superdose pode ser necessário o uso de um agente beta-bloqueador cardiosseletivo como antídoto.			

SULFATO DE MAGNÉSIO	
Classe farmacológica	Eletrólito
Apresentação	Solução injetável 50%, ou seja, 500mg/mL, ampola 10mL
Dose Usual	Hipomagnesemia: Adultos Leve: 1 g cada 6 h IM; Grave: 5 g EV em 1000 mL de SF ou SG 5% por 3 h; ou 250 mg/Kg, IM em intervalos de 4h
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.

Folha: 366

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Vias de administração	**IM**	Sim		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	Lento
	EV infusão em BI	Não	**Diluição padrão:**	4 amp. Em 500mL de diluente
			Diluente:	SF, SG, SRL
			Tempo de infusão:	300 mL/h por 20 min, seguido de infusão contínua de 24 - 48 mL/h por 24 h
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Anfotericina B, bicarbonato de sódio, ciclosporina, cefepime, emulsão lipídica 10%, procaína, polimixina B.			
Interações medicamentosas	Levometadil, levomepromazina, verapamil, anlodipino, nifedipino, calcitriol, poliestirenossulfonato de cálcio, hidroxizina, cetorolaco, micofenolato de mofetila, suplementos de fosfato, ciprofloxacino, levofloxacino, zolpidem, droperidol.			
Eventos adversos	Sonolência, sudorese, hipotensão, rubor, anúria, alterações cardíacas, diminuição dos reflexos neuromusculares, hipocalcemia, diarreia.			
Observações	Pode ser usado como adjuvante na NPT. Controle rigoroso débito urinário de hora em hora.			

SUXAMETÔNIO, CLORETO	
Classe farmacológica	Bloqueador neuromuscular
Apresentação	Pó para solução injetável 100mg e 500mg

Folha: 367

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

<table>
<tr><td>Dose Usual</td><td colspan="4">Adultos:
Intubação traqueal: [0,3 – 1,1 mg/Kg]
Infusão contínua: 0,5 a 10 mL/min
IM: 3 – 4 mg/Kg. (Dose máxima: 150 mg)
Crianças:
Intubação traqueal: uso EV Pequenas: 2 mg/Kg Maiores e adolescentes: 1 mg/Kg
IM: 3 – 4 mg/Kg. (Dose máxima 150 mg)</td></tr>
<tr><td>Reconstituição</td><td colspan="4">Sim. Em 9mL de AD</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Vias de administração</td><td>IM</td><td colspan="3">Sim</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV direto</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>10mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>AD.</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>10-30 seg.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">EV infusão</td><td rowspan="3">Sim</td><td>Diluição padrão:</td><td>1-2mg/mL</td></tr>
<tr><td>Diluente:</td><td>SF, SG, SRL</td></tr>
<tr><td>Tempo de infusão:</td><td>ACM</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Estabilidade</td><td colspan="2" rowspan="2">Reconstituído</td><td>TA:</td><td>24h</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Diluido</td><td>TA:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>R:</td><td>Não se aplica</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidade</td><td colspan="4">Anfotericina B, ampicilina, ampicilina+sulbactam, bic. de sódio, azatioprina, dantroleno, diazepam, diazóxido, fenobarbital, fenitoína, ganciclovir, gemtuzumabe, haloperidol, hidralazina, indometacina, insulina R, oxacilina, benzilpenicilina potássica, sulfametoxazol+trimetoprima, tiopental.</td></tr>
</table>

Folha: 368

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Potencializam os efeitos do suxametônio: certos inibidores da acetilcolinesterase, aminoglicosídeos, bloqueadores betaadrenérgicos, lidocaína, ciclofosfamida, lítio, sais de magnésio, isoflurano, terbutalina, lincosamidas, polimixina B, tetracicilinas, vancomicina. Podem ↑ os efeitos de: analgésicos opióides, glicosídeos cardíacos
Eventos adversos	Bradicardia, assistolia (rara), arritmias ventriculares malignas (rara), parada cardíaca secundária à rabdomiólise aguda com hiperpotassemia, risco de hipertermia maligna, hipertensão, taquicardia, eritrodermia, broncoespasmo, salivação, aumento da pressão intracraniana e intraocular, risco de reação grave em miopatia não diagnosticada, rubor, rash, hipercalemia, mioglobinemia, salivação, mialgia, mioglobinúria, apneia, depressão respiratória.
Observações	Contra-indicado: miopatias com CPK ↑, K ↑, lesão ocular aberta, história de hipertermia maligna. Início de ação (IV): 30 a 60 segundos. Duração da ação: 3 a 10 minutos. Início da ação (IM): 3 minutos. Duração da ação: 5 a 20 minutos. Pode produzir rigidez ao invés de relaxamento como os nãodespolarizantes.

VERAPAMIL, CLORIDRATO	
Classe farmacológica	Bloqueador de Canal de Cálcio
Apresentação	Solução injetável 2,5mg/mL, ampola com 2mL
Dose Usual	**Adultos:** Dose inicial: 5 a 10 mg (0,075 a 0,15 mg/kg de peso) Dose de repetição: 10 mg (0,15 mg/kg de peso). **Crianças:** Dose inicial: 0 a 1 ano: 0,1 a 0,2 mg/kg peso (dose usual de 0,75 a 2 mg) 1 a 15 anos: 0,1 a 0,3 mg/kg de peso (dose usual de 2 a 5 mg) Dose máx.: 5 mg. Dose de repetição: 0 a 1 ano: 0,1 a 0,2 mg/kg peso (dose usual de 0,75 a 2 mg) 1 a 15 anos: 0,1 a 0,3 mg/kg de peso (dose usual de 2 a 5 mg). Não exceder 10 mg em uma única dose.

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.

Folha: 370

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	2 min
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	0,1mg/mL de diluente
			Diluente:	SG
			Tempo de infusão:	30 min
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	SRL, Ibumina, anfotericina B, cloridrato de hidralazina ou trimetoprima e sulfametoxazol			
Interações medicamentosas	Aumentam sua toxicidade: antifúngicos azólicos, cimetidina. Diminuem seu efeito: barbitúricos, rifampicina. Têm sua toxicidade aumentada: amiodarona, fentanil, AAS, digitálicos, bbloqueadores, carbamazepina, ciclosporina, midazolam, teofilinas. Incompatível EV com bicarbonato, pentobarbital			
Eventos adversos	iperplasia gengival, bradicardia, bloqueio AV, ICC, hipotensão, tonturas, cefaléia, rash, constipação, angina, broncoespasmo, sintomas psicóticos.			
Observações	-			

VITAMINA B12				
Classe farmacológica	Vitaminas			
Apresentação	Solução injetável 2,5mg/mL, ampola com 2mL			
Dose Usual	Neonatos: IM ou SC 0,2 mcg/Kg por 2 dias, seguido por 1000 mcg/dia por 2 - 7 dias. Manutenção: 100 mcg/mês Crianças: 30 - 50 mcg/dia, IM ou SC, por 2 ou mais semanas (até atingir dose total de 1000 mcg). Manutenção: 100 mcg/mês. Adultos: 100 mcg/dia, IM ou SC, por 7 dias, seguidos de 100 mcg/semana, IM ou SC. Após, 100 mcg/mês, até a condição ser corrigida.			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Sim		
	Reconstituído		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica

Folha: 371

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Estabilidade	**Diluído**	**TA:**	Não se aplica
		R:	Não se aplica
Incompatibilidade	-		
Interações medicamentosas	Ácido p-aminossalicílico, colchicina, cloranfenicol, ácido ascórbico, omeprazol.		
Eventos adversos	-		
Observações	Proteger da luz		

VITAMINAS DO COMPLEXO B				
Classe farmacológica	Vitaminas			
Apresentação	Solução injetável, ampola com 2mL Tiamina – 10mg Riboflavina – 2,5mg Nicotinamida – 30mg D-Pantenol – 6mg Piridoxina – 2,5mg			
Dose Usual	**Adultos:** 1 - 2 ampolas/dia ou em dias alternados			
Reconstituição	Não. Solução pronta para uso.			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Não	**Diluição padrão:**	
			Diluente:	
			Tempo de infusão:	
	EV infusão	Sim	**Diluição padrão:**	1 amp em 100mL de diluente
			Diluente:	SF, SG
			Tempo de infusão:	ACM
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica

Folha: 372

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Incompatibilidade	-

Folha: 373

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Interações medicamentosas	Barbitúricos, levodopa (isolada).
Eventos adversos	Em pacientes com reconhecida hipersensibilidade à tiamina podem ocorrer: fenômenos alérgicos caracterizados por eritema, prurido náusea, vômito e reação anafilática (raro).
Observações	Infusão acima de 1 hora: proteger da luz e usar equipo fotossensível. Pode causar dor e irritação no local da administração.

SUGAMADEX SÓDICO				
Classe farmacológica	Agente reversor de bloqueio neuromuscular			
Apresentação	Solução injetável 100mg/mL, frasco ampola com 2mL			
Dose Usual	2 a 4 mg/kg (dose acima desse valor, ACM)			
Reconstituição	Não se aplica (solução pronta para uso)			
Vias de administração	**IM**	Não		
	EV direto	Sim	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	10 seg
	EV infusão	Não	**Diluição padrão:**	-
			Diluente:	-
			Tempo de infusão:	-
Estabilidade	**Reconstituído**		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
	Diluido		**TA:**	Não se aplica
			R:	Não se aplica
Incompatibilidade	Verapamil, ondansetrona.			
Interações medicamentosas	Toremifeno, ácido fusídico			
Eventos adversos	Boca seca, gosto metálico, náusea, vômito, eritema, taquicardia, bradicardia, hipotensão ou hipertensão.			

Folha: 374

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

Observação	O medicamento pode ser diluído para pacientes pediátricos na concentração de 25 mg/mL. Uso imediato preferencialmente. A estabilidade da solução pode ser de 48 h quando diluído em condições assépticas controladas e validadas. **Não é recomendada a reutilização do rocurônio nas primeiras 24 h após o uso de sugamadex.**

6. REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 19 maio 1998.

2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 6, de 4 de fevereiro de 2014. Dispõe sobre a atualização do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 05 fev. 2014.

3. MEDSCAPE. *Medscape Drug Reference* [Internet]. New York: WebMD LLC; [citado em 2026 maio 20]. Disponível em: <https://reference.medscape.com/drugs>

4. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Consulta a medicamentos e bulas [Internet]. Brasília: ANVISA; [citado em 2026 maio 20]. Disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/>

7. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
1	12/05/2026	Elaboração do Manual

Elaboração:

Celina de Jesus Guimarães (Farmacêutica/CRF-AM: 1749) **e equipe técnica.**

Assinatura: Celina Guimarães

Carla Natercia Cabral de Oliveira Farmacêutica/CRF-AM:1502

Assinatura: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA:52047024234 Assinado de forma digital por CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA:52047024234 Dados: 2026.06.11 11:01:18 -04'00'

Cecília Oliveira de Carvalho Farmacêutica/CRF-AM: 1776

Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente CECILIA OLIVEIRA DE CARVALHO Data: 09/06/2026 10:33:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Kacio Felipe Silva Souza Farmacêutico/CRF-AM: 2639

Assinatura: KACIO FELIPE SILVA SOUZA:52666042200 Assinado de forma digital por KACIO FELIPE SILVA SOUZA:52666042200 Dados: 2026.06.11 10:56:54 -04'00'

Data: 12/05/2026

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**

Aprovação: **Hilka Flávia Barra do Espirito Santo Alves Pereira** – Diretoria Técnica Assinatura: HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253 Assinado de forma digital por HILKA FLAVIA BARRA DO ESPIRITO SANTO ALVES PEREIRA:31006337253	Data:

Assinado digitalmente por: CARLA NATERCIA CABRAL DE OLIVEIRA em 19/06/2026 às 11:55:13 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/AB83.126B.4312.D472/109FC5EA
Código verificador: **AB83.126B.4312.D472** CRC: **109FC5EA**